

中医组方

一学就会

北京中医药大学 黄 斌 主编

教您如何开出适合的中药方

深奥难懂的中医药教材全面解读



吉林科学技术出版社



中医入门系列

一学就会

中医方组

黄斌 主编

吉林科学技术出版社

图书在版编目（CIP）数据

中医组方一学就会 / 黄斌主编. —长春：吉林科学技术出版社，2009.6

ISBN 978-7-5384-4216-8

I. 中… II. 黄… III. 方剂学—研究
IV. R289.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第075281号

中医入门系列

中医组方一学就会

- | | |
|-----------|---|
| ◎主编 | 黄 斌 |
| ◎编委 | 杨 恒 项柏冬 |
| ◎特约编辑 | 毕 锴 |
| ◎责任编辑 | 李 梁 李 征 |
| ◎封面设计 | 涂图工作室 张 虎 |
| ◎技术插图 | 张 虎 李 雷 李小明
崔 晶 夏 冰 赵 冲 |
| ◎出版发行 | 吉林科学技术出版社 |
| ◎社址 | 长春市人民大街4646号 |
| ◎邮编 | 130021 |
| ◎发行部电话/传真 | 0431-85677817 85635177 85651759
85600611 85670016 85651628 |
| ◎编辑部电话 | 0431-85619083 |
| ◎网址 | www.jlstp.com |
| ◎实名 | 吉林科学技术出版社 |
| ◎印刷 | 长春新华印刷集团有限公司 |

规格：720mm×990mm 16开 11.5印张

字数：200千字

版次：2010年5月第1版 2010年5月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5384-4216-8

定价：19.90 元

如有印装质量问题 可寄出版社调换



第一章 中药方剂基础知识

中药方剂学发展简史

中药方剂与治法

方剂的分类

方剂的组成与变化

剂型与服药方法

第二章 呼吸系统疾病

感冒、上呼吸道感染(外感风寒表实证)

麻黄汤

流行性感、各种体虚长期发热(外感风寒表虚证)

桂枝汤

感冒、流行性感、多种急性传染性
疾病初起阶段(表热证)

银翘散

传染病及流行性疾病引起的高热(阳明气热证)

白虎汤

肺炎(邪热壅肺证)

麻杏石甘汤

支气管炎(痰饮证)

苓桂术甘汤

急慢性支气管炎合并感冒、哮喘、肺
气肿(表寒内饮证)

小青龙汤

咳嗽(外感咳嗽)

止嗽散

哮喘(哮喘)

定喘汤

各种类型肺炎及肺癌(咳血)

咳血方

大叶性肺炎、肺部肿瘤(肺癰)

苇茎汤

第三章 消化系统疾病

胃肠型感冒、急性胃肠炎、中毒性消化不良、病毒性肝炎(表湿证)

藿香正气散

疟疾、急性病毒性肝炎(邪在少阳证)

小柴胡汤

肝炎、急性胰腺炎(少阳阳明证)

大柴胡汤

急慢性肠炎、慢性胃炎、胃十二指肠溃疡(脾胃虚寒证)

理中汤

慢性肝炎、慢性胆囊炎、慢性肠炎(肝脾气滞证)

四逆散

肝炎、胆囊炎(肝胆实热证)

龙胆泻肝汤

急慢性胃肠炎、急慢性肝炎(湿困脾胃证)

平胃散

慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡(痰湿证)

二陈汤

急慢性胃炎、妊娠恶阻(痰热内扰证)

温胆汤

疝气、肠绞痛、生殖器官及附件炎症(寒症)

天台乌药散

腹痛腹泻、食欲不振、呕吐(食滞胃肠证)

保和丸

急性胃肠炎、痢疾、肠伤寒(湿热食积证)

枳实导滞丸

肠梗阻(湿热内结证)

调胃承气汤

急性肠炎、痢疾、肠伤寒(胃肠湿热证)

葛根芩连汤

肠伤寒、急性胃肠炎、霍乱(湿热蕴中证)

连朴饮

胃肠道出血证、精神分裂症(下焦蓄血证)

桃核承气汤

慢性消化不良、小儿营养不良、慢性胃炎(脾虚食滞证)

健脾丸

各种急慢性胃肠炎、慢性胆囊炎、慢性肝炎(脾虚食滞证)

半夏泻心汤

神经性呕吐、胃扩张(呕逆)

旋覆代赭汤

急性肠炎、神经性腹泻(痛泻)

痛泻要方

腹泻(五更泄)

四神丸

便血(肠风下血)

槐花散

便秘(肠燥便秘证)

麻子仁丸(脾约丸)

黄疸性肝炎(黄疸)

茵陈蒿汤

肠道蛔虫病、胆道蛔虫病（蛔厥证）

乌梅丸

急性肠炎、痢疾、肠伤寒（肠道湿热证）

葛根黄芩黄连汤（葛根芩连汤）

第四章 循环系统疾病

败血症、脓毒血症（火毒壅盛证）

黄连解毒汤

急性白血病、DIC（血分热盛证）/108

犀角地黄汤

渗出性胸膜炎、肝硬化腹水、肾炎水肿（水饮证）

十枣汤

中风、中风后遗症（气虚血瘀证）

补阳还五汤

各种眩晕症、高血压病、神经衰弱症（风痰上扰证）

半夏白术天麻汤

高血压病、高血压脑病、脑血管意外（肝阳化风证）

天麻钩藤饮

心力衰竭、各类脑炎（少阴虚寒证）

四逆汤

风湿性心脏病、心力衰竭（气阴两虚证）

生脉散

冠心病、心律不齐、风湿性心脏病（心悸）

炙甘草汤

第五章 泌尿生殖系统疾病

急慢性肾炎（蓄水证）

五苓散

慢性肾炎、肾病综合征（阳虚水泛证）

真武汤

急性肾炎（少阳水饮证）

柴胡桂枝干姜汤

月经不调、不孕症（寒凝血瘀证）

温经汤

糖尿病、消渴、慢性肾炎（肝肾阴虚证）

六味地黄丸

膀胱炎、尿道炎、肾盂肾炎、前列腺炎（热淋证）

八正散

急性泌尿系统感染、尿路结石（尿血证）

小蓟饮子

尿频、小儿尿失禁（遗尿证）

缩泉丸

遗精、遗尿（肾虚遗精证）

金锁固精丸

慢性宫颈炎、慢性盆腔炎（湿浊带下证）

完带汤

第六章 其他疾病

荨麻疹、湿疹、过敏性皮炎(风疹)

消风散

癫痫、神经衰弱症(少阳痰热证)

柴胡加龙骨牡蛎汤

面神经麻痹(面瘫证)

牵正散

偏头痛(风邪上袭证)

川芎茶调散

流行性乙型脑炎、脑性疟疾(肝热动风证)

羚角钩藤汤

神经性呕吐、高血压头痛(厥阴虚寒证)

吴茱萸汤

各种疼痛、肋软骨炎、肋间神经痛(气滞血瘀证)

血府逐瘀汤

免疫功能低下、大病愈后(表虚证)

玉屏风散

慢性肠胃炎、慢性肝炎、贫血、营养不良(脾胃气虚证)

四君子汤

慢性肠炎、肠道功能紊乱、脏器下垂、流产(中气下陷证)

补中益气汤

贫血、神经衰弱、营养不良(气血两虚证)

归脾汤

贫血、大病初愈(血虚证)

四物汤

关节炎、系统性红斑狼疮、痛风(风湿正虚证)

独活寄生汤

神经衰弱症、忧郁症、更年期综合征(虚烦不眠证)

酸枣仁汤

附录 古方药量考证

第一章

中药方剂 基础知识

中医药是中华民族的瑰宝，也是我国优秀传统文化的重要组成部分。中药方剂作为中医药理论的重要组成部分，是临床治疗疾病的重要手段。本章主要介绍中药方剂的基础知识，包括方剂的概念、分类、组成、配伍、煎服法等。

一、方剂的概念
方剂是指根据中医理论，将多种中药按照一定的配伍原则组合而成，用于治疗疾病的药物制剂。方剂是中医药理论的重要组成部分，也是临床治疗疾病的重要手段。



中药方剂学发展简史

中药方剂学的发展已经有2000多年的历史了。现存的方书，根据《全国中基图书联合目录》记载，仅从晋、唐至今已多达1950余种，至于与方剂有关的医籍就更多。这些书籍的相继问世，反映出方剂学这门学科不断发展的轨迹。

中药方剂是古时人们在长期生活和生产实践中，经过世代代、日积月累的口尝身受，逐步积累的药物知识之大成。随着有意识地利用药物，自然涉及到药物的选择、配合和调剂，因而逐渐产生了方剂。早期的方剂，多数是单方，或仅由二三味药组成，十分简单。将两种或两种以上的药物组成复方加以利用，可以增强作用、提高疗效，并减轻不良反应和毒性，无疑是古代医药学发展过程中的巨大进步。两汉时期，方剂学有了较大的发展。其一是初步总结了治则和治法，并提出了对组方基本结构的要求，从而初步奠定了方剂学的理论基础；其二是形成了一批行之有效的著名方剂，为后世方剂的发展打下了坚实基础。东汉时以《神农本草经》为代表的本草学也积累了重要的药学成果，方剂的质量随之提高。汉末，由于疫

病肆虐，张仲景出于“拯夭救枉”之心，“勤求古训，博采众方”，并以《内经》理论为基础，结合自己的独到经验，完成了当时最高水平的临床巨著——《伤寒杂病论》。此书经晋代王叔和及宋代林亿等先后整理编辑为《伤寒论》和《金匱要略》，并得以广为流传。在历代医家的钻研和完善中，方剂学逐渐发展、成熟。近代以来，特别是新中国成立以后，方剂学更加迅速发展，并且对一大批古代的重要方书，如《肘后方》、《小品方》、《千金方》《外台秘要》、《太平惠民和剂局方》、《圣济总录》、《普济方》等，进行了校刊出版、影印或辑复，为古方和方剂学史的研究提供了极大的便利。重新编辑的古今医方、验方、方书辞典及其他方剂工具书亦大量涌现。随着近半个世纪以来中医药高等教育的不断发展，不同层次医药院校的使用的方剂教材、教学参考书，更是不断更新；同时，有关治则、治法及组方原理、配伍规律和复方效用的研究，既有文献的整理、临床的观察，又有大量现代实验研究。方剂理论研究更加深入，方剂应用范围更加广泛。中药制剂学的分化，中成药在生产工艺、剂型改进、药效、药理、毒理、质量标准和临床应用等方面，都取得了举世瞩目的成就；新的产品不断研制成功，剂型不断改进和更新，设备、技术和检测手段更加先进，



疗效可靠而安全的法定处方、协定处方不断增加。随着中医学的全面发展，方剂学的独特优势将会进一步得到发挥，并为人类的健康做出新的贡献。

中药方剂与治法

治法和方剂，都是中医学理、法、方、药体系的重要组成部分。临床辨证论治是一个由分析问题到解决问题的连续过程，只有辨证正确，治法的针对性才能明确和具体，根据治法遣药组方才能获得预期的疗效。因此，治法是联系辨证理论和遣药组方的纽带，也是学习和运用方剂不可缺少的基础。

治法，是在辨清证候，审明病因、病机之后，有针对性地采取的治疗方法。随着中医理论和临床实践的不断丰富和总结，治法也更加丰富，以适应各种病症的治疗需要。

中医学的治法内容，可以归纳为两个层次。首先，具有一定概括性的、针对某一类病机共性所确立的治法，称为治疗大法，如表证用汗法、寒证用温法、热证用清法、虚证用补法、实证用泻法等。其次是针对具体证候所确定的治疗方法，即具体治法。每一具体方剂

都体现着该方的具体治法。在临床运用中，只有精确地把握具体治法，才能保证具体病症治疗中有较强的针对性。

治法不但多层次，而且还多体系。这是源于临床辨证论治的多种体系，如脏腑辨证、六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证、经络辨证等。由于治法和病机的对应性，因此形成了相应的不同治法体系，如“宣肺止咳”“滋水涵木”等属于脏腑治法体系，“和解少阳”“泻下阳明热结”等属于六经治法体系，“清气分热”“清营凉血”等属于卫气营血治法体系，“宣上、畅中、渗下”及“三焦分消”等属于三焦治法体系。理解和运用时，必须紧密结合相关病机和辨证体系的基本理论，才能对具体治法以及遣药组方的把握达到切中病机、针对性强的要求。

方剂是中医临床治疗疾病的主要手段，是在辨证、立法的基础上选药配伍而形成的。只有首先理解方剂与治法的关系，才能正确地遣药组方或运用成方。

从中医学形成和发展的过程来看，治法是在长期临床积累了方药运用经验的基础上，在对人体生理病理认识的不断丰富、完善过程中，逐步总结而成的，是晚于方药形成的一种理论。但当治法已由经验上升为理论之后，就反过来成为遣药组方和运用成方的指导原则。如辨证与治法不符，组方与治法脱节，必然导致治疗无效，甚至使病情恶



化。由此可见，在临床辨证论治的过程中，辨证的目的在于确定病机，论治的关键在于确立治法，治法是针对病机产生的，而方剂必须相应地体现治法。治法是指导遣药组方的原则，方剂是体现和完成治法的主要手段。方与法之间系是相互为用，密不可分的。

除了以法组方、以法遣方以外，方剂和治法的关系，还体现在以法可以类方和以法可以释方两个方面。这四个方面，就构成了中医学历来所强调的“以法统方”的全部内容。

历代医学家鉴于具体治法的丰富内容，而又归属不同治法体系的特点，经过多次分类归纳逐渐形成体系。我们现在常沿用的“八法”，就是清代医家程钟龄从高层次治疗大法的角度，根据历代医家对治法的归类总结而来的。程氏在《医学心悟·医门八法》中说：“论病之源，以内伤、外感四字括之。论病之情，则以寒、热、虚、实、表、里、阴、阳八字统之。而论治病之方，则又以汗、和、下、消、吐、清、温、补八法尽之。”现将常用的八法内容，简要介绍如下：

汗 法

是通过开泄腠理、调畅营卫、宣发肺气等作用，使在表的外感六淫之邪随汗而解的一类治法。不以汗出为目的，而是通过出汗，使腠理开、营卫和、肺气畅、血脉通，从而能祛邪外出，正气

调和。除了主要治疗外感六淫之邪所致的表证外，对腠理闭塞，营卫郁滞的寒热无汗，或腠理疏松，虽有汗但寒热不解的病证，皆可用汗法治疗。由于病情有寒热，邪气有兼夹，体质有强弱，故汗法又有辛温、辛凉的区别，以及汗法与补法、下法、消法等其他治疗方法的结合运用。

吐 法

是通过涌吐的方法，使停留在咽喉、胸膈、胃脘的痰涎、宿食或毒物从口中吐出一类治法。适用于中风痰壅，宿食壅阻胃脘，毒物尚在胃中；痰涎壅盛之癫狂、喉痹，以及霍乱吐泻不得等，属于病位居上、病势急暴、内蓄实邪、体质壮实之证。因易伤胃气，故体虚气弱、妇人新产、孕妇等均应慎用。

下 法

是通过泻下、荡涤、攻逐等作用，使停留于胃肠的宿食、燥屎、冷积、瘀血、结痰、停水等从下窍而出，以祛邪除病的一类治法。凡邪在肠胃而致大便不通、燥屎内结，或热结旁流，以及停痰留饮、瘀血积水等形症俱实之证，均可使用。由于病情有寒热，正气有虚实，病邪有兼夹，所以下法又有寒下、温下、润下、逐水、攻补兼施之别，并与其他治法结合运用。



和 法

是通过和解或调和的方法，使半表半里之邪，或脏腑、阴阳、表里失和之证得以解除的一类治法。和解是专治邪在半表半里的一种方法。至于调和之法，是一种既能祛除病邪，又能调整脏腑功能的治法，无明显寒热补泻之偏，性质平和，全面兼顾，适用于邪犯少阳、肝脾不和、肠寒胃热、气血营卫失和等症。和法的应用范围较广，分类也多，其中主要有和解少阳、透达膜原、调和肝脾、疏肝和胃、分消上下、调和肠胃等。《伤寒论》中对某些经过汗、吐、下，或自行吐利而余邪未解的病证，宜用缓剂或峻剂小量分服，使余邪尽除而不重伤其正的，亦称为和法，属广义和法的范围，它与和解、调和治法所指含义不同，不属治法讨论范围。

温 法

是通过温里祛寒的作用，以治疗里寒证的一类治法。里寒证的形成，有外感内伤的不同，或由寒邪直中于里，或因失治误治而损伤人体阳气，或因素体阳气虚弱，以致寒由内生。同时，里寒证又有部位浅深、程度轻重的差别，故温法又有温中祛寒、回阳救逆和温经散寒的区别。由于里寒证形成和发展过程中，往往阳虚与寒邪并存，所以温法又常与补法配合运用。

清 法

是通过清热、泻火、解毒、凉血等作用，以清除里热之邪的一类治法。适用于里热证、火证、热毒证以及虚热证等里热病证。由于里热证有热在气分、营分、血分、热壅成毒以及热在某一脏腑之分，因而在清法之中，又有清气分热、清营凉血、清热解毒、清脏腑热等不同。热证最易伤阴，大热又易耗气，所以清热剂中常配伍生津、益气之品。若温病后期，热灼阴伤，或久病阴虚而热伏于里的，又当清法与滋阴并用，更不可纯用苦寒直折之法，热必不除。

消 法

是通过消食导滞、行气活血、化痰利水、驱虫等方法，使气、血、痰、食、水、虫等渐积形成的有形之邪渐消缓散的一类治法。适用于饮食停滞、气滞血瘀、癥瘕积聚、水湿内停、痰饮不化、痞积虫积以及疮疡痈肿等病症。消法与下法虽同是治疗内蓄有形实邪的方法，但在适应病症上有所不同。下法所治病证，多为病势急迫、形证俱实、邪在肠胃，必须速除，而且是可以从下窍而出者。消法所治，主要是病在脏腑、经络、肌肉之间，邪坚病痼而来势较缓，属渐积形成，且多虚实夹杂，尤其是气血积滞而成之癥瘕痞块、痰核瘰癧等，不可能迅即消除，必须渐消缓散。

消法也常与补法、下法、温法、清法等
其他治法配合运用，但仍然是以消为主
要目的。

补 法

是通过补益人体气血阴阳，以主治
各种虚弱证候的一类治法。补法的目
的在于通过药物的补益，使人体气血阴阳
虚弱或脏腑之间的失调状态得到纠正，
复归于平衡。此外，在正虚不能祛邪外
出时，也可以补法扶助正气，并配合其
他治法，达到扶正祛邪的目的。虽然
补法有时可收到间接祛邪的效果，但一
般是在无外邪时使用，以避免“闭门留
寇”之弊。补法的具体内容甚多，既有
补益气、血、阴、阳的不同，又有分补
五脏之侧重，但较常用的治法分类仍以
补气、补血、补阴、补阳为主。在这些
治法中，已包括了分补五脏之法。

上述八种治法，适用于表里、寒
热、虚实等不同的证候。对于多数疾病
而言，病情往往是复杂的，单一治法
往往不能符合治疗需要，常需数种治法
配合运用，才能治无遗邪，照顾全面。
所以虽为八法，配合运用之后则变化多
端。正如程钟龄《医学心悟》中说：
“一法之中，八法备焉，八法之中，百
法备焉。”因此，临证处方，必须针对
具体病证，灵活运用八法，使之切合病
情，方能收到满意的疗效。

方剂的分类

方剂的分类，历代医家见仁见智，
先后创立了多种分类方法，其中主要有
“七方”说、病症分类法、祖方分类
法、功用分类法、综合分类法等。

“七方”说

“七方”说始于《黄帝内经》。
《素问·至真要大论》说：“君一臣
二，制之小也。君一臣三佐五，制之中
也。君一臣三佐九，制之大也”；“君
一臣二，奇之制也。君二臣四，偶之制
也。君二臣三，奇之制也。君二臣六，
偶之制也”；“补上治上制以缓，补下
治下制以急，急则气味厚，缓则气味
薄”；“近而奇偶，制小其服；远而奇
偶，制大其服。大则数少，小则数多，
多则九之，少则二之。奇之不去则偶
之，是谓重方。”这是“七方”说的最
早记载。从《素问·至真要大论》所述
内容来分析，它是根据病邪的微甚、病
位的表里、病势的轻重、体质的强弱
以及治疗的需要，概括地说明制方的
方法，并不是为了方剂分类而设。至
金·成无己在《伤寒明理论》中说：
“制方之用，大、小、缓、急、奇、



偶、复七方是也”，才明确提出“七方”的名称，并将《内经》的“重”改为“复”，于是后人引申“七方”为最早的方剂分类法。成氏虽倡“七方”之说，但除了在分析方剂时有所引用外，其所著《伤寒明理论》中也未按“七方”分类。迄今为止，尚未见到按“七方”分类的方书。由此可见，“七方”应当是古代的一种组方理论。

病症分类法

按病证分类的方书首推《五十二病方》，该书记载了52种疾病，医方283首，涉及内、外、妇、儿、五官等科，但组方简单，用量粗略，部分病名、药名已无从查考，不具有临床指导意义。汉代张仲景《伤寒杂病论》、唐代王焘《外台秘要》、宋代王怀隐《太平圣惠方》、明代朱《普济方》、清代张璐《张氏医通》、清代徐大椿的《兰台轨范》等，均为病症分类的代表作。这种分类方法，便于临床以病索方。

病症分类法还包括了以脏腑病症或以病因等分类方剂的不同方法，如《备急千金要方》、《外台秘要》、《三因极一病证方论》等都是以病症分类为基础的相关方法结合的方书。

祖方（主方）分类法

明代施沛所编著的《祖剂》，选《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匱要

略》、《太平惠民和剂局方》以及后世医家的部分基础方剂，冠以祖方，用以归纳其他同类方剂。清代《张氏医通》除按病因、病症例方外，另编一卷《祖方》，选古方34首为主，各附衍化方若干首。这种分类方法，对归纳病机、治法共性的类方研究具有较好的作用，但往往不能推本溯源，始末不清。例如以宋代《局方》二陈汤为祖方，而将唐代《千金方》的温胆汤反作附方。

功用（治法）分类法

方剂的功用与其所体现的治法是一致的，故以治法分类方剂的方法是由早期功用分类的基础上逐渐发展成熟的，这种方法始于“十剂”说。唐代陈藏器于《本草拾遗·条例》中提出“药有宣、通、补、泄、轻、重、涩、滑、燥、湿十种”，并于“宣可去壅”“通可去滞”“补可去弱”“泄可去闭”“轻可去实”“重可去怯”“滑可去著”“涩可去脱”“燥可去湿”“湿可去枯”之下，各举数药为例。可见陈氏所归纳的“十种”之说，原是针对药物按功用分类的一种方法。宋代赵佶《圣济经》于每种之后加一“剂”字，如《圣济经·审剂篇》云：“故郁而不散为壅，以宣剂散之。”金·成无己《伤寒明理论》中说：“制方之体，宣、通、补泄、轻、重、滑、涩、燥、湿十剂是也。”至此方书中才有“十剂”这



个名称。但对十剂分类，还不足以完全概括临床常用方药，所以后世各家又有增益，如《本草衍义》于十剂外增加寒、热二剂；明·缪仲淳增加升、降二剂。明代徐思鹤的《医家全书》除十剂外，增加了调、和、解、利、寒、温、暑、火、平、夺、安、缓、淡、清等，共为二十四剂。方书中除清·陈修园《时方歌括》载方108首是按上述十二剂分类外，其余尚不多见。

明·张景岳鉴于“古方之散列于诸家者，既多且杂，或互见于各门，或彼此之重复”，因而“类为八阵，曰补、和、攻、散、寒、热、固、因。”并在《景岳全书·新方八略引》中说：“补方之制，补其虚也”；“和方之制，和其不和者也”；“攻方之制，攻其实也”；“用散者，散表证也”；“寒方之制，为清火也，为除热也”；“热方之制，为除寒也”；“固方之制，固其泄也”；“因方之制，因其可因者也。凡病有相同者，皆按证而用之，是谓因方”。张氏选集古方1516首，自制新方186首，皆按八阵分类。此外，为便于专科临证运用，又另列妇人、小儿、痘疹、外科四大门类，作为补充。可见，张氏的八阵分类方法是对原有功用（治法）分类方法的进一步完善和发展。

清代程钟龄在《医学心悟》中提出：“论治病之方，则又以汗、和、下、消、吐、清、温、补八法尽之”，

明确提出了“以法统方”的思想，也是对治法分类方剂的理论总结。

综合分类法

清代汪昂的《医方集解》，开创了新的综合分类法，既能体现以法统方，又能结合方剂功用和证治病因，并照顾到治有专科。分别为补养、发表、涌吐、攻里、表里、和解、理气、理血、祛风、祛寒、清暑、利湿、润燥、泻火、除痰、消导、收涩、杀虫、明目、痲痹、经产、救急等22类。这种分类法，概念清楚、提纲挈领、切合临床、照顾面广，被后世多数医家所推崇，如清代吴仪洛的《成方切用》、清代张秉成的《成方便读》都是借用汪氏的分类方法。

综上所述，历代医家对于方剂的分类，各有取义，繁简不一。古今方书浩瀚，前人所累积的有效方剂，不尽其数。加之一方可以多用，一方常兼几法，在整理历代方剂时，如何使分类细而不犯繁琐、简而不致笼统或挂漏，还需要很好地研究总结。

本书从有利于读者按病索方的角度出发，遵循病症分类法的分类原则，结合现代医学和诊断的习惯，以西医病证系统分类，分为呼吸系统疾病、消化系统疾病、循环系统疾病、泌尿生殖系统疾病和其他疾病共5章，尽可能做到法与方的统一，使之有纲有目，概念明确，



条理清晰，便于学习和掌握，为临床辨证论治和遣药组方打好基础。

方剂的组成与变化

中医临床的用药治病多数采用复方形式。在辨证审因，确定治法之后，便进入了具体的遣药组方阶段。要组织好一首有效方剂，必须重视两个重要环节：一是严密的组方基本结构；二是熟练的药物配伍技巧。

方剂的配伍目的

药物的功用各有所长，也各有所短，只有通过合理的组织，调其偏性，制其毒性，增强或改变原有功能，消除或缓解其对人体的不良因素，发挥其相辅相成或相反相成的综合效应，使各具特性的群药组合成一个新的有机整体，才能符合辨证论治的要求。这种运用药物的组合过程，中医药学称之为“配伍”。“配”，有组织、搭配之义；“伍”，有队伍、序列之义。

运用配伍方法遣药组方，从总体而言，其目的不外增效、减毒两个方面。“用药有利有弊，用方有利无弊”，如何充分发挥药物对治疗疾病有“利”的

一面，同时又能控制、减少甚至消除药物对人体有“弊”的一面，这就是方剂学在运用配伍手段时最根本的目的。一般来说，药物通过配伍，可以起到下述作用：

增强药力。功用相近的药物配伍，能增强治疗作用，这种配伍方法在组方运用中较为普遍。如荆芥、防风同用可疏风解表；薄荷、茶叶同用可清利头目；党参、黄芪同用可健脾益气；桃仁、红花同用可活血祛瘀等。

产生协同作用。药物之间在某些方面具有一定的协同作用，常相互需求而增强某种疗效。如麻黄和桂枝相配，通过“开腠”和“解肌”协同，比单用麻黄或桂枝方剂的发汗力量明显增强；附子和干姜相配，俗称“附子无姜不热”，体现了先后天脾肾阳气同温，“走而不守”和“守而不走”协同，大大提高温阳祛寒作用。

控制多功用单味中药的发挥方向。这是在方剂配伍中十分重要的一个方面。通过配伍，可以控制药物功用的发挥方向，从而减少临床运用方药的随意性。

扩大治疗范围，适应复杂病情。中医药学在长期的发展过程中，经历代医家反复实践总结，产生了不少针对基础病机的基础方剂，如四君子汤、四物汤、二陈汤、平胃散、四逆散等。在临床上通过随证配伍，可以使这些基础方剂不断扩大治疗范围。

控制药物的毒副作用。“是药三分毒”。从中国医学史的相关资料表明，上古时期，人们对药物的毒副作用是十分畏惧的，从古代将中药统称为“毒药”，以及“神农尝百草，一日而遇七十毒”的传说，到“若药不瞑眩，厥疾弗瘥”的认识，以及臣子为国君试药、儿子为父亲试药的记载，反映了当时运用药物能产生毒副作用的普遍性。但随着中医学的发展和药物运用经验的积累，尤其是方剂学的发展，探索和掌握了控制毒副作用的方法，为后世方药的广泛运用和疗效的提高创造了条件。至西汉后期时，对中药的称谓，由“毒药”改称为“本草”，这本身就是中医药学划时代进步的标志。这与方剂学中运用配伍方法的成果是分不开的。通过配伍控制毒副作用，主要反映在两个方面。一是“七情”中“相杀”和“相畏”关系的运用，即一种药物能减轻另一种药物的毒副作用，二是多味功用相近药物同时配伍的运用，这种方式既可利用相近功用药物的协同作用，又能有效减轻毒副作用的发生。控制毒副作用的方法，除了上述两个方面外，中医药学中还包含着丰富的方法和内容。如因时、因地、因人制宜，恰如其分的用量控制，特定的炮制方法，道地药材的选择，具体的煎药、服药方法以及恰当的剂型要求等。

方剂的基本结构

每一首方剂，固然要根据病情，在辨证立法的基础上选择合适的药物，妥善配伍而成。但在组织不同作用和地位的药物时，还应符合严密的组方基本结构，即“君、臣、佐、使”的组方形式。这样才能做到主次分明、全面兼顾、扬长避短、提高疗效。

据各家论述及历代名方的组成规律，进一步分析归纳如下：

君药：即对主病或主证起主要治疗作用的药物。

臣药：有两种意义。①辅助君药加强治疗主病或主证作用的药物；②针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用的药物。

佐药：有三种意义。①佐助药，即配合君、臣药以加强治疗作用，或直接治疗次要兼证的药物；②佐制药，即用以消除或减弱君、臣药的毒性，或能制约君、臣药峻烈之性的药物；③反佐药，即病重邪甚，可能拒药时，配用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物，以防止药病格拒。

使药：有两种意义。①引经药，即能引领方中诸药至特定病所的药物；②调和药，即具有调和方中诸药作用的药物。

综上所述，一个方剂中药物的君、臣、佐、使，主要是以药物在方中所起作用的主次地位为依据。遣药组方时既要针对病机考虑配伍用药的合理性，又要按照



组成的基本结构要求将方药组合成为一个主次分明、全面兼顾的有机整体，使之更好地发挥整体效果，这是需要充分运用中医药理论为指导，进行周密设计的。

方剂的变化形式

临证不依病机、治法选用成方，谓之“有方无法”；不据病情加减而墨守成方，又谓“有方无药”。因此在临证运用成方时，我们应根据病人体质状况、年龄长幼、四时气候、地土差异，以及病情变化而灵活加减，做到“师其法而不泥其方，师其方而不泥其药”。徐灵胎说：“欲用古方，必先审病者所患之证相合，然后施用，否则必须加减，无可加减，则另择一方。”（《医学源流论·执方治病论》）说明方剂在运用时不可囿于成方，应当通过灵活变化来适应具体病情的需要。

药味加减的变化。药物是决定方剂功用的主要因素。当方剂中的药物增加或减少时，必然要使方剂组成的配伍关系发生变化，并由此导致方剂功用的改变。这种变化主要用于临床选用成方，其目的是使之更加适合变化了的病情的需要。必须指出，在此所指的药味增减的变化，是指在主病、主证、基本病机以及君药不变的前提下，改变方中的次要药物，以适应变化了的病情需要，即我们常说的“随证加减”。在选用成方加减时，一定要注意所治病症的病机、

主证都与原方基本相符，否则是不相宜的。还有一点，即对成方加减时，不可减去君药，否则就不能说是某方加减，而是另组新方了。

药量增减的变化。药物的用量直接决定药力的大小。某些方剂中用量比例的变化还会改变方剂的配伍关系，从而可能改变该方功用和主治证候的主要方面。药量的增加或减少，可以是单纯药力的改变，也可以随着组成配伍关系的改变而功用、主治发生改变。

中药制剂种类较多，各有特点。由于剂型不同，在作用上也有区别。药味、药量、剂型等的变化形式，可以单独应用，也可以相互结合使用，有时很难截然分开。但通过这些变化，能充分体现出方剂在临床中的具体运用特点，只有掌握这些特点，才能制裁随心，以应万变之病情，从而达到预期的治疗目的。

剂型与服药方法

剂 型

方剂组成以后，还要根据病情与药物的特点制成一定的形态，称为剂型。早在《黄帝内经》中就有汤、丸、散、



膏、酒、丹等剂型，历代医家又有很多发展，明代《本草纲目》所载剂型已有40余种。建国以来，随着制药工业的发展，又研制了许多新的剂型，如片剂、冲剂、注射剂等。

现将常用剂型的主要特点及制备方法简要介绍如下：

汤剂

古称汤液，是将药物饮片加水或酒浸泡后，再煎煮一定时间，去渣取汁，制成的液体剂型。主要供内服，外用的多作洗浴、熏蒸及含漱。特点是吸收快、药效发挥迅速，而且可以根据病情的变化随证加减，能较全面、灵活地照顾到每个患者或各具体病变阶段的特殊性，适用于病症较重或病情不稳定的患者。汤剂的不足之处是服用量大，某些药的有效成分不易煎出或易挥发散失，不适于大生产，亦不便于携带。

散剂

将药物粉碎，混合均匀，制成粉末状制剂，分为内服和外用两类。内服散剂一般是研成细粉，以温开水冲服，量小者亦可直接吞服，亦有制成粗末，以水煎取汁服者，称为煮散。散剂的特点是制作简便，吸收较快，节省药材，便于服用及携带。外用散剂一般作为外敷，掺散疮面或患病部位，亦有作点眼、吹喉等用，应研成极细粉末，以防刺激创面。

丸剂

是将药物研成细粉或药材提取物，加适宜的粘合剂制成球形的固体剂型。与汤剂相比，吸收较慢，药效持久，节省药材，便于服用与携带。适用于慢性、虚弱性疾病。但也有丸剂药性比较峻猛，多为芳香类药物与剧毒药物，不宜作汤剂煎服的。常用的丸剂有蜜丸、水丸、糊丸、浓缩丸等。

(1) 蜜丸

是将药物细粉用炼制的蜂蜜为粘合剂制成的丸剂，分为大蜜丸和小蜜丸两种。性质柔润，作用缓和持久，并有补益和矫味作用，常用于治疗慢性病和虚弱性疾病，需要长期服用。

(2) 水丸

俗称水泛丸，是将药物细粉用水（冷开水或蒸馏水）或酒、醋、蜜水、药汁等为粘合剂制成的小丸。水丸较蜜丸崩解、溶散得快，吸收、起效快，易于吞服，适用于多种疾病。

(3) 糊丸

是将药物细粉用米糊、面糊、曲糊等为粘合剂制成的小丸。糊丸粘合力强，质地坚硬，崩解、溶散迟缓，内服可延长药效，减轻剧毒药的不良反应和对胃肠的刺激。

(4) 浓缩丸

是将药物或方中部分药物煎汁浓缩成膏，再与其他药物细粉混合干燥、粉



碎，用水或蜂蜜或药汁制成丸剂。因其体积小，有效成分高，服用剂量小，可用于治疗多种疾病。

其他尚有蜡丸、水蜜丸、微丸、滴丸等。

膏 剂

是将药物用水或植物油煎熬去渣而制成的剂型，有内服和外用两种。内服膏剂有流浸膏、浸膏、煎膏三种；外用膏剂分软膏、硬膏两种。其中流浸膏与浸膏多数用于调配其他制剂使用，如合剂、糖浆剂、冲剂、片剂等。现将煎膏与外用膏剂分述如下：

(1) 煎膏

又称膏滋，是将药物加水反复煎煮，去渣浓缩后，加炼蜜或炼糖制成的半液体剂型。其特点是体积小、含量高、便于服用、口味甜美、有滋润补益作用，一般用于慢性虚弱性患者，有利于较长时间用药。

(2) 软膏

又称药膏，是将药物细粉与适宜的基质制成具有适当稠度的半固体外用制剂。其中用乳剂型基质的亦称乳膏剂，多用于皮肤、粘膜或疮面。软膏具有一定的粘稠性，外涂后渐渐软化或熔化，使药物慢慢吸收，持久发挥疗效，适用于外科疮疡疖肿、烧烫伤等。

(3) 硬膏

又称膏药，古称薄贴。它是以植

物油将药物煎至一定程度，去渣，煎至滴水成珠，加入黄丹等搅匀，冷却制成的硬膏。用时加温摊涂在布或纸上，软化后贴于患处或穴位上，可治疗局部疾病和全身性疾病，如疮疡肿毒、跌打损伤、风湿痹证以及腰痛、腹痛等。

酒 剂

又称药酒，古称酒醴。它是将药物用白酒或黄酒浸泡，或加温隔水炖煮，去渣取液，供内服或外用。酒有活血通络、易于分散和助长药效的特性，故常在祛风通络和补益剂中使用。外用酒剂尚可祛风活血、止痛消肿。

丹 剂

有内服和外用两种。内服丹剂没有固定剂型，有丸剂，也有散剂，每以药品贵重或药效显著而名之曰丹，如至宝丹、活络丹等。外用丹剂亦称丹药，是以某些矿物类药经高温烧炼制成的不同结晶形状的制品。常研粉涂撒疮面，治疗疮疡痈疽，亦可制成药条、药线和外用膏剂应用。

茶 剂

是将药物经粉碎加工而制成的粗末状制品，或加入适宜粘合剂制成的方块状制剂。用时以沸水泡汁或煎汁，不定时饮用。大多用于治疗感冒、食积、腹泻，近年来又有许多健身、减肥的新产品。



露 剂

亦称药露，多用新鲜含有挥发性成分的药物，用蒸馏法制成的芳香气味的澄明水溶液。一般作为饮料及清凉解暑剂。

锭 剂

是将药物研成细粉，或加适当的粘合剂制成规定形状的固体制剂，有纺锤形、圆柱形、条形等，可供外用与内服。内服，取研末调服或磨汁服；外用，则磨汁涂患处。

条 剂

亦称药捻，是将药物细粉用桑皮纸粘药后搓捻成细条，或将桑皮纸捻成细条再粘着药粉而成。用时插入疮口或痿管内，能化腐拔毒、生肌收口。

线 剂

亦称药线，是将丝线或棉线置药液中浸煮，经干燥制成的外用制剂。用于治疗瘰管、痔疮或赘生物，通过所含药物的轻度腐蚀作用和药线的机械紧扎作用，使其引流通畅，或萎缩、脱落。

栓 剂

古称坐药或塞药，是将药物细粉与基质混合制成一定形状的固体制剂，用于腔道并在其间融化或溶解而释放药物，有杀虫止痒、润滑、收敛等作用。《伤寒杂

病论》中曾有蛇床子散坐药及蜜煎导法，即最早的阴道栓与肛门栓。近年来栓剂发展较快，可用以治疗全身性疾病。它的特点是通过直肠（也有用于阴道）粘膜吸收，有50%~70%的药物不经过肝脏而直接进入大循环，一方面减少药物在肝脏中的“首过效应”，同时减少药物对肝脏的毒性和副作用，还可以避免胃肠液对药物的影响及药物对胃粘膜的刺激作用。婴幼儿直肠给药尤为方便。

冲 剂

是将药材提取物加适量赋形剂或部分药物细粉制成的干燥颗粒状或块状制剂，用时以开水冲服。冲剂具有作用迅速、味道可口、体积较小、服用方便等特点，深受患者欢迎。

片 剂

是将药物细粉或药材提取物与辅料混合压制而成的片状制剂。片剂用量准确，体积小。味很苦或具恶臭的药物压片后可再包糖衣，使之易于服用。如需在肠道吸收的药物，则又可包肠溶衣，使之在肠道中崩解。此外，尚有口含片、泡腾片等。

糖浆剂

是将药物煎煮、去渣取汁、浓缩后，加入适量蔗糖溶解制成的浓蔗糖水溶液。糖浆剂具有味甜量小、服用方便、吸收较快等特点。



口服液

是将药物用水或其他溶剂提取，经精制而成的内服液体制剂。该制剂集汤剂、糖浆剂、注射剂的特点，具有剂量较少、吸收较快、服用方便、口感适宜等优点。近年来发展很快，尤其是保健与滋补性口服液日益增多。

注射液

亦称针剂，是将药物经过提取、精制、配制等制成的灭菌溶液、无菌混悬液或供配制成液体的无菌粉末，供皮下、肌肉、静脉等注射的一种制剂。具有剂量准确、药效迅速、适于急救、不受消化系统影响的特点，对于神志昏迷、难于口服用药的患者尤为适宜。

以上诸种剂型，各有特点，临证应根据病情与方剂特点酌情选用。此外，尚有胶囊剂、灸剂、熨剂、灌肠剂、搽剂、气雾剂等，都在临床中广泛应用，而且还在不断研制新剂型，以提高药效，便于临床使用。

服法

方剂的服法包括服药时间和服药方法。服法的恰当与否，对疗效有一定影响。清代徐灵胎于《医学源流论》中说：“病之愈不愈，不但方必中病，方虽中病，而服之不得法，则非特无功，而反有害，此不可不知也。”因此，对

方剂的服用方法也应予以重视。兹就历代方剂运用情况，总结说明于下。

1. 服药时间

一般来说，宜在饭前1小时服药，以利于药物尽快吸收。但对胃肠有刺激的方药，宜饭后服用，以防产生副作用；滋补方药，宜空腹服用；治疟方药，宜在发作前2小时服用；安神方药，宜在睡前服用；急症重病可不拘时间服用；慢性病应定时服用，使之能持续发挥药效。根据病情的需要，有的可一天数服，有的可煎泡代茶时时饮用。个别方剂，古人对服药时间有特殊要求，如鸡鸣散在天明前空腹冷服效果较好，可参考运用。

前人有些服药论述，是考虑病位的上下远近，从有利于除邪和养生而论，亦可供临床参考。如《千金要方·序例》记载的“病在胸膈以上者，先食后服药；病在胸膈以下者，先服药后食；病在四肢血脉者，宜空腹而在旦；病在骨髓者，宜满而在夜。”以及《医心方》载葛仙翁曰：“服治病之药，以食前服之；服养生之药，以食后服之。”

2. 服药方法

运用汤剂，通常是1日1剂，将头煎、二煎兑合，分2次或3次温服。但特殊情况下，亦可1日连服2剂，以增强药力。散剂和丸剂是根据病情和具体药物定量，日服2次或3次。散剂中有些可直接用水送服，有些粗末散剂，可加水煮



沸取汁，还有些散剂是用于外敷或掺洒疮面，亦有作为点眼或吹喉用的。各种丸剂都可以直接用水送服，至于其他不同剂型，可参考制剂情况及方药功用酌情而定。

针对不同情况，前人还总结出一些汤剂的经验服法。如服发汗解表药，宜趁热服，药后还须盖被避风，使遍身微微出汗为佳。热证用寒药可冷服以助其清，寒证用热药可热服以助其温，但有时寒热偏盛、阴阳离绝、相互格拒，出现服药后呕吐的情况，如果是真寒假热证候则宜热药冷服，真热假寒证候则宜寒药热服。此谓反佐服药法，即《素问·五常政大论》中所说：“治热以寒，温而行之；治寒以热，凉而行之；治温以清，冷而行之；治清以温，热而行之。”若见服药呕吐者，宜先服少许姜汁，或用鲜生姜擦舌，或嚼少许陈皮，然后再服汤药；或采用冷服、少量频饮的方法。对于昏迷病人及吞咽困难者，现多用鼻饲法给药。

使用峻烈药或毒性药，应审慎从事，宜先进小量，而后逐渐增大，至有效止，不可过量，以免中毒。《神农本草经·序例》中说：“若用毒药疗病，先起如黍粟，病去即止，不去倍之，不去十之，取去为度。”明确提出毒性药的运用规范。总之，在治疗过程中，应根据病情和药物的性能来决定不同的服法。

呼吸系统疾病

方藏中皆祕方、脈方、
方等、奇方、圖經、諸方中時
至、病中者、常是清純四
方、其書兩百餘方。史
云、古今謂多名方、然
祕方、不難易辨、易
易辨、指錄指美、而上
難考、對某些病候、隨
時是變、不斷時懷然、又
他方、同遠合廣大中者
為常用。



病名

感冒、
上呼吸道感染

中医病名

外感风寒表实证

症状

外感风寒表实证主要表现为恶寒发热，头身疼痛，无汗而喘，舌苔薄白，脉浮紧。麻黄汤是治疗外感风寒表实证的基础方。临床应用以恶寒发热，无汗而喘，脉浮紧为辨证要点。

本证之恶寒怕冷为必见表现，且比较显著，病人往往穿厚衣或盖厚被，喜靠近暖气、空调等取暖，但仍难解其寒。恶寒之后可能出现发热症状，一般并非高热，基本不超过38.5摄氏度，代表性的症状是病人能自觉寒冷，却多半没有自觉发热。另外一项特征性症状是无汗。这是体表毛孔等孔窍闭塞的重要标志。如有汗，则无法诊断为本证。全身关节疼痛及头痛等症状，多为酸麻痛楚、活动不适等轻微疼痛，不会达到难以忍受的剧痛程度。因为没有口渴舌红等热症表现，证明患者营阴未伤，不属于热证，这也是与表热证区分的一个重要依据。舌苔薄白，无油腻之象，则可以与湿邪犯表引起的头痛病证相区别。总

体说明，表寒实证虽然是体表病变，但中医理论中，“肺合皮毛”，在体表的病变很容易深入而影响到肺，这也与西医理论中外感疾病很容易沿气管等呼吸道深入达到肺脏不谋而合，所以也会有咳嗽气喘等呼吸道疾病的初期症状，不过，这并非疾病的主要表现，也不是鉴别诊断的依据。

【用方】

麻黄汤——《伤寒论》

方剂说明

发汗解表，宣肺平喘。

针对于流行性感病毒引起的急性呼吸道传染病、易于冬季发生的普通感冒或鼻、咽、喉及气管支气管树的其他病毒感染之后的急性上呼吸道感染等。

组成

麻黄（去节）9g，桂枝6g，杏仁（去皮尖）6g，炙甘草3g。

歌曰：麻黄汤中用桂枝，杏仁甘草四般施，发热恶寒头项痛，喘而无汗宜服之。

配伍说明

麻黄汤主要用于治疗外感风寒表实证。表实证的根本原因是由于肺气不能宣发，故本方关键之处在于发散肺气。



中医理论认为肺主一身之气，外合皮肤毛发，能通肌理。由于外感风寒之邪束缚体表，导致毛窍闭塞，卫阳之气被遏制，不能通达于外，所以会出现恶寒发热、无汗、头身疼痛的症状；又由于毛孔不透，肺气也不能宣通，不能发散于外，就上逆而表现为咳喘的症状。本方中，麻黄发汗解表，宣肺平喘，利水消肿，可治疗本病的主症。但由于本病卫强营弱、卫气与邪气交争于外，导致卫气的病理性亢盛，故单用麻黄发汗只能解卫气之闭郁，所以又加透营达表的桂枝为臣药，以助麻黄发汗之力，同时起到调和营卫的作用。杏仁降肺气，与麻黄配伍，一升一降，能够达到宣肺平喘的功效。炙甘草益气补中、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛，调和药性的同时又可调和麻黄杏仁的宣降特性，缓和麻黄桂枝合用的峻烈作用，还可防止汗出过猛而伤及正气。故所谓“治肺不忘宣降”“麻黄无桂枝不温”。

根据现代药理研究，麻黄汤具有较强的发汗退热作用，如几味主要成分对流感病毒也有抑制作用。其中麻黄能解除支气管痉挛，使呼吸道通畅；桂枝能降低对疼痛的敏感度并且舒张血管，可止痛；杏仁对呼吸中枢有镇定作用，可镇咳。

方剂制备

取水1800毫升煎煮麻黄，至水量约减少到原来的3/4时撇去浮沫，加入其余三味药材，继续煎至约500毫升药汁。分三份趁温热时服用。服后盖被至全身微微汗出为佳。如汗出后退热，病痛大减，则不要再服；若仍然不能出汗，可酌情再服。

使用说明

1. 一般冬季使用。
2. 青壮年多用。
3. 北方多用。
4. 有咽痛者不能使用麻黄汤。咽痛表明有热，热证加用热药，则必然加重病情。
5. 本方虽为取汗，但不可发汗多，因大汗会损伤人体阳气。发汗后应擦干，避免风干受凉。
6. 服药期间忌食生冷油腻食物，不宜冷敷。
7. 本方为辛温发汗之峻剂，故《伤寒论》对“疮家”“淋家”“衄家”“亡血家”，以及外感表虚自汗、血虚而脉兼“尺中迟”、误下而见“身重心悸”等，虽有表寒证，亦皆禁用。麻黄汤药味虽少，但发汗力强，不可过服，否则，汗出过多必伤人正气。正如柯琴指出：“此乃纯阳之剂，过于发散，如单刀直入之将，投之恰当，一战成功。”



不当则不戢而召祸。故用之发表，可一而不可再。”（《伤寒来苏集·伤寒附翼》卷上）

临症加减

1. 如患者身体困重不灵活，平时生活环境多潮湿的，则在原方基础上加白术12g，即为麻黄加术汤。本方创建于东汉时期，方中的白术也可以用苍术代替。用白术则侧重补气健脾，燥湿利水，止汗安胎；用苍术则侧重燥湿健脾，祛风湿。

2. 如患者下午至傍晚时分发热明显，全身风湿疼痛的，则原方麻黄减为6g，去桂枝，加薏苡仁12g此方为麻杏苡甘汤，可解表祛湿，须注意，患者是阴虚潮热，而不是湿邪所致的潮热。

3. 如患者着凉后烦躁，不出汗，身体疼痛的，则原方麻黄减为6g，甘草加至6g，另加石膏18g，生姜9g，大枣3g，此方称为大青龙汤。患者服用之后，应该达到微微出汗的效果，如果汗出过多，就要用温粉扑身止汗。温粉配方：龙骨、牡蛎、黄芪、麻黄根，4味药材混合研成细末。功用：发汗解表，清热除烦。

4. 如患者鼻塞不通，声音闷重，说话难以出声，并且咳嗽胸闷的，可使用有节麻黄、保留皮尖的杏仁及鲜甘草，3味药材等量混合研为粗末，取15g及生姜5片、加水400毫升煎至250毫升，即为三

拗汤。去渣后服用，给身体保暖至微微出汗即可。功用：宣肺解表。

典型案例

王某，男，43岁。患者于昨夜发热，体温38.9度，今晨来诊仍发热，头痛，颈项强直，肢体酸楚而痛，流清涕，心烦欲呕，食减而不渴，脉浮紧，舌苔薄白。麻黄汤加味主之。麻黄6g，桂枝10g，杏仁10g，法夏6g，防风6g，甘草6g，生姜3片。嘱温服而卧，取汗自愈。

病名

流行性感
各种体虚长期发热

中医病名

外感风寒表虚证

症状

主要表现为头痛发热、汗出恶风、鼻鸣干呕、苔白不渴（不渴在这里作为鉴别症状出现，又如小便自利。主要用于与外感风热证相区分。）、脉象浮缓或浮弱。

本症发热一般为低热，这与症状中包括自汗出，带走身体一部分热量有关。而发热同时伴有恶风也是本病的一



个特点。恶风与恶寒其实是程度上的差别，所谓恶风，即连风所带来的一点寒气也不能忍受，但无风时没有寒冷感；而恶寒则指无风时也有寒冷感。自汗频出也是本病的症状，并且与恶风一同出现，往往出汗后更明显地表现出恶风。头痛可以表现为头部、颈项等部位的强直性疼痛，也可以是后头部和额部的疼痛，一般程度较轻微。口不渴、舌不红，舌苔薄白也是津液未伤，没有转成热证的有力证明。鼻塞、喷嚏、流清鼻涕等症状既可以出现于风寒感冒和流行性感冒中，也可能是某些种类的鼻咽炎症。

本症与表寒实证（麻黄汤证）的区别主要在于有汗还是无汗，脉象是浮缓还是浮紧，另外还可参考有无咳嗽、气喘等症状。

【用方】 桂枝汤——《伤寒论》

方剂说明

解肌发表，调和营卫。本方常用于感冒、流行性感冒、原因不明的低热、产后及病后的低热、妊娠呕吐、多形红斑、冻疮、荨麻疹等属营卫不和者。

组成

桂枝9g，芍药（白芍）9g，甘草6g，生姜9g，大枣3枚。

歌曰：桂枝汤治太阳风，芍药甘草姜枣同，解肌发表调营卫，表虚有汗此有功。

配伍说明

本症是由风寒束表，营卫不和所致。外感风寒表虚证，《伤寒论》中称之为太阳中风，其病机为卫强营弱（是卫气与邪气交争的应急状态）。外感风邪，风性疏泄，卫气失去其固护之性，不能固护营阴，致使营阴不能内守而外泄，故头痛发热，汗出恶风，脉浮缓。汗者，阳加于阴谓之汗也。风寒在表，应以辛温发散之品以解表，但本症属于表虚，腠理不固，故治以解肌发表，调和营卫。营为阴，卫为阳，调和营卫也是调和阴阳，即祛邪扶正兼顾治之。方中桂枝发汗解肌，温经通络，助阳化气为君药。（解肌与解表是有区别的，解肌主要有两种情况：1. 病人汗出表证，由于腠理疏松，邪在腠理，用解肌；2. 透疹亦可用解肌，一般有解肌作用的药物都有透疹的作用。而解表则是一个含义范围较宽的词，解表包括解肌，而解肌的主要位置在腠理。）用芍药养血调经，平肝止痛，敛阴止汗为臣药，是由于芍药有益阴敛营，敛固外泄之营阴的作用。桂芍等量合用，一治卫强，一治营弱，使表邪得解，营卫调和。生姜发汗解表，温中止呕，温肺止咳，性辛温，既助桂枝辛散表邪，又可以和胃止



呕。大枣补中益气，养血安神，缓和药性甘平，可以补中益气滋脾生津。姜枣相配，是补脾和胃，调和营卫的常用组合，是本方中除了桂枝芍药以外的第二对调和营卫的药对。炙甘草益气补中、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛，调和药性，合桂枝辛甘化阳以实卫，合芍药酸甘化阴以和营。

据现代药理研究，桂枝汤具有解热镇痛、消炎镇静等作用其中桂枝能降低人体对疼痛的敏感度，解除血管及心肌的痉挛状态。与具有同样功用的芍药相配合，能达到良好的止痛效果，同时血管扩张，血液循环改善，有温通阳气，调和血液的功用；甘草、生姜、大枣能促进血液循环并抗过敏，并为机体提供营养。所以桂枝汤能全方位发汗解热，对抗多种病原体，改善血液循环。

方剂制备

五味药材研成粗末，用水1400毫升，小火熬煮至剩600毫升左右，滤掉药渣待药液温度适中时先服用三分之一，然后食用一些热稀粥，并盖厚被发汗，2小时左右应该达到周身微微汗出的效果，不要时间过久以致出汗过多，否则损及阴液阳气，反而不能透邪外出。

使用说明

1. 现在常用于半身汗出，效果颇佳；成人遗尿，加龙骨、牡蛎；以及遗

精早泄等证。

2. 不止用于外感表证，也常用于内伤杂症，具有双向调节使体温等生命指征趋向正常的特点；既能发汗也能止汗，能利尿也能止淋，通过适当加减变化可以获得理想的效果。

3. 热邪在表或有里热者忌用。

4. 如取汗效果不佳不宜过度服用，须重新辨证以防误治。

5. 禁食生冷粘腻、酒肉臭恶等，尤其“不可令如水流漓，病必不除”，是服解表剂后应该注意的通则。

6. 表实无汗，或表寒里热，不汗出而烦躁，以及温病初起，见发热口渴，咽痛脉数者，皆不宜使用。

临症加减

1. 病人体质较差，或表现为出汗较多，可在原方基础上加适量黄芪。

2. 有明显的脊背僵直症状，可加入葛根，即桂枝加葛根汤。

3. 有咳嗽、喘急的，加厚朴、杏仁，即桂枝加厚朴杏子汤。

4. 有腹部胀满疼痛拒按的，可加大黄，即桂枝加大黄汤。

5. 小儿因肺炎等呼吸道疾病，病后仍有余热、出汗干咳的，或妇女产后汗出不止，均可用本方加龙骨、牡蛎，即桂枝加龙骨牡蛎汤。此方也可治疗遗精、阳痿、脱发、失眠、眩晕等多种肾精亏损之证。



实例练习

王某，男，56岁，平素身体虚弱易患感冒。两天前感染风寒，现证见发热恶寒，头痛不舒，自己服用一些感冒药物后汗出后仍低热不退，全身酸痛无力，怕风头痛，不思饮食，查体见舌苔薄润而白，舌体淡红，脉缓无力。桂枝汤加味，桂枝9g，芍药（白芍）9g，甘草6g，生姜9g，大枣3枚，黄芪9g，水煎服。服后食用些热稀粥，并盖厚被发汗。

病名

感冒、流行性感冒、多种急性传染性疾病初起阶段

中医病名

表热证

症状

主要表现为发热无汗，或有汗不畅，微恶风寒，头痛口渴，咳嗽咽痛，舌尖红，苔薄白或微黄，脉浮数。《温病条辨》称本方为“辛凉平剂”，主治温病初起是治疗外感风热表证的常用方。临床应用以发热、微恶寒、咽痛、口渴、脉浮数为辨证要点。

发热恶寒为病邪侵袭体表的必有症状，本证外邪性质为热邪，故自觉发

热，体温有时可超过39摄氏度，反而恶寒症状不明显，只有毛孔闭塞且无汗的患者会有较明显的恶寒症状。人体感受热性病邪，耗伤阴津，故可有口渴、舌红、小便黄等热证表现。津液被热邪煎熬，也可能出现黄稠鼻涕、黄痰等呼吸道分泌物。咽喉肿痛等症状也有助于本病的诊断。中医学理论中“肺合于皮毛”也是咳嗽这一症状出于肺气、失于宣降的有力佐证。如果口渴比较明显，口腔、舌头干燥少津，而又病发于秋季者，多是燥热之症，会伴有咳嗽剧烈，痰少难出，或阵阵干咳。

表热证和里热证的主要区别在于有没有恶寒症状及是否明显热盛阴伤。恶寒明显而没有阴伤热盛症状的，为表证；无恶寒而壮热口渴、舌红苔黄、小便短赤等热盛阴伤表现的则为里证。但也有两种夹杂而成的表里俱热之症，临床需仔细鉴别。

【用方】

银翘散——《温病条辨》

方剂说明

辛凉透表，清热解毒。广泛用于急性发热性疾病的初起阶段，如感冒、流行性感冒、急性扁桃体炎、上呼吸道感染、肺炎、麻疹、流行性脑膜炎、乙型脑炎、腮腺炎等辨证属温病初起，邪郁



肺卫者。皮肤病如风疹、荨麻疹、疮痈疖肿，亦多用之。

组成

连翘15g，银花15g，苦桔梗6g，薄荷6g，竹叶4g，生甘草5g，荆芥穗4g，淡豆豉5g，牛蒡子6g，鲜苇根汤煎。

歌曰：银翘散主上焦疴，竹叶荆牛豉薄荷。甘桔芦根凉解法，清疏风热煮无过。

配伍说明

连翘、银花为君药，既有辛凉解表、清热解毒的作用，又具有芳香避秽的功效；薄荷、牛蒡子可疏散风热、清利头目，解毒利咽；荆芥穗、淡豆豉有发散解表之功，若无汗者，可以加大用量，助君药发散表邪，透热外出。此二者虽为辛温之品，但辛而不烈，温而不燥，反佐用之，可增辛散透表之力，为臣药。竹叶清热除烦生津，芦根清热生津，桔梗宣肺止咳，三者同为佐药。甘草调和诸药，清热除烦的力量：栀子>竹叶>灯心草。荆芥穗、淡豆豉性微温，开毛窍，助邪外出，表邪通过此二药透表而出。

根据现代药理学研究，本方对多种病毒有灭活作用，并有一定的抗菌效果，也能改善人体的免疫环境。方剂组成中的金银花、连翘、牛蒡子等药物是抑菌成分的主要来源。而荆芥的发汗解

热功能据研究应该来源于其成分对汗腺的刺激作用。桔梗服用后有助于支气管中的稠痰变稀，变得易于咳出。而甘草通过其抗炎、抗过敏的功能，能保护发炎的咽喉和支气管粘膜，使其少受刺激而减少咳嗽的发作。这些药物的协同作用，决定了银翘散比较适用于上呼吸道感染以及呼吸道传染病的初期阶段。

方剂制备

方中所有药物混合制成散剂，每次取粉末9g，先用新鲜芦根煎汤，再加入药粉煮沸至药香大出，然后滤掉药渣趁热服用。病情较重者白天服用3次，夜晚1次；症状轻微者可白天服用2次，夜晚1次。现代也有将原方原量按汤剂方法煎服的用法。仍然是用新鲜芦根煎汤代替水煎药，药液香气大盛时即可去药渣服用，不能过分熬煮。如果服后没有达到理想的效果，则可增量至一日两剂。周身无汗的患者可在服药后加盖厚被，多饮热水发汗，有汗者则无须再发汗。

解表剂煎煮火候的通则：药香大出时即取服，不要过分煎香。

使用注意

1. 某些急性传染性疾病，由于病情发展比较快，所以在初期的表证阶段时间较短暂或不典型，诊断时应加以注意。

2. 有许多急性传染病在初期阶段可表现为表热证，治疗得当可在此阶段痊



愈，但应密切观察病人变化，以防外邪内传转为其他病症，如已经发生转变的须及时改变治法。

临症加減

1. 冬季发病，恶寒较重、无汗，是肌表闭塞严重的反应，方中薄荷、淡豆豉、荆芥等辛温散表的药物可适当加重用量。或者酌量加入苏叶、葱白、防风等药；

2. 夏季发病或多汗者，须减去荆芥；

3. 如有胸脘部位痞闷不舒，舌苔白腻，犯恶欲呕者多兼犯湿邪，可加藿香、佩兰；

4. 口渴严重者，适量添加天花粉。

5. 咽喉疼痛较重，甚者颈项肿痛的，加马勃、玄参、僵蚕、射干、板蓝根等。

6. 出鼻血，去掉荆芥、豆豉，加白茅根、茜草根、侧柏叶、栀子炭等。

7. 发热较重者，可酌情添加黄芩、蒲公英等。

典型案例

张某，男，28岁，日前参加体育活动后出汗，脱衣不慎着凉。现自觉发热怕冷，微恶风寒，头痛咽干，稍有咳嗽，无汗来诊。查体，体温39摄氏度，舌苔薄白，舌尖稍红，脉浮数。银翘散加味：连翘15g，银花15g，苦桔梗6g，薄荷6g，竹叶4g，生甘草5g，荆芥穗4g，淡

豆豉5g，牛蒡子6g，川贝母6g，鲜芦根煮水煎服。

关于感冒

感冒，祖国医学称“伤风”，是由多种病毒引起的一种呼吸道常见病，其中30%~50%是由某种血清型的鼻病毒引起。普通感冒虽多发于初冬，但任何季节，如春天、夏天也可发生，不同季节的感冒的致病病毒并非完全一样。感冒病例分布是散发性的，不引起流行，常易合并细菌感染。普通感冒起病较急，早期症状有咽部干痒或灼热感、喷嚏、鼻塞、流涕，开始为清水样鼻涕，2~3天后变稠，可伴有咽痛；一般无发热及全身症状，或仅有低热、头痛。一般经5~7天痊愈。

感冒是由呼吸道病毒引起的，其中以冠状病毒和鼻病毒为主要致病毒。病毒从呼吸道分泌物中排出并传播，当机体抵抗力下降，如受凉、营养不良、过度疲劳、烟酒过度、全身性疾病及鼻部本身的慢性疾病影响呼吸道畅通时，容易诱发感染。感冒发作后继发细菌感染。感冒起病时鼻内有干燥感及痒感、打喷嚏、全身不适或有低热，以后渐有鼻塞、嗅觉减退、流大量清水鼻涕、鼻粘膜充血、水肿、有大量清水样或脓性分泌物等。若无并发症，病程约为7~10天。

用于治疗感冒的药物有许多种。由

于中成药具有副作用小、疗效好的特点，故很受人们青睐。但临床实践证明，如果中成药选用不当，也可延误病情。中医将感冒分为风寒型感冒、风热型感冒、暑湿型感冒和时行感冒（流行性感冒）四种类型。根据辨证施治的原则，不同类型的感冒应选用不同的中成药治疗。

1. 风寒型感冒：病人除了有鼻塞、喷嚏、咳嗽、头痛等一般症状外，还有畏寒、低热、无汗、流清涕、吐稀薄白色痰等特点。这种感冒与病人感染风寒有关，治疗应以辛温解表为原则。

2. 风热型感冒：病人除了有鼻塞、流涕、咳嗽、头痛等感冒的一般症状外，还有发热重、痰液粘稠呈黄色等特点。治疗应以辛凉解表为原则。

3. 暑湿型感冒：病人表现为畏寒、发热、口淡无味、头痛、头胀、腹痛、腹泻等症状。此类型感冒多发生在夏季，治疗应以清暑、祛湿、解表为主。

4. 时行感冒：病人的症状与风热感冒的症状相似，但较风热感冒病人的症状重。病人可表现为高热、怕冷、寒战、头痛剧烈、肢体酸痛、疲乏无力等症状。治疗应以清热解毒、疏风透表为主。

病名

传染病及流行性疾病引起的高热

中医病名

阳明气热证

症状

阳明气分热盛证。壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力。本方为治阳明气分热盛证的基础方。临床应用以身大热，汗大出，口大渴，脉洪大为辨证要点。

本病仍然属于外感热证，多数是由于表邪内传，全身阳气应激而起对抗外邪，从而形成的里实热证。由于气分实热内盛，所以身有高热、面部红赤，不恶寒而恶热，不喜穿衣盖被。因内热旺盛，迫使津液外泄，故周身大汗出，汗出则津伤，表现为口渴舌燥，脉象洪大而有力，舌苔黄燥、或干而色深，甚至有突出芒刺，这些都是津液受损，里热亢盛的表现。

习惯上把本症的症状表现概括为四大症：身大热、口大渴、汗大出、脉洪大。但是临床诊断上，也无须拘泥于这四项表现，比如肌表毛孔闭塞的话，则也有可能表现为无汗。内伤杂病中，仅表现出口大渴和脉洪大，而没有大热大



汗症状的，诊断为胃热亢盛证的例子也是有的。另外，如果仍兼有表证，那么畏寒、恶风、无汗的情况也可出现。疾病发展到一定阶段，汗出过多，毛孔疏散，人体阳气大规模消耗后劲不足的情况下，也会出现体虚而恶风寒的情况，所以本病辨证诊断要综合全身症状，不要拘泥于某些局部特征。

【用方】

白虎汤——《伤寒论》

方剂说明

清热生津。现用于流行性乙型肝炎、流行性脑脊髓膜炎、大叶性肺炎、夏季热等属于热在气分者。

组成

石膏50g，知母18g，甘草6g，粳米9g。

歌曰：白虎汤膏知甘草粳，气分大热此方。热渴汗出脉洪大，加入人参生气津。

配伍说明

本方原为治阳明经证的主方，后世温病学家又以此为治气分热盛的代表方剂。凡伤寒化热内传阳明之经，或温邪由卫及气，皆能出现本症。里热炽盛，故壮热不恶寒；热灼津伤，乃见烦渴引

饮；里热蒸腾，逼津外泄，则汗出；脉洪大有力，为热盛于经所致。气分热盛，但未致便秘，故不宜攻下；热盛津伤，又不能苦寒直折。唯以清热生津法最宜。方中君药生石膏，辛甘大寒，入肺胃二经，功善清解，透热出表，以除阳明气分之热。

根据现代药理研究表明，白虎汤全方有退热作用，但如果不加石膏则没有退热效果，证实单味石膏本身已经有很快的退热功效，配合知母同用，可以使效果更为持久。知母本身也有抗菌的作用。而甘草可以保护消化道粘膜，并具有肾上腺皮质激素样作用，能够抗炎、抗过敏、镇痛解毒。

方剂制备

方中4味药材取水约2000毫升，煮到米熟，滤出药渣后应剩余约600毫升药液，分3等份，每次取一份温服，一日服用3次。如症状较急较重，可将间隔时间减少到2~3小时。生石膏难溶于水，故用量较一般药材大，必要时最多可用到250g，须医者根据实际情况自行加減。

临症加减

1. 汗吐下后，里热炽盛，而见四大症者；白虎汤证见有背微恶寒，或饮不解渴，或脉浮大而芤，以及暑热病见有身大热属气津两伤者。原方加人参10g，即为白虎加人参汤，可清热、益气、生津。



2. 温疟，其脉入平，身无寒但热，骨节疼烦，时呕。以及风湿热痹，症见壮热，气粗烦躁，关节肿痛，口渴苔白，脉弦数，即为白虎加桂枝汤，原方加桂枝5~9g。可清热、通络、和营卫。

3. 湿温病。身热胸痞，汗多，舌红苔白腻等。以及风湿热痹，症见身大热，关节肿痛等。原方加苍术9g，即成白虎加苍术汤。可清热祛湿。

典型案例

某男，21岁。因食蓖麻油中毒而继发再生障碍性贫血。血红蛋白在4g左右，红细胞200万上下。经常衄血，发热，烦躁，自汗，舌淡红苔薄黄，脉洪大而数，身有瘀斑多处，此起彼伏。此为阳明热盛，淫于血分，迫血妄行。与白虎汤加白茅根、生地。重用石膏45~60g。后期石膏减量，加阿胶调治。

病名

肺炎（大叶性肺炎、支气管肺炎）

中医病名

邪热壅肺证

症状

主要症状为身热不解，咳逆气急鼻煽，口渴，有汗或无汗，舌苔薄白或黄，脉浮而数。本方为治疗表邪未解，邪热壅肺之喘咳的基础方。因石膏倍麻黄，其功用重在清宣肺热，不在发汗，所以临床应用以发热、喘咳、苔薄黄、脉数为辨证要点。

本症属于外感热证，或由于在表的风寒之邪入里化热、风热燥热之邪犯肺，或由热邪直接犯肺，均可引发。肺的主要职责是呼吸，使肺气正常升降，如果肺中热邪壅堵则会导致肺气升降失职，呼吸功能受阻。所以本症除了发热口渴、脉浮苔黄等里热的特征症状之外，还有咳嗽气喘、小儿呼吸鼻翼扇动等呼吸系统不正常的表现。气喘的程度多半可以直接反应肺气郁闭的程度。而发热等里热症状的轻重程度则可反应邪热的轻重程度。外邪与里热有时程度相当，又各有侧重，须临证判断。胸闷胸痛及咳痰是肺热熏蒸津液，灼伤脉络所致，有时则可



见咳铁锈色痰。

本症有汗还是无汗，也与肺气的郁闭状况相关。如郁闭较甚，则往往毛孔不通，表现为无汗；如肺气尚能宣降，毛孔通畅，则表现为有汗。同理，有汗者一般肺部症状较轻，邪热也比较容易透出。

【用方】

麻杏石甘汤

——《伤寒论》

方剂说明

辛凉宣肺，清热平喘。

本方适用于感冒、上呼吸道感染、急性支气管炎、支气管肺炎、大叶性肺炎、支气管哮喘、麻疹合并肺炎等属表证未尽，热邪壅肺者。

组成

麻黄9g，杏仁9g，甘草6g，石膏18g。

歌曰：麻杏石甘药四件，肺热壅盛服后解。

配伍说明

本方证是表邪入里化热，壅遏于肺，肺失宣降所致。风热袭表，表邪不解而入里，或风寒之邪郁而化热入里，邪热充斥内外，故身热不解、汗出、

口渴、苔黄、脉数；热壅于肺，肺失宣降，故咳逆气急，甚则鼻煽。若表邪未尽，可因卫气被郁，毛孔闭塞而无汗；苔薄白，脉浮亦是表证未尽之征。治当辛凉透邪，清热平喘。方中麻黄辛温，开宣肺气以平喘，开腠解表以散邪；石膏辛甘大寒，清泄肺热以生津，辛散解肌以透邪。二药一辛温，一辛寒；一以宣肺为主，一以清肺为主，且俱能透邪于外，合用则相反之中寓有相辅之意，既消除致病之因，又调理肺的宣发功能，共用为君。石膏倍于麻黄，使本方不失为辛凉之剂。麻黄得石膏，宣肺平喘而不助热；石膏得麻黄，清解肺热而不凉遏，又是相制为用。杏仁味苦，降利肺气而平喘咳，与麻黄相配则宣降相因，与石膏相伍则清肃协同，是为臣药。炙甘草既能益气和缓，又与石膏相合而生津止渴，更能调和于寒温宣降之间，为佐使药。四药合用，解表与清肺并用，以清为主；宣肺与降气结合，以宣为主。共成辛凉疏表，清肺平喘之功。麻杏石甘汤与麻黄汤俱用麻黄、杏仁、甘草而治喘咳，但前方主治之喘咳。证属表邪入里化热，壅遏于肺，故以麻黄配石膏，清热宣肺为主，兼以解表祛邪；后方主治之喘咳系风寒束表，肺气失宣所致，故以麻黄配桂枝，相须为用，发汗解表为主，兼以宣肺平喘。二方仅一药之差，功用及主治证病机却大相径庭。



现代药理研究表明，本方的全方煎剂及单味药均具有抗菌抗病毒的功效。麻黄主要舒张支气管平滑肌，有助于平喘，杏仁能镇咳祛痰，两者均兼有利水的作用，有助于消除阻止细胞的炎性水肿。石膏不但止渴利尿，也能解除高热。甘草除了能发挥肾上腺皮质激素类作用调和诸味药材的功效，本身也可祛痰镇痛，消炎脱敏。现代也应用以本方加清热解毒药治疗小叶性肺炎。

方剂制备

水1400毫升，先煎麻黄，沸腾后撇去泡沫，煎至药汤剩余1000毫升左右时加入其余3味药材，当药液剩余约400毫升左右时停火，滤出药渣，平均分成2份，每次1份，1日2次温服。

使用注意

1. 麻杏石甘汤中麻黄与石膏的用量需成比例，可用1:3（邪热闭肺、无汗）或1:5（邪热壅肺、有汗），重用石膏制麻黄之温性，去性存用。

2. 常用于麻疹病发的肺炎、百日咳、白喉、猩红热、急性支气管炎或慢性支气管炎的急性发作。

3. 临床中一般用于呼吸系统的各种感染性疾病，各种肺炎伴喘急内热的尤其有效。

4. 并非所有肺部疾病均适用本方。

5. 使用本方治疗小儿肺炎，对高热喘急等症状的治疗具有比较快速的效果，但是急性病症发展变化比较快，治疗时应密切观察，以防出现危机情况不能及时抢救。

6. 风寒咳喘、痰热壅盛者不适合本方。

临症加减

1. 风水。全身肿，恶风，脉浮，不渴，自汗，无大热者。原方去杏仁加生姜9g，大枣5枚调和营卫即成越婢汤。功用：发汗利水。

2. 身见无汗恶寒者，多为表邪未尽，可加荆芥、豆豉、苏叶、牛蒡子等药物解表。

3. 病人本身素体阴虚或因为邪热耗伤阴津的，酌加北沙参、麦冬、芦根药物清养肺阴。

4. 肺热炙烈，体温较高，吐铁锈色痰或腥臭脓痰的，可加入金荞麦、鱼腥草、虎杖、薏苡仁等药物清肺化痰。

5. 治疗小儿百日咳并发肺炎的，可添加百部、川贝、前胡、天竺黄等药物化痰止咳。

6. 治疗白喉并发肺炎，加金银花、连翘、生地、玄参、黄连、板蓝根等药物清热解毒、养阴润肺。

典型案例

万某，男，10岁，于秋天病发，热而无汗，咳嗽气喘，痰声如锯，喉间满



布白点白块，四肢面目浮肿，舌苔白黄，指纹紫红。投以麻杏甘石汤。处方：麻黄炙至八分，苦杏仁9g（去皮打尖），生甘草9g，生石膏15g（打碎）。水煎急服。

病名

支气管炎

中医病名

痰饮证

症状

中阳不足之痰饮。主要表现为胸胁支满，目眩心悸，短气而咳，舌苔白滑，脉弦滑或沉紧。

脾阳不足，健运失职，则湿滞而为痰为饮。而痰饮随气升降，无处不到，停于胸胁，则见胸胁支满；阻滞中焦，清阳不升，则见头晕目眩；上凌心肺，则致心悸、短气而咳；舌苔白滑、脉沉滑或沉紧皆为痰饮内停之症。

由于水饮停留于中焦，必定影响气机运行，加上水饮又为有形实邪，所以胸胁及胃脘部位撑胀满闷，其中也包括了肺气肿引起桶状胸的情况在内，水饮阻滞于中焦，导致清阳之气不能上升，也可能引起头晕目眩。水饮中阻而导致

胃气不能下行而上逆，呕吐清水痰涎，或者可见胃脘之气上逆于胸。水饮直接犯心，扰乱心神则心悸，上犯于肺，影响肺宣降的功能则导致气喘。同时水饮停于体内，影响阳气敷布，可导致后背有畏寒感。舌苔白滑，脉象弦滑或者沉紧也都是水饮内伏的表现。

本症所见的眩晕与一般的头昏和头重有所不同，多表现为视物旋转，严重则不能睁眼，多伴有明显的恶心或者呕吐，以高血压病、内耳水肿、脑震荡后遗症等所引起的头晕比较多见。本症的咳喘气短多数情况下伴有咳吐多量白色泡沫状的粘痰，常见于慢性气管炎。有些患者会有胃内有液体晃动的自觉症状，有些甚至可以听到水液晃动的声音。

由于胃脘胸胁部位撑胀、眩晕、呕吐、咳喘等症状的病因多种多样，所以要确诊本症需要排除其他原因，诊断时一方面需要注意舌苔的状况，一方面也要随时检查中阳不足、脾失健运的症状以及水饮内停的特征。

【用方】

苓桂术甘汤

——《金匮要略》

方剂说明

温阳化饮，健脾利湿。

可用于耳源性眩晕症，高血压病



导致的眩晕，脑震荡后遗症的眩晕，慢性支气管炎、哮喘，心功能衰竭或者肾炎所导致的水肿、心包积液等，可酌情加减使用。本方对于阳气虚衰而感受风湿导致的关节炎、阳虚低热出汗、尿崩症、神经性口渴也具有一定的临床效果。

组成

茯苓12g，桂枝9g，白术9g，甘草6g。

歌曰：苓桂术甘化饮剂，温阳化饮又健脾。饮邪上逆胸胁满，水饮下行悸眩去。

配伍说明

本方所治痰饮是中阳素虚，脾失健运，气化不利，水湿内停所致。因脾主中州，主管气化，为气机升降之枢纽，若脾阳不足，健运失职，则湿滞而为痰为饮。而痰饮随气升降，无处不到，停于胸胁，则见胸胁支满；阻滞中焦，清阳不升，则见头晕目眩；上凌心肺，则致心悸、短气而咳；舌苔白滑，脉沉滑或沉紧皆为痰饮内停之征。故治当温阳化饮，健脾利水。本方重用甘淡之茯苓为君，健脾利水，渗湿化饮，既能消除已聚之痰饮，又善平饮邪之上逆。桂枝为臣，功能温阳化气，平冲降逆。苓、桂相合为温阳化气，利水平冲之常用组合。白术为佐，功能健脾燥湿，苓、术相须，为健脾祛湿的常用组合，在此体

现了治生痰之源以治本之意；桂、术同用，也是温阳健脾的常用组合。炙甘草用于本方，其用有三：一可合桂枝以辛甘化阳，以襄助温补中阳之力；二可合白术益气健脾，崇土以利制水；三可调和诸药，功兼佐使之用。四药合用，温阳健脾以助化饮，淡渗利湿以平冲逆，全方温而不燥，利而不峻，标本兼顾，配伍严谨，为治疗痰饮病之和剂。

此方服后，当小便增多，是饮从小便而去之征，故原方用法之后有“小便当利”之说。此亦即《金匮要略》“夫短气有微饮者，当从小便去之”之意。

根据现代药理研究结果显示，苓桂术甘汤的成分具有健胃、利尿、镇静、镇痛、强心等多方面的作用。方中的主要药物茯苓的突出作用是利水，不但对炎症具有一定的治疗效果，对肝脏和胃肠道的损伤也有治疗作用。桂枝能扩张血管，改善脏器血液循环。

方剂制备

方中4味，取水约1200毫升，煮至600毫升，去渣滓后。1日3次温服。

使用注意

1. 本方所针对的痰饮，包括痰饮、悬饮、溢饮、支饮，故为“病痰饮者，当以温药和之”之法的代表方。

2. 本方性质偏温，对夹杂有热邪或者本身偏阴虚者不宜投用。



病名

急慢性支气管炎
合并感冒、哮喘、肺气肿

中医病名

表寒内饮证

症状

表寒内饮证。主要表现为恶寒发热，无汗（此为必备症状），胸痞喘咳，痰多而稀；或痰饮喘咳，不得平卧；或身体痛重，头面四肢浮肿（后三者为内饮的证候），舌苔白滑，脉浮。本方是治疗外感风寒，寒饮内停喘咳的常用方。临床应用以恶寒发热，无汗，喘咳，痰多而稀，舌苔白滑，脉浮为辨证要点。因本方辛散温化之力较强，只有确属水寒相搏于肺者，方宜使用，且视病人体质强弱酌定剂量。

由于有风寒在表，所以出现恶寒发热、无汗、头身疼痛等表寒症状。又因有水饮内停，阻遏胸背阳气运行，所以往往有背部恶寒严重的表现。水饮夹杂寒邪阻于肺，必致肺气不能宣降而喘咳。咳吐清稀痰涎为内有水饮停留的征象。水饮如外溢于肌肤，则可导致肢体颜面浮肿；水饮内停则小便不利，小腹作胀。胃中如有水饮内停则胃气易上逆而呕吐。口渴喜热饮，苔薄均为寒饮内

3. 本方虽然有健脾之功效，但是毕竟为驱除水饮而设，对于肝肾不足，气血双亏而引起的眩晕、水肿以及风寒痰热、肺虚等引起的相关咳喘诸证均起不到相应的作用。

临证加減

1. 呕吐痰涎较多者，加法半夏、陈皮；

2. 眩晕比较严重者，加入明天麻、法半夏、陈皮、白果等；

3. 脾虚严重的患者，加党参；

4. 兼有肌肤水肿表现者，加入乌蛇、威灵仙、羌活等。

实例练习

袁某，男，34岁。素有咳嗽，屡治屡发，难获远效。近因伤风，旧病复发，咳唾清痰，头晕目眩，胸胁胀满，口淡食少，心下如有物跳动，背部如掌大之处怕冷特甚，脉沉细而弦，舌嫩苔白滑，呼吸短浅难续，尿清量少，大便自调。诊断此症属饮停中焦，治宜温阳化饮，用本方原方煎汤内服。



停的表现。在临床上，对本症的诊断尤以咳喘、痰多而清稀或多泡沫为主要依据，至于发热则可有可无。其中恶寒一症可以由表症引起，也可无表症而由阳气被水饮遏制所致。因而本症即可见于外感病，也可以见于慢性病和各种内伤杂病中，不必拘于表里。

【用 方】

小青龙汤

——《伤寒论》

方剂说明

解表散寒，温肺化饮。

适用于支气管炎、支气管哮喘、肺炎、百日咳、肺心病、过敏性鼻炎、卡他性眼炎、卡他性中耳炎等属于外寒里饮证者。

组 成

麻黄去节9g，芍药9g，细辛6g，干姜6g，炙甘草6g，桂枝去皮9g，半夏9g，五味子6g。

歌曰：小青龙汤最有功，风寒束表饮停胸，辛夏甘草和五味，姜桂麻黄芍药同。

配伍说明

本方主治外感风寒，寒饮内停之症。风寒束表，皮毛闭塞，卫阳被遏，

营阴郁滞，故见恶寒发热、无汗、身体疼痛。素有水饮之人，一旦感受外邪，每致表寒引动内饮，《难经·四十九难》说：“形寒饮冷则伤肺。”水寒相搏，内外相引，饮动不居，水寒射肺，肺失宣降，故咳喘痰多而稀；水停心下，阻滞气机，故胸痞；饮动则胃气上逆，故干呕；水饮溢于肌肤，故浮肿身重；舌苔白滑，脉浮为外寒里饮之佐证。对此外寒内饮之证，若不疏表而徒治其饮，则表邪难解；不化饮而专散表邪，则水饮不除。故治宜解表与化饮配合，一举而表里双解。方中麻黄、桂枝相须为君，发汗散寒以解表邪，且麻黄又能宣发肺气而平喘咳，桂枝化气行水以利里饮之化。干姜、细辛为臣，温肺化饮，兼助麻、桂解表祛邪。然而素有痰饮，脾肺本虚，若纯用辛温发散，恐耗伤肺气，故佐以五味子敛肺止咳、芍药和营养血，二药与辛散之品相配，一散一收，既可增强止咳平喘之功，又可制约诸药辛散温燥太过之弊；半夏燥湿化痰，和胃降逆，亦为佐药。炙甘草兼为佐使之药，既可益气和中，又能调和辛散酸收之品。药虽八味，配伍严谨，散中有收，开中有合，使风寒解，水饮去，宣降复，则诸症自平。

根据现代药理研究结果显示，小青龙汤可以缓解支气管平滑痉挛，有抗组胺作用；方中麻黄与芍药配合，能解除支气管的痉挛；半夏、麻黄、甘草可以



祛痰止咳；桂枝又可以促进血液循环，改善血行；五味子可镇咳，增强肾上腺皮质功能。

方剂制备

8味药用水约2000毫升，先加入麻黄煮至剩余药液约1600毫升时，加入其他药材，最后煮取600毫升左右药液，滤去药渣，分3次温服。

使用注意

1. 因本方多温燥之品，故阴虚干咳无痰或痰热证者，不宜使用。
2. 本症原无口渴症状，因服药而出现口渴者，是水饮将去的表现，不一定是化热之象，须进行区别。

临症加减

1. 水饮郁结而表症不明显，咳而上气，喉中有水鸡声者，可加射干、生姜、紫菀、款冬花、大枣等以宣肺祛痰，下气止咳。
2. 表实而无汗者，可用生麻黄，并去芍药。
3. 表虚有汗者，可用蜜炙麻黄。
4. 有咳喘而不发热者，可用蜜炙麻黄，去桂枝。
5. 肺气久虚而咳者，五味子加量，同时用蜜炙干姜补肺气。
6. 水饮郁久化热，口渴痰黄稠，苔黄脉数者，可加石膏。

7. 水饮夹杂寒气而喘噎者，可加附子。

8. 水饮内阻而小腹胀满、小便不利者，可加茯苓。

典型案例

徐某，男，26岁。平素好酒，病喘满短气，胁连腰痛，有汗，脉弦细而沉，舌苔白滑而厚，恶风寒，喘息不能平躺。诊断内饮招外风为病，处方：桂枝18g，干姜9g，杏仁15g，炒白芍12g，生姜9g，半夏18g，炙甘草3g，制五味4.5g，旋覆花9g，水煎服。

病名

咳嗽

中医病名

外感咳嗽

症状

风邪犯肺证。咳嗽咽痒，咯痰不爽，或微有恶风发热，舌苔薄白，脉浮缓。本方为治疗表邪未尽，肺气失宣而致咳嗽的常用方。临床应用以咳嗽咽痒，微恶风发热，苔薄白为辨证要点。



【用方】 止嗽散——《医学心悟》

方剂说明

宣利肺气，疏风止咳。

适用于上呼吸道感染、支气管炎、百日咳等属表邪未尽、肺气失宣者。

组成

桔梗炒、荆芥、紫菀蒸、百部蒸、白前蒸各9g，甘草炒3g，陈皮去白6g。

歌曰：止嗽散内用桔梗，紫菀荆芥百部陈，白前甘草共为末，姜汤调服止嗽频。

配伍说明

本方治证为外感咳嗽，经服解表宣肺药咳仍不止者。风邪犯肺，肺失清肃，虽经发散，因解表不彻而其邪未尽，故仍咽痒咳嗽，此时外邪十去八九，故微有恶风发热。治法重在理肺止咳，微加疏表之品。方中紫菀、百部为君，两药味苦，都入肺经，其性温而不热，润而不膩，皆可止咳化痰，对于新久咳嗽都能使用。桔梗味苦辛而性平，善于开宣肺气；白前味辛甘性平，长于降气化痰。两者协同，一宣一降，以复肺气之宣降，增强君药止咳化痰之力，为臣药。荆芥辛而微温，疏风解

表，以祛在表之余邪；陈皮理气化痰，均为佐药。甘草调和诸药，合桔梗又有利咽止咳之功，是为佐使之用。综观全方，药虽七味，量极轻微，具有温而不燥、润而不膩、散寒不助热、解表不伤正的特点。正如《医学心悟》卷三中所说：“本方温润和平，不寒不热，既无攻击过当之虞，大有启门驱贼之势。是以客邪易散，肺气安宁。”故对于新久咳嗽，咯痰不爽者，加减运用得宜，均可获效。

方剂制备

上为末。每服9g，食后、临卧开水调下；初感风寒，生姜汤调下（现代用法：共为末，每服6~9g，温开水或姜汤送下。亦可作汤剂，水煎服，用量按原方比例酌减）。

使用注意

阴虚劳嗽或肺热咳嗽者，不宜使用。

临症加减

1. 伤风咳嗽，恶寒发热，咳嗽痰多，鼻塞流涕，舌苔白膩，脉浮者，可用金沸草散：旋覆花、麻黄、前胡各9g，荆芥穗12g、甘草、半夏、赤芍各3g，外加生姜三片，枣一枚以发散风寒，降气化痰；

2. 外感风热之邪导致咳嗽、咽痒、痰稠、舌红苔黄者，可加金银花、连翘、牛



芎子、芦根等；

3. 外感风寒表症明显者，可加苏叶、杏仁、防风等；

4. 外感暑热而身重头重，咳嗽、胸脘痞满、心烦、苔白腻者，可加藿香、佩兰、大豆卷等；

5. 兼有恶寒、无汗、身疼痛拘急者，可加瓜蒌皮、枇杷叶、贝母、梨皮等。

典型案例

王某，男12岁，学生。2月前因外感起病，至今咳嗽不止，咯痰不爽，面色无华，脉细，苔薄白。当用止嗽散法，温润和平，止咳化痰。方用：荆芥6g，炙紫菀9g，百部9g，白前9g，桔梗4.5g，生甘草3g，化橘红4.5g，象贝9g，杏仁9g，水煎服。

病名

哮喘

中医病名

哮喘

症状

哮喘。咳嗽痰多气急，痰稠色黄，微恶风寒，舌苔黄腻，脉滑数。本方亦为降气平喘之常用方，用于素体痰多，

复感风寒，致肺气壅闭之喘咳证。临床应用以哮喘咳嗽，痰多色黄，微恶风寒，苔黄腻，脉滑数为辨证要点。

【用方】

定喘汤

——《摄生众妙方》

方剂说明

宣肺降气，清热化痰。

适用于支气管哮喘、慢性支气管炎等属痰热壅肺者。

组成

白果9g，麻黄9g，苏子6g，款冬花9g，杏仁9g，桑白皮6g，黄芩6g，半夏9g，甘草3g。

歌曰：定喘白果与麻黄，款冬半夏白皮桑，苏杏黄芩兼甘草，外寒痰热哮喘尝。

配伍说明

本方证因素体多痰，又感风寒，肺气壅闭，不得宣降，郁而化热所致。症见哮喘咳嗽，痰多色黄，质稠不易咳出等。治宜宣肺降气，止咳平喘，清热祛痰。方用麻黄宣肺散邪以平喘，白果敛肺定喘而祛痰，共为君药，一散一收，既可加强平喘之功，又可防麻黄耗散肺气。苏子、杏仁、半夏、



款冬花降气平喘，止咳祛痰，共为臣药。桑白皮、黄芩清泄肺热，止咳平喘，共为佐药。甘草调和诸药为使。诸药合用，使肺气宣降，痰热得清，风寒得解，则喘咳痰多诸症自除。本方与苏子降气汤均为降气平喘之常用方。本方以麻黄、白果与黄芩、苏子配伍，组成宣肺散寒，清热化痰，降气平喘之剂；苏子降气汤以苏子降气平喘为君药，配以下气祛痰之品，更用肉桂温肾纳气，当归气病调血，用以治“上实下虚”之喘咳，但以上实为主。平素有热痰，又感风寒邪气，内外合邪，表里同病。

方剂制备

水三盅，煎二盅，作二服，每服一盅，不用姜，不拘时候，徐徐服。

现在制备方法：取水1500毫升，将药材放入、煎至水量约为1000毫升时即可。分作两次服用，服药时不易过快。

使用注意

若新感风寒，虽恶寒发热、无汗而喘，但内无痰热者；或哮喘日久，肺肾阴虚者，皆不宜使用。

临症加减

1. 痰热较甚、咳吐黄稠粘痰、口干苦而渴、舌质红者，可加全瓜蒌、金荞麦、鱼腥草、冬瓜仁等。

2. 如痰湿壅盛，喉中痰鸣，但热象

不明显，可去黄芩、桑白皮，加射干、厚朴等。

实例练习

李某，女，21岁，喘作三天。患者自述：3岁患麻疹后遂发哮喘，迄今18年，每于夏凉后反复发作，前天哮喘又发，夜间不能平卧，喉间痰鸣如扯锯，痰黄稠而难咳出，伴有寒热，咳嗽胸闷。诊得舌质红苔黄腻，脉象滑数。体温：37.6℃，心率80次/分，律齐。两肺满布哮鸣音。放射线胸透：两肺透亮度增加，横膈下降，肋间隙增宽。诊断证属哮喘，风寒外束，痰热内蕴。治宜宣肺降逆，清化痰热，处方：白果肉6g，麻黄5g，杏仁10g，甘草6g，苏子10g，半夏10g，款冬花10g，桑白皮12g，黄芩12g，水煎服。

病名

各种类型肺炎及肺癌

中医病名

咳血

症状

肝火犯肺之咳血证。主要表现为咳嗽痰稠带血，咳出不爽，心烦易怒，



胸胁作痛，咽干口苦，颊赤便秘，舌红苔黄，脉弦数。本方为治疗肝火犯肺之咳血证的常用方。临床应用以咳嗽痰带血，胸胁作痛，舌红苔黄，脉弦数为辨证要点。

【用方】 咳血方——《丹溪心法》

方剂说明

清肝宁肺，凉血止血。

适用于支气管扩张、肺结核等咳血属肝火犯肺者。

组成

青黛6g，瓜蒌仁9g，海粉（海浮石）9g，栀子9g，生诃子6g。

歌曰：咳血方中诃子收，海粉山栀共瓜蒌，青黛泻肝凉血热，咳嗽痰血此方投。

配伍说明

本方证系肝火犯肺，灼伤肺络所致。肺为清虚之脏，木火刑金，肺津受灼为痰，清肃之令失司，则咳嗽痰稠、咳出不爽；肝火灼肺，损伤肺络，血渗上溢，故见痰中带血；肝火内炽，故心烦易怒、胸胁作痛、咽干口苦、颊赤便秘；舌红苔黄，脉弦数为火热炽盛之征。此证病位虽在肺，但病本则在肝。按治病求本的原则，治当清

肝泻火，使火清气降，肺金自宁。方中青黛咸寒，入肝、肺二经，清肝泻火，凉血止血；山栀子苦寒，入心、肝、肺经，清热凉血，泻火除烦，炒黑可入血分而止血，两药合用，澄本清源，共为君药。火热灼津成痰，痰不清则咳不止，咳不止则血难宁，故用瓜蒌仁甘寒入肺、清热化痰、润肺止咳；海粉（现多用海浮石）清肺降火，软坚化痰，共为臣药。诃子苦涩、性平，入肺与大肠经，清降敛肺，化痰止咳，用以为佐。诸药合用，共奏清肝宁肺之功，使木不刑金，肺复宣降，痰化咳平，其血自止。本方的配伍特点：寓止血于清热泻火之中，虽不专用止血药，火热得清则血不妄行，为图本之法。

方剂制备

共研末为丸，每服9g；亦可作汤剂，水煎服，用量按原方比例酌定。

使用注意

因本方属寒凉降泄之剂，故肺肾阴虚及脾虚便溏者，不宜使用。

临症加減

1. 肺热壅盛而身热咳喘者，可配合使用金银花、连翘、鱼腥草、虎杖等药清热解毒。

2. 咳势剧烈而痰少难咳者，可加杏仁、浙贝母、枇杷叶、天竺黄、南沙参等。

3. 伴有肺阴耗伤者，可加入北沙参、麦冬。

4. 久虚者，可加百合、阿胶珠。

5. 出血较多者，可加白芨、三七或混入云南白药。

典型案例

洪某，女，60岁。患者每日咳血5~20口，咳嗽，胸胁胀痛满闷约1月。该患者少量、反复咳血病史十余年。曾以胸部平片、支气管碘油造影及体征诊断为“支气管扩张”。每次病情发作与季节、气候无关系，但遇怒及情志不遂后，往往要咯血，小量咯血常持续数月。1月前因大怒后，即觉胸闷，频咳阵阵，牵连胸胁胀痛，随之咳出鲜血约100毫升。抢救给予脑垂体后叶素10U静脉注射后，大咯血止。但每日晨起咳血5~20口不等。曾用卡巴克洛（安络血）、维生素K3、青霉素、可待因等止血、抗炎、镇咳，血量仍不见减少，有时咳血量还增加。至今患者常为咳血不止所苦，同时伴有心烦、性情急躁等症。舌质红，苔微黄，脉弦数。血压：170/100mmHg。胸部听诊：右肺下可见小水泡音。胸片示：右肺下纹理增粗、紊乱，散在边缘不清的点状阴影。诊断：咳血（肝火犯肺型），处方：瓜蒌20g，诃子、山梔、海浮石、麦冬各15g，丹皮10g，青黛5g，冲3剂，水煎服。

病名

大叶性肺炎、肺部肿瘤

中医病名

肺 痈

症状

肺痈。身有微热，咳嗽痰多，甚则咳吐腥臭脓血，胸中隐隐作痛，舌红苔黄腻，脉滑数。本方为治肺痈的常用方剂，不论肺痈将成或已成，均可使用本方。临床应用以胸痛，咳嗽，吐腥臭痰或吐脓血，舌红苔黄腻，脉数为辨证要点。

【用 方】

苇茎汤——

《外台秘要》引《古今录验方》

方剂说明

清肺化痰，逐瘀排脓。

适用于肺脓肿、大叶性肺炎、支气管炎、百日咳等属肺热痰瘀互结者。

组 成

苇茎60g，薏苡仁30g，冬瓜仁24g，桃仁9g。

歌曰：苇茎汤出千金方，桃仁薏苡



冬瓜仁，肺痈痰热兼瘀血，化浊排脓病自宁。

配伍说明

本方所治之肺痈是由热毒壅肺，痰瘀互结所致。痰热壅肺，气失清肃则咳嗽痰多。《内经》说：“热盛则肉腐，肉腐则成脓”，邪热犯肺，伤及血脉，致热壅血瘀，若久不散则血败肉腐，乃成肺痈；痈脓溃破，借口咽而出，故咳吐腥臭黄痰脓血；痰热瘀血，互阻胸中，因而胸中隐痛；舌红苔黄腻，脉滑数皆痰热内盛之象。治当清肺化痰，逐瘀排脓。方中苇茎甘寒轻浮，善清肺热，《本经逢源》谓：“专于利窍，善治肺痈，吐脓血臭痰”，为肺痈必用之品，故用以为君。冬瓜仁清热化痰，利湿排脓，能清上彻下，肃降肺气，与苇茎配合则清肺宣壅，涤痰排脓；薏苡仁甘淡微寒，上清肺热而排脓，下利肠胃而渗湿，二者共为臣药；桃仁活血逐瘀，可助消痈，是为佐药。方仅四药，配伍严谨，药性平和，共具清热化痰、逐瘀排脓之效。用于肺痈脓未成者，服之可使消散；脓已成者，可使肺热清，痰瘀化，脓液外排，痈渐向愈。方中苇茎一药，现代临床上多用芦根，而很少用茎，这是古今用药习惯不同导致的。方中瓜瓣一药，《张氏医通》认为，“瓜瓣即甜瓜子”，因其功用近似，后世常以冬瓜子代瓜瓣。

方剂制备

口父咀，内苇汁中，煮取二升，服一升，再服，当吐如脓（现代用法：水煎服）。

临症加减

1. 未成脓者，可加鱼腥草、黄连、黄柏、栀子、黄芩、红藤、金荞麦、败酱草等。

2. 已化脓，咳腥臭痰或突然咳吐大量痰及脓血者，可加浙贝母，重用桔梗、葶苈子、败酱草、金荞麦等以清热化瘀排脓。

典型案例

万某，女，34岁。患肺痈，病已危急，病者喘剧烈，多吐五花脓痰，已一周。靠坐不得卧，面部微肿，眼珠外突，喘如曳锯，胸前拒按，烦郁胀闷，脉劲数，时或一止，参伍不调。诊断为肺痈，处方：苦葶苈18g，苡仁15g，瓜瓣24g，桃仁9g，鲜竹沥24g，鲜苇茎250g，水煎急服。

《高士王常杜中醫神書》

中醫秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

中者、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

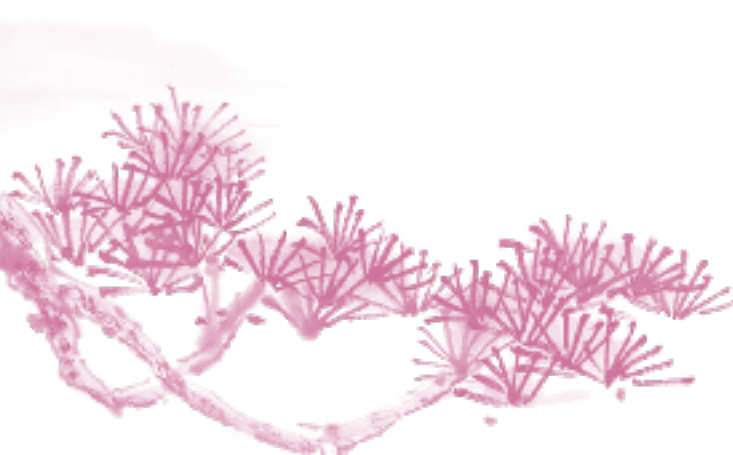
秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方



第三章

消化系统疾病

本書上中冊杜中醫視毒、
視民視中醫視方、脈方、
視方等視方圖的視方中詩
視方中貴視常見視視四
視方，共視而百餘方。視
視方古今視多名方、視
視方，不勝易視、易
視方、指錄指集，而上
視方，對某些視視視
視方是視不視視懷視，視
視方，是視合廣大中視
視方視用。

這些視方大視分視四大
一視經視方，二視食視
三視中視藥視方，四
視方用視方，五視日常
視方，并視經視方視

病名

胃肠型感冒、急性胃肠炎、中毒性消化不良、病毒性肝炎

中医病名

表湿证

症状

外感风寒，内伤湿滞证。主要表现为霍乱吐泻，恶寒发热，头痛，脘腹疼痛，舌苔白腻，以及山岚瘴疟等。藿香正气散主治外感风寒，内伤湿滞证。临床应用以恶寒发热，上吐下泻，舌苔白腻为辨证要点。

由于湿邪侵犯体表，邪正抗争，湿邪与风寒之邪夹杂，阻遏人体卫阳之气，故可见发热、恶寒等症状，且多数患者无汗。湿邪属于阴性病邪，性质重浊粘腻，困于人体表面后，造成体表血运不畅，卫阳失调，所以肢体不灵活，困重酸楚。湿邪内阻于脾胃，导致脏腑气机不畅，消化器官升降功能失常，就会出现胸脘满闷、脘腹疼痛、恶心呕吐、肠鸣腹泻等症状。呕吐物一般是胃内未消化完的食物残渣，腹泻的排泄物一般是稀薄的粪便，粪水夹杂或黄色稀水，一般没有脓血，也不会散发出刺鼻气味，肛门处也没有灼热感，可以与湿热内蕴导致的痢疾腹泻相

鉴别。与吐泻呈现米泔水样的霍乱也应该注意鉴别诊断。

本病既有表证症状，也有胃肠道等消化系统症状，没有明显热象，多发于夏秋季节。这与人们在夏秋季节生活习惯不佳，贪凉饮冷，露宿生食以及气候潮湿都有一定的关系。

【用方】

藿香正气散

——《太平惠民和剂局方》

方剂说明

解表化湿，理气和中。

常用于急性胃肠炎或四时感冒属湿滞脾胃，外感风寒者。

组成

大腹皮、白芷、紫苏、茯苓各5g，半夏曲、白术、陈皮、厚朴、桔梗各10g，藿香15g，炙甘草12g。

歌曰：藿香正气大腹苏，甘桔陈苓术朴俱。夏曲白芷加姜枣，感伤岚瘴并能驱。

配伍说明

本方主治外感风寒，内伤湿滞证，为夏月常见病症。风寒外束，卫阳郁遏，故见恶寒发热等表证；内伤湿滞，湿浊中阻，脾胃不和，升降失常，则为上吐下



泻；湿阻气滞，则胸膈满闷、脘腹疼痛。治宜外散风寒，内化湿浊，兼以理气和中之法。方中藿香为君，既以其辛温之性而解在表之风寒，又取其芳香之气而化在里之湿浊，且可辟秽和中而止呕，为治霍乱吐泻之药。半夏曲、陈皮理气燥湿，和胃降逆以止呕；白术、茯苓健脾运湿以止泻，共助藿香内化湿浊而止吐泻，俱为臣药。湿浊中阻，气机不畅，故佐以大腹皮、厚朴行气化湿，畅中行滞，且寓气行则湿化之义；紫苏、白芷辛温发散，助藿香外散风寒，紫苏尚可醒脾宽中，行气止呕，白芷兼能燥湿化浊；桔梗宣肺利膈，既益解表，又助化湿；煎用生姜、大枣，内调脾胃，外和营卫。使以甘草调和药性，并协姜、枣以和中。诸药合用，外散风寒与内化湿滞相伍，健脾利湿与理气和胃共施，使风寒外散，湿浊内化，气机通畅，脾胃调和，清升浊降，则霍乱自己。感受山岚瘴气及水土不服者，亦可以本方辟秽化浊，和中悦脾而治之。

现代药理研究表明，藿香所含有的成分对多种病毒及细菌有抑活作用，同时可以促进胃液分泌，对增强消化能力也有帮助，是一味治疗胃肠型感冒的常用药物；厚朴也是一味广谱抗菌药材，能松弛肌肉，对肠道和支气管有兴奋作用；茯苓的突出作用是利尿，不但对炎症具有一定的治疗效果，对肝脏和胃肠道的损伤也有作用；紫苏有一定的解热作用；

桔梗则主要祛痰，对呼吸系统的炎症有镇静作用；白芷也可以抗菌解表；甘草能缓解平滑肌痉挛，消炎抗过敏；生姜能增强血液循环，对肠道也有兴奋作用。这些药物按照一定比例配合作用，则可解热抗菌消炎，调节胃肠道功能，适合用来治疗呼吸道和消化道疾病。

方剂制备

各味药材研为细末，一次取混合粉末6g，加入姜枣，共用水煎，趁热服用。本方为解表之剂，勿过煮，要保证发挥药力，药用冷水先泡1小时，间隔4个小时吃第二煎。第一煎服完后身发燥，服第二煎后，则汗出，病乃解。药量不少于250~300毫升。

使用注意

1. 本方是治疗外感病的常用方剂，多用于夏季的胃肠型病毒性感冒，也能治疗急性胃肠炎、肠伤寒初期，以及小儿腹泻，传染性肠炎等疾病，对其他疾病患者出现中寒、湿阻、气滞等相关证候的也有一定治疗效果。现在也常以丸剂或口服液等制剂形式的中成药出现。

2. 本症既可因夏秋季节胃肠型感冒引发，也可见于其他传染性疾病初期阶段，要关注湿邪的转化和去留，变化情况不可忽视。本方性偏燥热，不适合湿热之邪引发的病症，临床应用时要加以关注。

临症加减

1. 表邪较重，表现出恶寒甚至外邪束表而无汗，骨节肌肉酸痛明显的，重用香薷以发汗解表和中。

2. 宿食停滞，脘腹胀痛，吐泻物酸臭气味较重的，可加神曲莱菔消食导滞。

3. 腹泻严重的且以黄色稀水为主的，可加薏苡仁、车前子、泽泻等药物健脾利水而止泻。

典型案例

刘某，男，25岁。夏夜露天乘凉，第二天上午开始自觉身体不适，恶寒发热，午后开始恶心呕吐、腹痛腹泻，排黄色稀水样便数次。查体腹部平坦柔软，有轻度压痛，无反跳痛，心肺功能正常，体温39摄氏度。舌苔薄白微腻，口中淡而不渴。诊断表湿证，处方：大腹皮5g，白芷5g，紫苏5g，茯苓5g，半夏曲10g，白术10g，陈皮10g，厚朴10g，桔梗10g，藿香15g，炙甘草12g，薏苡仁9g，车前子9g，水煎服。

病名

疟疾、急性病毒性肝炎（急性胰腺炎、急性胆囊炎等）

中医病名

邪在少阳证

症状

伤寒少阳证。主要表现为恶寒发热交替进行，胸胁胀满而苦，默默不欲饮食，心烦喜呕，呕后觉舒，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦者。另有妇人热入血室胞宫，经水适断，有时寒热发作，以及疟疾、黄疸等病而见少阳证者。本方为治疗伤寒少阳证的基础方，又是和解少阳法的代表方。临床应用以寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕为辨证要点。临床上只要抓住前四者中的一二主证，便可用本方治疗，不必待其证候悉具。正如《伤寒论》所说：“伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。”

本症源于正邪之气相争于胆经，部位既非表又非里，故也称为半表半里证。如对抗中病邪占优势，则表现为阳气被抑制而恶寒；如人体阳气较为强大，则恶寒解而发热明显。而人体卫阳之气周身运行有定时，则正邪力量对比也随时变化，在症状中就表现出有特征



性的定时寒热交替，或称为寒热往来。少阳胆经的循行路线遍布胸胁，少阳之邪使胆经气机不畅，则发为胸胁胀满疼痛，也表现为某一侧或者双侧的胀痛。而邪气在胆，常可犯胃，胃气不平则上逆为呕，且不进饮食。心烦口苦，视物不明皆为胆经热象。

【用方】

小柴胡汤

——《伤寒论》

方剂说明

和解少阳。

适用于感冒、流行性感冒、疟疾、慢性肝炎、肝硬化、急慢性胆囊炎、胆结石、急性胰腺炎、胸膜炎、中耳炎、产褥热、急性乳腺炎、睾丸炎、胆汁返流性胃炎、胃溃疡等属邪踞少阳，胆胃不和者。

组成

柴胡24g，黄芩9g，人参9g，甘草炙6g，半夏9g，生姜9g，大枣4枚。

歌曰：小柴胡汤和解供，半夏人参甘草从，更用黄芩加姜枣，少阳百病此为宗。

配伍说明

本方为和解少阳的代表方剂。少

阳经脉循胸布胁，居于太阳、阳明表里之间。伤寒邪犯少阳，邪正相争，正胜欲拒邪出于表，邪胜欲入里并于阴，故往来寒热。足少阳之脉起于目锐眦，其支者，下胸中，贯膈，络肝，属胆，循胁里。邪在少阳，经气不利，郁而化热，胆火上炎，而致胸胁苦满、心烦、口苦、咽干、目眩；胆热犯胃，胃失和降，气逆于上，故默默不欲饮食而喜呕；若妇人经期，感受风邪，邪热内传，热与血结，血热瘀滞，疏泄失常，故经水不当断而断、寒热发作有时。邪在表者，当从汗解；邪入里者，则当吐下。今邪既不在表，又不在里，而在表里之间，则非汗、吐、下所宜，故唯宜和解之法。方中柴胡苦平，入肝胆经，透泄少阳之邪，并能疏泄气机之郁滞，使少阳半表之邪得以疏散，为君药。黄芩苦寒，清泄少阳半里之热，为臣药。柴胡之升散，得黄芩之降泄，两者配伍，是和解少阳的基本结构。胆气犯胃，胃失和降，佐以半夏、生姜和胃降逆止呕；邪从太阳传入少阳，缘于正气本虚，故又佐以人参、大枣益气健脾，一者取其扶正以祛邪，一者取其益气以御邪内传，俾正气旺盛，则邪无内向之机。炙甘草助参、枣扶正，且能调和诸药，为使药。诸药合用，以和解少阳为主，兼补胃气，使邪气得解，枢机得利，胃气调和，则诸症自除。原方“去滓再煎”，使药性更为醇和，药汤之量



更少，减少了汤液对胃的刺激，避免停饮致呕。小柴胡汤为和剂，一般服药后不经汗出而病解，但也有药后得汗而愈者，这是正复邪却，胃气调和所致。正如《伤寒论》所说：“上焦得通，津液得下，胃气因和，身濇然汗出而解。”若少阳病证经误治损伤正气，或患者素体正气不足，服用本方，亦可见到先寒战后发热而汗出的“战汗”现象，属正胜邪却之征。

根据现代药理研究结果，小柴胡汤除了解热之外，还可以促进胆汁分泌，保护肝脏细胞等。方中单味药物药理研究结果如下：柴胡能镇静止痛，止咳消炎，同时对肝脏细胞有保护作用；黄芩除了对病毒细菌有抑活作用外，也能降低毛细血管通透性及提高人体免疫力，与柴胡配合协同使用能解热利胆，对缓解平滑肌的痉挛也有效果；人参能提高人体综合防御能力，抗疲劳氧化，兴奋中枢神经系统，与甘草和生姜配合使用还能改善消化系统功能的异常；半夏则对咳嗽呕吐都有治疗和缓解的作用。综合来看，小柴胡汤配方全面严谨，对消化、神经、免疫系统症状都有一定的治疗效果。

方剂制备

全方加水约2400毫升，煮至剩余一半左右后去除药渣，再继续熬取剩余汤量的一半，分3份，每次1份，1日3次服用。

使用注意

1. 本方主治少阳病症。
2. 可以治疗偏头痛此为少阳经之分布，耳鸣如钟如潮、耳聋等症。
3. 本方临床上适用于肠伤寒、流感、急慢性胆囊炎、败血症、肋间神经痛、疟疾、湿疹等各种疾病出现寒热往来、胸胁苦满、口苦咽干等少阳症状者。
4. 少阳证病邪非表非里，治疗时不可汗吐下，否则徒伤正气津血，于病无益。

临症加减

1. 患者脘腹有热，午后潮热，大便秘结，可加芒硝，成柴胡加芒硝汤。
2. 全身疼痛，手足沉重，汗多热少，脉象见濡滑的湿证疟疾，或少阳疾病兼见湿热内蕴者，表现为腹痛恶心，低烧呕吐，大便稀溏的，均可用本方与平胃散合用。
3. 产后身体虚弱，感受外邪造成邪入少阳经出现寒热往来，恶露不尽者，可加当归、丹参、益母草、荆芥炭。
4. 邪在少阳，但是热甚而有痰湿，寒热起伏如发疟疾，寒轻热重的，亦可用蒿芩清胆汤，用青蒿代替柴胡配合黄芩清少阳胆热。

典型案例

胡某，女，38岁，发热恶寒来诊，经查下午发潮热，高时可达39摄氏度。



其他证见乏力恶心，口苦欲呕，食欲不佳，左胁胀痛。体检肝脏有肿大压痛。诊断为邪在少阳证，处方：柴胡24g，黄芩9g，人参9g，甘草炙6g，半夏9g，生姜9g，大枣4枚，水煎服。

病名

肝炎、急性胰腺炎（急慢性肝胆系统疾病、内伤杂病）

中医病名

少阳阳明证

症状

少阳阳明证。主要表现为往来寒热，胸胁苦满，呕不止，郁郁微烦，心下痞硬，或心下满痛，大便不解或热结旁流，舌苔黄，脉弦数有力。本方为治疗少阳阳明合病的常用方。临床应用以往来寒热，胸胁苦满，心下满痛，呕吐，便秘，苔黄，脉弦数有力为辨证要点。

本证的特征性表现是在少阳证的同时，出现心下痞痛，或者胸脘满胀拒按，大便状况不正常，或秘结不便，或热结旁流。心下痞痛，坚实拒按，其实部位是胃肠肝胆处，局部肌肉多紧张，疼痛，并且有压痛，也可能出现反跳痛。心下一侧或两侧位置都有可能。中医理论证明，这是由于病邪深入阳明导

致的阳明热结，故称之为少阳阳明证。阳明内结之后，腑气不通，胃失和降而致呕不止。

【用方】

大柴胡汤

——《金匱要略》

方剂说明

和解少阳，内泻热结。

适用于急性胰腺炎、急性胆囊炎、胆石症、胃及十二指肠溃疡等属少阳阳明合病者。

组成

柴胡12g，黄芩9g，芍药9g，半夏9g，生姜15g，枳实9g，大枣4枚，大黄6g。

歌曰：大柴胡汤用大黄，枳实芩夏白芍将。煎加姜枣表兼里，妙法内攻并外攘。

配伍说明

本方系小柴胡汤去人参、甘草，加大黄、枳实、芍药而成，亦是小柴胡汤与小承气汤两方加减合成，是和解与泻下并用的方剂。小柴胡汤为治伤寒少阳病的主方，因兼阳明腑实，故去补益胃气之人参、甘草，加大黄、枳实、芍药以治疗阳明热结之证。因此，本方主



治少阳阳明合病，仍以少阳为主。症见往来寒热、胸胁苦满，表明病变部位仍未离少阳；呕不止与郁郁微烦，则较小柴胡汤证之心烦喜呕为重；再与心下痞硬或满痛、便秘或下利、舌苔黄、脉弦数有力等结合考虑，说明病邪已进入阳明，有化热成实的热结之象。在治法上，病在少阳，本当禁用下法，但与阳明腑实并见的情况下，就必须表里兼顾。《医方集解》说：“少阳固不可下，然兼阳明腑实则当下。”方中重用柴胡为君药，配臣药黄芩和解清热，以除少阳之邪；轻用大黄配枳实以内泻阳明热结，行气消痞，为臣药。芍药柔肝缓急止痛，与大黄相配可治腹中实痛，与枳实相伍可以理气和血，以除心下满痛；半夏和胃降逆，配伍大量生姜，以治呕逆不止，共为佐药。大枣与生姜相配，能和营卫而行津液，并调和脾胃，功兼佐使。总之，本方既不悖于少阳禁下的原则，又可和解少阳，内泻热结，使少阳与阳明合病得以双解，可谓一举两得。正如《医宗金鉴·删补名医方论》所说：“斯方也，柴胡得生姜之倍，解半表之功捷；枳、芍得大黄之少，攻半里之效徐，虽云下之，亦下中之和剂也。”然较小柴胡汤专于和解少阳一经者力量为大，名曰“大柴胡汤”。

现代药理研究表明，大柴胡汤利胆作用明显，能降低括约肌的张力，降低

排便困难。方中大黄与芍药合用能协同利胆，芍药为治腹泻的常用药，配伍大黄以治腹中实痛，配伍甘草以治腹中虚痛。而大黄和枳实的搭配可以增强肠道的蠕动，有利于大便通下。大黄及其他几种药物都有抗菌消炎、解热镇痛的功效，故而本方对消化系统的多种炎症都有很好的疗效。

方剂制备

8味药材加水约2400毫升，熬煮至约剩余一半的时候滤去药渣，继续熬煮至剩下药液的一半，平均分3份，每次1份，1日3次。

使用注意

1. 本方现在用治急性胰腺炎、急性胆囊炎、胆石症等效果很好。
2. 使用本方时，应辨明少阳与阳明何者为重。少阳证重者，治疗以和解为主；阳明证重者，治疗则应以通泄里热为主。本病发展变化较快，须随时观察病情变化，以免延误病情。

临症加减

1. 眼球、皮肤、粘膜及小便发黄者，可酌情加入茵陈蒿、栀子退黄。
2. 体温较高，口渴烦闷、舌红赤者，加蒲公英、金银花、连翘、板蓝根等。



典型案例

张某，男，35岁，腹痛3天，不敢按压，压后抬手有剧痛。恶心呕吐，吐黄绿色酸水，口苦烦躁，咽干口渴。两日未解大便，小便黄赤短少。舌红苔薄腻，脉弦数。诊断为少阳阳明证，处方：柴胡12g，黄芩9g，芍药9g，半夏9g，生姜15g，枳实9g，大枣4枚，大黄6g，水煎服。

病名

急慢性肠炎、慢性胃炎、
胃十二指肠溃疡

中医病名

脾胃虚寒证

症状

脾胃虚寒证。主要表现脘腹冷痛，喜得温按，自利不渴，畏寒肢冷，呕吐，不欲饮食，舌淡苔白，脉沉细；或阳虚失血（此处的失血，多是指下焦的便血以及妇女的月经量多、崩漏）；或小儿慢惊，或病后喜唾涎沫；或霍乱吐泻；以及胸痹等中焦虚寒所致者。本方是治疗中焦脾胃虚寒证的基础方。临床应用以脘腹冷痛，呕吐便溏，畏寒肢冷，舌淡，苔白，脉沉细为辨证要点。

脾主司运化，分辨清浊，使清阳之气上升。如本身脾气不强，过食生冷寒湿伤胃，则损及脾阳，键运功能失职，升降失常则见吐泻。寒邪内盛则阳气难升，脘腹胀满而疼痛，得温则减。湿盛而口不渴，苔白而腻滑，脉细弱。腹痛喜温是虚寒的特征性表现，可以与里热与实寒证作为鉴别。本症也可见病人口渴，但必欲饮热水而不喜凉。本症中的呕吐物多为清稀水涎，或胃内容物，没有热臭气味，腹泻排出的大便也多稀溏，甚至直接泻出稀水，小便清长，与湿热之邪导致的腹泻有明显的区别。临床上，脾胃突然感受外寒，虽然平素无脾虚之状况，脾阳被外寒所遏，也可能出现同本症相同或类似的症状表现，虽然两者性质有虚实之分，但本质上脾阳不升与脾阳虚衰也没有绝对的界限，诊治上可以与本症互相借鉴。

【用方】

理中汤——《伤寒论》

方剂说明

温中散寒，补气健脾。

适用于急慢性胃肠炎、胃及十二指肠溃疡、胃痉挛、胃下垂、胃扩张、慢性结肠炎等属脾胃虚寒者。

组成

干姜5g，人参6g，白术9g，炙甘草6g。

歌曰：理中汤主温中阳，人参白术甘草姜。

配伍说明

本方所治诸症皆由脾胃虚寒所致。中阳不足，寒从中生，阳虚失温，寒性凝滞，故畏寒肢冷、脘腹绵绵作痛、喜温喜按；脾主运化而升清，胃主受纳而降浊，今脾胃虚寒，纳运升降失常，故脘痞食少、呕吐、便溏；舌淡苔白润，口不渴，脉沉细或沉迟无力皆为虚寒之象。治宜温中祛寒，益气健脾。方中干姜为君，大辛大热，温脾阳，祛寒邪，扶阳抑阴。人参为臣，性味甘温，补气健脾。君臣相配，温中健脾。脾为湿土，虚则易生湿浊，故用甘温苦燥之白术为佐，健脾燥湿。炙甘草性温具补，补脾益气，调和诸药，用之为使。甘草与诸药等量，寓意有三：一为合参、术以助益气健脾；二为缓急止痛；三为调和药性，是佐药而兼使药之用。纵观全方，温补并用，以温为主，温中阳，益脾气，助运化，故曰“理中”。阳虚失血，无论吐、衄或便血、崩漏，但见面色㿖白、气短神疲、脉细或虚大无力，

是阳气虚弱，脾不统血所致，以本方加减治疗。胸痹一病，总由上焦阳气不足，阴寒之邪上乘，胸中之气痹阻所致。若心中痞坚，逆气上冲心胸，是中焦阳虚，又有痰饮上犯所致。可用本方温中祛寒，益气健脾，使中焦气旺，则上焦之气开发，逆气可平，胸痹可愈。病后多生涎唾，久久不已，是脾气虚寒，不能摄津，津上溢于口所致。以本方丸剂缓治，亦可徐徐收功。小儿慢惊，总由先天不足，后天失调，或过服寒凉之品，或大病后调理不善，戕害脾胃阳气所致。若形气羸瘦、手足不温、呕吐泄泻、神疲食少、舌淡苔白、脉细迟或沉细缓弱者，纯属中焦虚寒，亦可用本方治疗。综观本方，治病虽多，究其病机，总属中焦虚寒，可以异病同治。本方在《金匱要略》中作汤剂，称“人参汤”。理中丸方后亦有“然不及汤”四字。盖汤剂较丸剂作用力强而迅速，临床可视病情之缓急酌定使用剂型。

根据现代药理研究结果显示，理中汤中，干姜能健脾胃，改善血液循环，人参也有增强脾胃功能的成分和作用，还能兴奋神经系统，改善体内代谢环境。甘草除了能抑制肠道平滑肌的痉挛，也可以降低胃酸的分泌，保护消化道粘膜。整个方剂构成上对调整消化系统及人体内环境有积极的作用。



方剂制备

本方4味药材，用水约1600毫升，煎至约剩余600毫升后停火，滤去药渣分3份，1日3次服用。服药约30分钟后可食用少量热稀粥并盖厚被以取暖，盖好后不要随意掀动以免受寒。本方现代也有制成蜜丸或水丸剂型的，用量与服用频率基本与汤剂相同。

使用注意

理中汤虽然适用于中焦太阳虚寒病症，可以快速取效，但属于温热之品，不宜久服。如患者夹杂邪热，则应适当配以清热之品同用。而且一定要明辨患者是否患有出血性疾病，否则一旦应用不当，本方温热之性将会迫血妄行而加重出血，应严密观察，谨慎用药，以免发生意外。

临症加减

1. 脾胃虚寒，风冷相乘，脘腹疼痛，霍乱吐利转筋等，本方全方用药每味均增至9g，再加附子9g，成附子理中丸，以温阳祛寒，益气健脾。此方脾肾双补，通过附子补肾阳来补脾之阳。

2. 太阳病，外证未除而数下之，遂协热下利，利下不止，心下痞硬，表里不解者。去白术，加桂枝12g，其他3味药均加量至9g，能温里解表，益气健脾。

3. 病人呕吐严重，加吴茱萸、姜

半夏。

4. 病人腹泻严重，重用白术，或加苍术、茯苓。

5. 患者脾胃虚寒而有便血，可将方中干姜换为炮姜，再加炙黄芪、茜草炭、藕节等止血。

典型案例

王某，男，39岁。初诊时患者腹泻已愈一年，经常肠鸣，大便稀溏，日下八九次，食欲欠佳，完谷不化，曾经数十医诊治而未有改善。查体，见患者面色惨白无华，精神疲乏，腹部稍胀而喜按，舌苔浮有一层黄色厚腻，脉细迟。辨证为脾虚泄泻，治宜补中益土，方用仲景理中汤。处方：人参9g，炒白术9g，黑干姜6g，炙甘草6g，水煎服。

病名

慢性肝炎、慢性胆囊炎、
慢性肠炎

中医病名

肝脾气滞证

症状

阳郁厥逆证略有气闭之意。主要表现为手足不温，或身微热，或咳，或悸，或小便不利，或腹痛，或泄利，脉弦。肝脾不和证。主要表现为胁肋胀满，脘腹疼痛，脉弦等。本方原治阳郁厥逆证，后世多用作疏肝理脾的基础方。临床应用以手足不温，或胁肋、脘腹疼痛，脉弦为辨证要点。

本证形成的根本原因是肝气郁滞或肝气横逆，而肝经循行于胸胁部，所以出现胸胁部胀满或走串疼痛。脾胃气机瘀滞，则见胃脘部痞闷或胀满，或伴有嗳气、欲叹息，时时排气、噎气，排气后暂时舒爽。由于气机郁结，阳气被阻滞于内而不能外达四肢，所以四肢清冷不温。在外感热病中，则可表现为胸腹有热而手足不温，所以本证也成为四逆证，但与阳气衰微所导致的四逆完全不同，前者属于热厥，后者属于寒厥。由于肝脾气机瘀滞，运化功能失常，所以有时可以出现腹痛、腹泻等症状。这种

腹泻并不是泻后缓解的，而是每泻必不畅快，甚至出现里急后重感。泻后腹痛减轻是肝脾气滞的表现，脉象弦急也是气滞的典型脉象。古人虽然强调本证应有身体温热、手足不温的四逆表现，但临床上并非必见症状，有的病人可以有手足心热，下午微恶寒等表现，这也是阳气内郁的外部表现，可以作为本证的诊断参考。

【用方】

四逆散——《伤寒论》

方剂说明

透邪解郁，疏肝理气。

适用于慢性肝炎、胆囊炎、胆石症、胆道蛔虫症、肋间神经痛、胃溃疡、胃炎、胃肠神经官能症、附件炎、输卵管阻塞、急性乳腺炎等属肝胆气郁、肝脾（或胆胃）不和者。

组成

甘草6g，枳实6g，柴胡6g，白芍药6g。

歌曰：四逆散中用柴胡，芍药枳实甘草处。专治阳郁成四逆，疏通瘀滞痞自除。

配伍说明

四逆者，乃手足不温也。其证缘



于外邪传经入里，气机为之郁遏，不得疏泄，导致阳气内郁，不能达于四末，而见手足不温。此种“四逆”与阳衰阴盛的四肢厥逆有本质区别。正如李中梓云：“此证虽云四逆，必不甚冷，或指头微温，或脉不沉微，乃阴中涵阳之证，惟气不宣通，是为逆冷。”故治宜透邪解郁，调畅气机为法。方中取柴胡入肝胆经升发阳气，疏肝解郁，透邪外出，为君药。白芍敛阴养血柔肝为臣，与柴胡合用，以补养肝血，条达肝气，可使柴胡升散而无耗伤阴血之弊。佐以枳实理气解郁，泄热破结，与柴胡为伍，一升一降，加强舒畅气机之功，并奏升清降浊之效；与白芍相配，又能理气和血，使气血调和。使以甘草，调和诸药，益脾和中。综合四药，共奏透邪解郁，疏肝理脾之效，使邪去郁解，气血调畅，清阳得伸，四逆自愈。原方用白饮（米汤）和服，亦取中气和则阴阳之气自相顺接之意。由于本方有疏肝理脾之功，所以后世常以本方加减治疗肝脾气郁所致胁肋脘腹疼痛诸症。

本方与小柴胡汤同为和解剂，同用柴胡、甘草。但小柴胡汤用柴胡配黄芩，解表清热作用较强；四逆散则柴胡配枳实，升清降浊，疏肝理脾作用较著。故小柴胡汤为和解少阳的代表方，四逆散则为调和肝脾的基础方。

根据现代药理研究结果显示，四逆散中的柴胡、芍药，具有镇静、镇

痛的功用，对于各种神经痛都有一定的疗效，并可以抗菌、抗病毒，赤芍还可以扩张血管，促进血液循环。柴胡与甘草配合使用，对保护肝功能有较好的效果。枳实可以兴奋平滑肌，促进胃肠蠕动。近年的研究发现，枳实制剂可以升高血压而对抗休克，这项成果已经应用于临床，证实对于早期休克四肢发冷而胸腹灼热的热厥病人有较好的效果。另外本方还具有一定的抗菌消炎作用。

方剂制备

方中四味药捣成细末，晒过后用白开水送服，每次1.5~3g，1日3次，也可以按同样剂量加水约1200毫升煎服。

使用注意

四逆散中虽然有补益阴血的药物，但全方的重点在于疏理气机，所以属于气虚导致的气滞证不适用于本方，以防更加耗伤正气。

临症加减

1. 伴有咳嗽者，可加五味子、干姜。
2. 心悸不宁者，加桂枝。
3. 小便不利者，加茯苓、车前子。
4. 腹中冷痛者，加熟附子。
5. 腹泻，泻后有里急后重感者，加薤白、木青等。
6. 肝气郁结而兼有肝血亏虚，脾失运化导致的两胁作痛、寒热往来、头痛

目眩、口燥咽干、女子月经不调、经前乳胀、脉虚弦者，可去枳实，加当归、白术、茯苓、薄荷、生姜成逍遥散。

7. 妇女产后胁肋疼痛伴寒热往来者，去枳实，加枳壳、陈皮、川芎、香附等以增强疏肝理气和血通络的效果。

实例练习

李某，男，63岁。近半年来，胸胁肩背作痛，走窜不定，时作时休；胃脘胀满，暖气颇多，自觉有气上冲。曾作上消化道造影，未见异常；经B型超声波诊断，发现“慢性胆囊炎”“胆结石”。查体舌苔黄，脉沉小。诊断：证属肝气横逆，木土不和。治以疏肝理气，行气消胀为法。处方：柴胡10g，枳壳10g，郁金10g，白芍12g，甘草10g，青陈皮各8g，香橼皮8g，厚朴10g，炒山栀10g，旋覆花10g，生赭石10g，法夏10g，全瓜蒌15g，荷梗3g，片姜黄10g。

病名

肝炎、胆囊炎

中医病名

肝胆实热证

症状

肝胆实火上炎证。主要表现为头痛（裂痛），目赤胁痛，口苦，耳聋，耳肿等，舌红苔黄，脉弦数有力。肝胆湿热下注证。主要表现为阴肿，阴痒，阴汗，小便淋浊，或妇女带下黄臭等，舌红苔黄腻，脉弦数有力。本方为治肝胆实火上炎，湿热下注的常用方。临床应用以口苦溺赤，舌红苔黄，脉弦数有力为辨证要点。

本证临床表现非常复杂，诊断时除了需要掌握以湿热下注以及肝胆实火上炎等主要症状之外，还需要注意两个细节：一是病变部位，本证的病变部位有的在肝胆，即中医学中的肝胆所在位置，并非仅仅如同现代医学解剖中所指的肝脏和胆囊所在右侧，而是两侧胁下，即两侧胁下胀满疼痛均属于肝胆之范畴；另外一种是指按照经络循行，肝经和胆经经过的区域均属于肝胆所属，基本上包括头部两侧、两耳前后、胸胁乳房、下阴足趾等部位，相关病变都与



肝胆不合有联系。除此之外，中医理论中，肝开窍于目，眼睛的一些病变也多少与肝胆有关。二是病邪性质，本证病邪多属于湿热或者火热，这些性质是根据症状表现推断出来的，实质上也就是病症的性质。就本证来说属于肝火上炎，扰于头部，导致了眩晕、头痛，而且多数伴随有胀痛且以头耳两侧肝经循行部位为重。火热之邪犯于眼部，故见目红赤流泪畏光；犯于耳则有耳鸣、耳聋、肿痛等多种表现。口苦也是肝胆火热上犯的表现。而热邪夹湿则易下注，可能出现一些泌尿生殖系统症状，比如小便淋涩混浊，频急不净，外阴瘙痒肿痛，女性也有异常白带分泌、异味等，也可能出现下肢肿痛结块等症状。这些都是湿热之邪沿肝胆经脉循行走串所导致的，同理也可以解释胸胁胀痛、小腹胀痛等症状的原因。肝胆有邪，同时也可能影响解剖位置上临近且同属于消化系统的脏器，比如脾胃的功能，导致出现泛恶、脘腹痞满、不思饮食、厌油腻等症状。热邪扰乱心神的情况下，病人也会有心烦失眠、烦躁不安等表现，比较典型的症状有五心烦热等。

【用 方】 龙胆泻肝汤

——《医方集解》

方剂说明

清肝胆实火，泻下焦湿热。

本方常用于顽固性偏头痛、头部湿疹、高血压、急性结膜炎、虹膜睫状体炎、外耳道疖肿、鼻炎、急性黄疸性肝炎、急性胆囊炎，以及泌尿生殖系统炎症、急性肾盂肾炎、急性膀胱炎、尿道炎、外阴炎、睾丸炎、腹股沟淋巴结炎、急性盆腔炎、带状疱疹等属肝经实火、湿热者。

组 成

龙胆草6g，黄芩9g，栀子9g，柴胡6g，泽泻9g，木通6g，当归3g，生地6g，生甘草6g，车前子6g。

歌曰：龙胆泻肝栀芩柴，生地车前泽泻偕，木通甘草当归合，肝经湿热力能排。

配伍说明

本症由于肝胆经实火上炎，或湿热循经下注所致。治之宜清肝胆实火，泻下焦湿热。方中龙胆草大苦大寒，能上清肝胆实火，下泻肝胆湿热，为君药。黄芩、栀子苦寒，归肝胆三焦经，泻火



解毒，燥湿清热，为臣药。湿热壅滞下焦，故用渗湿泻热的车前子、木通、泽泻导湿热下行，从水道而去，使邪有出路，则湿热无留，为佐。肝为藏血之脏，肝经实火，易伤阴血，所用的药物又有苦燥渗利伤阴之品，故用生地养阴，当归补血，使祛邪而不伤正；肝体阴而用阳，性喜疏泄条达而恶抑郁，火邪内郁，肝气不舒，用大剂苦寒降泻之品，又可能使肝胆之气被抑，故又用柴胡舒畅肝胆，并能引诸药归于肝胆经，为佐。甘草为使，一可缓苦寒之品防其伤胃，二可调和诸药。本方的配伍特点是泻中有补，利中有滋，降中寓升，祛邪而不伤正，泻火而不伐胃，使火降热清，湿浊得利，循经所发诸症皆可相应而愈。

根据现代药理研究，本方对急性炎症致病菌有良好对抗作用，并且兼有利尿、利胆泄肝、止痛等作用。龙胆草的成分除了能够镇静抗炎之外，同时具有一定的解热功能。栀子则除抗菌外，也能镇静镇痛、利胆解痉、稳定血压等。黄芩和柴胡、当归的化学成分中物质的具体功能在前面的某些方剂中已有具体介绍，不再赘述。本方各味药物组合后，不但能够抗菌消炎，而且对人体的生理功能及免疫系统环境具有调节作用。

方剂制备

作水剂煎服，根据病情轻重决定用药剂量，也可制成丸剂。每次服6~9g，1日2次，温开水送下。

使用注意

1. 此方配伍严谨，用时最好遵用原方。
2. 肝经湿热亦可造成阳痿，且青壮年的阳痿多因于此，症见阴痒，阴汗。
3. 男子遗精与女子的带下有类似之处，故在用药方面亦可相互借用。
4. 黄芩、丹皮为清肝火的药对，黄芩走气分，丹皮走血分。补充肝火耗伤的阴血，防止苦燥药物龙胆草、黄芩、栀子伤阴，防止车前子、木通、泽泻渗利伤阴。
5. 本方药物多为苦寒之性，内服易伤脾胃，对脾胃虚寒和阴虚阳亢之症，多服、久服皆非所宜。服用期间忌食油腻生冷。
6. 木通切忌使用马兜铃科植物关木通，以免引起中毒，发生意外。

临症加减

1. 本证肝火上炎兼见头痛眩晕严重者，加菊花、石决明、羚羊角等药物清热解痉；
2. 肝胆热邪炽盛，兼犯脾胃或肺脏，灼伤血络，有吐血、咳血症状者，



加侧柏叶、藕节、白芨等凉血止血；

3. 湿热下注而湿邪较重，证见患处渗液较多的，可加苦参、苍术；

4. 湿热下注见下肢痿软无力，足膝关节红肿疼痛、或者有瘙痒、渗出等症状的，可加用三妙丸，组成为酒炒黄柏120g，苍术180g，川牛膝60g，混合研为细末，以面糊为丸。

5. 肝火炽盛而腹实，便秘难解、火邪难泄的，重用当归、加黄连、黄柏、大黄、芦荟、木香等清热泻肝，攻下行滞。

典型案例

患者女，45岁。病发带状疱疹，于左胁呈点状分布，直至左下腹，色暗红，无脓疱及溃破，疼痛难忍，动则尤甚，自觉痛处有灼热感，伴口苦、纳差、眠差、舌红苔黄，脉弦滑数无力。中医诊断疱疹。证属肝胆湿热。治以清泻肝胆湿热。方用龙胆泻肝汤加减：龙胆草、当归、延胡索、郁金、甘草各12g，黄芩、柴胡、栀子、泽泻、黄芪、丹皮、玄参各15g，生地、白茅根各30g，蒲公英、紫花地丁各20g。每日1剂，水煎服。

病名 急慢性胃肠炎、 急慢性肝炎 中医病名 湿困脾胃证

症状

湿滞脾胃证。主要表现为脘腹胀满，不思饮食，呕吐恶心，嗳气吞酸，肢体沉重，怠惰嗜卧，常大便溏薄下利。舌苔白腻而厚，脉缓。

由于湿浊困阻脾胃，阻滞气机，可见脘腹胀满；湿邪影响到脾胃的升降功能，则可出现泛恶、便溏、不思饮食；湿阻于中，清阳之气不能敷布全身，可导致倦怠嗜睡。这与全身阳气虚衰所导致的倦怠萎靡有所不同。舌苔滑腻是诊断体内有湿邪停滞的重要依据，而口淡无味与脉象沉缓是这一诊断的重要佐证。

湿困脾胃证以脾胃阳气困遏，湿浊内阻为特征，如果兼有湿热，则属于湿热蕴中证，如表现出明显的中阳虚衰、寒湿内阻的症状，则又属于太阴虚寒证，须辨证诊断。

【用方】 平胃散

——《简要济众方》

方剂说明

燥湿运脾，行气和胃。

本方临床上几乎可以应用于任何湿邪所致的病症，虽然治疗重点在脾胃，但是又不局限于脾胃。如常用于慢性胃炎、消化道功能紊乱、胃及十二指肠溃疡等属湿滞脾胃者。但是很多非消化系统的疾病只要有湿邪的存在，也常使用本方，比如冠心病、失眠、慢性肾炎，以及妇科疾病如月经稀少或闭经、不孕症、白带异常等。

组成

苍术15g，厚朴、陈皮各9g，甘草6g，生姜2片，大枣2枚。

歌曰：平胃散用朴陈皮，苍术甘草姜枣齐。燥湿运脾除胀满，调味和中此方宜。

配伍说明

本方为治疗湿滞脾胃的基础方。脾为太阴湿土，居中州而主运化，其性喜燥恶湿，湿邪滞于中焦，则脾运不健，且气机受阻，故见脘腹胀满、食少无味；胃失和降，上逆而为呕吐恶心、暖气吞酸；湿为阴邪，其性重着粘腻，

故为肢体沉重、怠惰嗜卧。湿邪中阻，下注肠道，则为泄泻。以治当燥湿运脾为主，兼以行气和胃，使气行则湿化。方中以苍术为君药，以其辛香苦温，入中焦能燥湿健脾，湿去则脾运，脾健则湿邪得化。湿邪阻碍气机，且气行则湿化，故方中臣以厚朴，本品芳化苦燥，长于行气除满，且可化湿。与苍术相伍，行气以除湿，燥湿以运脾，使滞气得行，湿浊得去。陈皮为佐，理气和胃，燥湿醒脾，以助苍术、厚朴之力。使以甘草，调和诸药，且能益气健脾和中。煎加姜、枣，以生姜温散水湿且能和胃降逆，大枣补脾益气以襄助甘草培土制水之功，姜、枣相合尚能调和脾胃。综合全方，燥湿与行气并用，而以燥湿为主。

根据现代药理研究结果显示，平胃散方中所含有的成分能够很好地调整胃肠道消化功能。方中的苍术有健胃、利尿、发汗、镇静、降血糖和强壮身体的作用，厚朴则除了能健胃、镇静、镇痛、缓解横纹肌强直等作用外，还具有较好的抗菌作用。此外，方中使用的陈皮能够健胃、止吐、祛痰。甘草则有解痉、保护胃粘膜、以及发挥类肾上腺皮质激素作用。综合全方，不仅能健脾胃助消化，而且也有广泛复杂的药理作用。

方剂制备

方中各味共为细末，每服4~6g，姜



枣煎汤送下；或作汤剂，水煎服，用量按原方比例酌减。

使用注意

平胃散虽然适用的病症很多，但就方剂性质来说属于偏温燥，所以无湿者固然不能使用，有湿邪而素体阴虚或者间杂有火热之邪者也不适宜，不可轻易使用。如果一定要用，需要妥善配伍增减。

临症加减

1. 湿困脾胃而气机瘀滞较甚者，可加木香、砂仁等增加行气之力。
2. 兼有食积内停者，可加炒神曲、麦芽，焦山楂等。
3. 兼见腹胀便秘者，可加槟榔、莱菔子、枳实等。
4. 兼有脾胃虚弱而倦怠乏力，食欲减少大便稀溏者，可加炒白术、茯苓、党参等。
5. 兼有脾胃寒盛而腹部冷痛作泻者，可加干姜、肉桂等。
6. 胃气上逆较严重而见呕吐或嗝逆频作者，可加入姜半夏等。

实例练习

阎某，女，42岁。平素胃部有恙多年，经诊断为浅表性胃炎。最近几日胃脘部位胀满不适，进食后加重，有轻微痛感，伴随恶心呕吐，大便稀溏，一日

排便多于两次，食欲不振。经查体，舌苔白腻不清，脉诊濡细。诊断湿困脾胃证。处方：苍术15g，厚朴9g，陈皮9g，甘草6g，炒白术6g，茯苓6g，党参9g，与生姜2片、大枣2枚，水煎服。

病名

慢性胃炎、
胃及十二指肠溃疡

中医病名

痰湿证

症状

湿痰咳嗽。主要表现为痰多色白易咯，胸膈痞闷，恶心呕吐，肢体倦怠，或头眩心悸，舌苔白润，脉滑。

湿痰为病，犯肺致肺失宣降，则咳嗽痰多；停胃令胃失和降，则恶心呕吐；阻于胸膈，气机不畅，则感痞闷不舒；流注肌肉，则肢体困重；阻遏清阳，则头目眩晕；痰浊凌心，则为心悸。

中医学有“脾为生痰之源，肺为贮痰之器”的说法，即指出脾胃失去健运功能是产生痰湿的原因，也说明了痰湿生成后一般会阻滞于肺。痰邪阻滞于肺，必然影响肺的正常生理功能，肺气失于宣降，表现为咳嗽并且咳白色痰液，也可能发生喘促。舌苔白腻脉滑是



体内有湿痰之邪的重要诊断依据。由于痰湿生成后，阻碍气机运行，所以可以见到胸闷、脘痞的症状。痰湿停留于脾胃则影响其运化及升清降浊的功能，所以不思饮食或恶心呕吐。痰湿阻滞中焦，导致清阳之气不能上输全身及头部，出现肢体困倦、头晕目眩等症状。痰湿扰乱心神，也可出现心悸、癫狂、失眠、惊恐不安或肢体抽搐、丧失意识等表现。如痰湿纠结于筋骨、经络，则会形成有形肿块，并且多可活动，皮肤颜色没有变化，疼痛状况不严重，与一般炎症性质的红肿热痛有所区别，被称为痰核。其中结于脖颈部的多属于瘰癧（淋巴结结核），深入肌肉或骨骼的则属于流痰（骨结核、关节结核）。如痰湿下注，妇女可见白带频多，其中如果有痰湿阻滞于胞宫的情况，也可能发生不孕。如痰湿不化充斥于身体，也能表现为肥胖，故有“肥人多痰”的说法，这其中也包括了部分高血脂病例，也属于痰湿之列。

【用方】

二陈汤

——《太平惠民和剂局方》

方剂说明

燥湿化痰，利气和中。

本方临床上应用的范围极其广泛，

很多治疗痰湿的方剂都是在二陈汤的基础上加减变化而来的，在具体运用时还需要根据痰湿所兼挟的病邪的不同性质和所停滞的不同部位进行灵活的加减变化。本方现代常用于慢性支气管炎、慢性胃炎、梅尼埃病、神经性呕吐等属湿痰证者。

组成

半夏、橘红各15g，白茯苓9g，炙甘草4.5g。

歌曰：二陈汤用半夏陈，益以茯苓甘草臣，利气和中燥湿痰，煎加生姜与乌梅。

配伍说明

本方证多由脾失健运，湿无以化，湿聚成痰，郁积而成。湿痰为病，犯肺致肺失宣降，则咳嗽痰多；停胃令胃失和降，则恶心呕吐；阻于胸膈，气机不畅，则感痞闷不舒；流注肌肉，则肢体困重；阻遏清阳，则头目眩晕；痰浊凌心，则为心悸。治宜燥湿化痰，理气和中。方中半夏辛温性燥，善能燥湿化痰，且又和胃降逆，为君药。橘红为臣，既可理气行滞，又能燥湿化痰。君臣相配，寓意有二：一为等量合用，不仅相辅相成，增强燥湿化痰之力，而且体现治痰先理气，气顺则痰消之意；二为半夏、橘红皆以陈久者良，而无过燥之弊，故方名“二陈”。此为本方燥湿化痰的基本结构。佐以茯苓健脾渗



湿，渗湿以助化痰之力，健脾以杜生痰之源。鉴于橘红、茯苓是针对痰因气滞和生痰之源而设，故二药为祛痰剂中理气化痰、健脾渗湿的常用组合。煎加生姜，既能制半夏之毒，又能协助半夏化痰降逆、和胃止呕；复用少许乌梅，收敛肺气，与半夏、橘红相伍，散中兼收，防其燥散伤正之虞，均为佐药。以甘草为佐使，健脾和中，调和诸药。综合本方，结构严谨，散收相合，标本兼顾，燥湿理气祛已生之痰，健脾渗湿杜生痰之源，共奏燥湿化痰，理气和中之功。

根据现代药理研究的结果显示，本方中的半夏具有止咳镇吐的作用，陈皮可以促进消化液的分泌，排除肠内多余积气，并且能利胆、抗炎、扩张支气管、祛痰。而茯苓除可以利尿之外，还可以保肝，镇静。甘草能抑制平滑肌的病理性痉挛，抗炎、抗过敏。与陈皮、茯苓配合使用又可以保护胃肠等消化道粘膜，防止溃疡的发生。这些药材单独的药理功能并不能涵盖二陈汤全方的药理作用。全方成分对消化、呼吸、神经、心血管、内分泌、生殖泌尿等各系统的功能都具有一定程度上的双向调节功能。

方剂制备

每服12g加生姜7片，乌梅1个，水煎温服。

使用注意

二陈汤属于温燥之剂，如素体阴虚或有热者应谨慎使用，或适当配合养阴清热之品。对有咳血倾向的患者忌用半夏，以防引起大出血。

临症加减

1. 痰湿挟寒，属寒痰的患者，加苍术、生姜汁，寒邪过甚可加淡吴茱萸、附子。
2. 痰湿挟热，属痰热或痰火者，加石膏、青黛、黄连、竹沥。
3. 痰湿挟风，属风痰者，加明天麻、制南星、白附子、皂角、地龙。
4. 痰湿挟瘀，属瘀痰者，加桃仁、红花、丹参。
5. 痰湿而热邪积滞肠腑者，加大黄、芒硝、全瓜蒌。
6. 挟气滞者，加制香附、枳壳、柴胡等。
7. 痰湿蒙蔽心神者，加石菖蒲、郁金、礞石、法半夏等。
8. 中风痰迷心窍而神志昏蒙者，加胆南星、枳实、人参、石菖蒲、竹茹。
9. 痰湿阻滞于胞宫，肥胖不孕，白带频下者，加苍术、制香附、当归、南星等。
10. 痰湿阻滞纠结于肌肉皮下者，加白芥子、皂角刺。
11. 肺热痰热凝结于肺，咳吐黄痰



者，加瓜蒌仁、黄芩、枳实、胆南星等。

典型案例

王某，男，55岁。患支气管炎、肺气肿十余年。每到气候变冷发作尤甚。近日因感受风寒，咳嗽剧烈，喘促，吐大量泡沫状白色痰液，胸闷不舒，脘腹胀满，口不渴，无食欲。查体舌苔白厚腻，脉细滑。诊断为痰湿挟寒证，处方：半夏15g，橘红15g，白茯苓9g，炙甘草4.5g，苍术9g，吴茱萸6g，水煎服。

病名

急慢性胃炎、
妊娠恶阻

中医病名

痰热内扰证

症状

胆胃不和，痰热内扰证。主要表现为胆怯易惊，虚烦不宁，失眠多梦，呕吐呃逆，癫痫等证。

本症痰热所在部位以胆为主，痰热在胆则容易犯胃，导致胃失和降而引发呕吐、嗝逆。胆之痰热又可能上扰心神，轻者导致失眠、心悸、心烦不安、惊恐，严重者可引起神志失常。其中在

内伤杂病里有表现为抑郁、淡漠者为癫，有表现为兴奋、狂乱者为狂，外感热性病中，有表现为神志不清或者昏迷不醒者，也有表现为说胡话者，称为谵语。痰热内盛则口苦、舌苔黄腻，脉象见弦滑，痰热阻碍气机运行也会出现胸闷的症状。

【用方】

温胆汤

——《三因极一病证方论》

方剂说明

理气化痰，清胆和胃。本方为治疗胆郁痰扰所致不眠、惊悸、呕吐以及眩晕、癫痫症的常用方。应用以心烦不寐，眩悸呕恶，苔白、腻，脉弦滑为辨证要点。适用于神经官能症、急慢性胃炎、慢性支气管炎、梅尼埃病、更年期综合征、癫痫等属胆郁痰扰者。

组成

半夏、竹茹、枳实各6g，橘皮9g，炙甘草3g，白茯苓4.5g。

歌曰：温胆汤中苓半草，枳竹陈皮加姜枣。虚烦不眠心中悸，胆热痰扰证可消。

配伍说明

本方证多因素体胆气不足，复由



情志不遂，胆失疏泄，气郁生痰，痰浊内扰，胆胃不和所致。胆为清净之府，性喜宁谧而恶烦扰。若胆为邪扰，失其宁谧，则胆怯易惊、心烦不眠、夜多异梦、惊悸不安；胆胃不和，胃失和降，则呕吐痰涎或呃逆、心悸；痰蒙清窍，则可发为眩晕，甚至癫痫。治宜理气化痰，和胃利胆。方中半夏辛温，燥湿化痰，和胃止呕，为君药。臣以竹茹，取其甘而微寒，清热化痰，除烦止呕。半夏与竹茹相伍，一温一凉，化痰和胃，止呕除烦之功备；陈皮辛苦温，理气行滞，燥湿化痰；枳实辛苦微寒，降气导滞，消痰除痞。陈皮与枳实相合，亦为一温一凉，而理气化痰之力增。佐以茯苓，健脾渗湿，以杜生痰之源；煎加生姜、大枣调和脾胃，且生姜兼制半夏毒性。以甘草为使，调和诸药。综合全方，半夏、陈皮、生姜偏温，竹茹、枳实偏凉，温凉兼进，令全方不寒不燥，理气化痰以和胃，胃气和降则胆郁得舒，痰浊得去则胆无邪扰，如是则复其宁谧，诸症自愈。

温胆汤最早见于《外台秘要》卷十七引《集验方》，方中生姜四两，半夏二两（洗），橘皮三两，竹茹二两，枳实二枚（炙），甘草一两（炙），治“大病后，虚烦不得眠，此胆寒故也”，全方药性以温为主。至《三因极一病证方论》中所载3首同名温胆汤中有两方组成完全相同，均在《集验方》

原方基础上加茯苓一两半、大枣一个，生姜减为五片，全方药性即由偏温而归于平和，其主治在“虚烦证治”仍沿袭《外台秘要》之治，在“惊悸证治”项下则为“心胆虚怯，触事易惊，气郁生涎”变生的诸证，但仍沿袭温胆汤。后世医家又在此基础上进行化裁，如加黄连，名黄连温胆汤（《六因条辨》卷上）；去姜、枣，易枳实、茯苓为枳壳、赤茯苓，更加青蒿、青子芩、碧玉散，方名蒿芩清胆汤（《重订通俗伤寒论》），功用方向亦随之转为以清胆和胃为主。

根据现代药理研究结果显示，本方除了半夏具有止咳镇吐的作用外，陈皮可以促进消化液的分泌，排除肠内多余积气，并且能利胆、抗炎、扩张支气管、祛痰。而茯苓除可以利尿之外，还可以保肝，镇静。甘草能抑制平滑肌的病理性痉挛，抗炎、抗过敏。与陈皮、茯苓配合使用除了有可以保护胃肠等消化道粘膜，防止溃疡的发生等功能之外，更侧重于镇静、调整中枢系统功能，是治疗神经精神性疾病的常用方剂。

方剂制备

加生姜5片，大枣1枚，水煎服，用量按原方比例酌减。

使用注意

1. 本方用于痰热内扰证，因为病邪

本身带有热的性质，所以配方清热之力并不很强，所以对于热甚或者痰火之证并不能取得理想疗效，需要酌情加入清热泻火之品。

2. 如患者大便秘结而痰火内盛，需适当配合攻下之法，一般多用大黄。

3. 本方性质上属于温燥之剂，凡素体阴血不足者不宜食用，而火热煎熬日久损伤阴液者，可酌情加生地、沙参、石斛等。

临症加減

1. 眩晕严重者，可加明天麻、菊花、刺蒺藜等。

2. 呕吐严重的，可加苏叶、黄连、代赭石等。

3. 邪热炽盛者，可加黄连、黄芩、栀子等。

4. 痰热夹杂者，可加全瓜蒌、玄明粉、莱菔子、竹沥等。

5. 痰热上扰心神，出现失眠、心悸等神志症状者，可加远志、生牡蛎、酸枣仁等。

6. 癫痫发作者，可加郁金、白矾、胆南星、石菖蒲等。

7. 邪热盛而气血不足者，加黄连、熟地、人参、酸枣仁、远志等，成十味温胆汤。

典型案例

肖某，男性，35岁。夜难眠已久，

乱梦纷纭，睡后易惊，每晚非服安眠药物不能入睡。精神不振，易于烦躁，纳食乏味，食后则脘腹胀满不适，口干不欲饮水，舌苔黄厚，左关脉滑，余部脉象虚小。睡后易惊，为肝胆郁热挟痰，扰及心神，致使夜寐不宁。拟以清胆豁痰安神之温胆汤加味为治。处方：广陈皮4.5g，清半夏9g，云茯苓9g，炙甘草6g，枳实3g，竹茹9g，石菖蒲6g，萸炒连1.5g。

病名

疝气、肠绞痛、生殖器官
及附件炎症

中医病名

寒症

症 状

小肠疝气。主要表现为少腹引控睾丸而痛，偏坠肿胀，或少腹疼痛，苔白，脉弦。

本症属于中医学中疝气的一种证型。所谓疝气，包括了许多病症在内，其中包括有体腔内容物突出于体表，比如腹壁、腹股沟、阴囊等，或者伴有疼痛；有外生殖器的肿痛、流脓或流污水等；有小腹部伴有剧烈疼痛的大小便不通等。这些病症都与寒凝肝脉、阻



滞气机有关，精气不能通畅，则小腹或少腹疼痛牵引睾丸，或发为睾丸偏坠肿痛。小腹胀满，形寒畏冷也都是阴寒内盛、肝气郁结导致的。

【用 方】

天台乌药散

——《医学发明》

方剂说明

行气疏肝，散寒止痛。

本方主治疝气为寒凝肝脉，气机阻滞所致。“诸疝皆归肝经”“治疝必先治气”。对睾丸炎、附睾炎、胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎等属气滞寒凝者，均可加减使用。

组 成

天台乌药12g，木香6g，小茴香6g，青皮6g，高良姜9g，槟榔9g，川楝子12g，巴豆12g。

歌曰：天台乌药木茴香，巴豆制楝青槟姜。行气疏肝止疼痛，寒疝腹痛是良方。

配伍说明

本者由于寒凝气滞于肝经导致，方中乌药辛温，行气疏肝，散寒止痛，为君；青皮疏肝理气，木香行气止痛，小茴香暖肝散寒，良姜散寒止痛，共为

臣；用槟榔下气导滞，直达下焦而破坚；取苦寒之川楝子与辛热之巴豆同炒，去巴豆而用川楝子，是为增强川楝子行气散结之功，又可制其苦寒之性，“去性存用”者也，共为佐使。

根据现代药理研究结果显示，天台乌药散中的主要成分乌药、高良姜、小茴香、木香等药材中含有多种挥发油，具有较强的促进肠蠕动和止痛的作用。川楝子则含有挥发性脂肪酸，也具有比较显著的止痛效果。所以本方对于疼痛性的疾病尤其适用。

方剂制备

方中8味，先将巴豆微打破，同川楝子用麸炒黑，去巴豆及麸皮不用，合余药共研为末，和匀，每服3g，温酒送下。

使用注意

1. 小腹部的疼痛可以有很多种原因，也经常由于有关脏器组织的炎症、腔道梗阻或痉挛引起，其中有属于湿热热毒，不可投用天台乌药散类辛温之剂。

2. 凡患者有热邪的情况，如出现腹痛拒按，腹部坚实，或外阴部肿痛处红热，均不属于本方的适应症，临床使用时应加以鉴别。

临症加减

1. 气滞较甚者，可见小腹两侧窜痛无定处，或疼痛向下牵扯前阴部，可酌

情加荔枝核、橘核等。

2. 寒凝较甚，或见小腹以及外阴部阴冷作痛者，可加吴茱萸、肉桂、草拔、附子等。

3. 兼有瘀血凝聚而导致小腹坚硬满痛或睾丸肿痛如石者，可加红花、桃仁、地鳖虫活血化瘀，并配合昆布、海藻等软坚散结。

典型案例

唐某，男，40岁。两天前开始左下腹渐觉疼痛，痛势呈加剧趋势，并向同侧腹股沟方向放射疼痛，牵连左侧睾丸。左下腹压之疼痛，伴有酸麻胀感。身微恶寒，体温正常。查体舌苔白，舌质淡红正常，脉沉细弦。诊断气滞于下证，处方：天台乌药12g，木香6g，小茴香6g，青皮6g，高良姜9g，槟榔9g，川楝子12g，巴豆12g，水煎服。

病名

腹痛腹泻、食欲不振、
呕吐

中医病名

食滞胃肠证

症状

食滞胃肠证。主要表现脘腹痞满胀痛，噎腐吞酸，恶食呕吐，或大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑等。本方为治疗一切食积之常用方。临床应用以脘腹胀满，噎腐厌食，苔厚腻，脉滑为辨证要点。

本症由于暴饮暴食或平素饮食过量，超过脾胃运化能力，导致食物停留于消化道，阻碍脏腑功能正常运行，故可见胃脘及腹部胀满、甚至疼痛。食物在体内不能得到正常消化、吸收和排泄，加上胃肠功能的紊乱，升降失常，故发生呕吐腹泻，吐泻物主要为未消化完的食物残渣，因在消化道中堆积发酵，故有酸臭气味。食积于内，影响了脾胃的功能，因而不思饮食。临床上可以结合饮食不节史进行诊断。



【用方】 保和丸——《丹溪心法》

方剂说明

消食和胃。

常用于急慢性胃炎、急慢性肠炎、消化不良、婴幼儿腹泻等属食积内停者。

组成

山楂18g，神曲6g，半夏、茯苓各9g，陈皮、连翘、莱菔子各6g。

歌曰：保和神曲与山楂，苓夏陈翘莱菔加。炊饼为丸白汤下，方中亦可加麦芽。大安丸内加白术，消中兼补效堪夸。

配伍说明

本方证是因饮食不节，暴饮暴食所致。《素问·痹论》说：“饮食自倍，肠胃乃伤。”若饮食过度，食积内停，气机不畅，则脘腹痞满胀痛；脾胃升降失职，浊阴不降，则噎腐吞酸、恶食呕逆；清气不升，则大便泄泻等。治宜消食化滞，理气和胃。方中重用酸甘性温之山楂为君，消一切饮食积滞，长于消肉食油腻之积；神曲甘辛性温，消食健胃，长于化酒食陈腐之积；莱菔子辛甘而平，下气消食除胀，长于消谷面之积。三药同用为臣，能消各种食物积滞。食积易于阻气、生湿、化热，故

以半夏、陈皮辛温，理气化湿，和胃止呕；茯苓甘淡，健脾利湿，和中止泻；连翘味苦微寒，既可散结以助消积，又可清解食积所生之热，均为佐药。诸药配伍，使食积得化，胃气得和，热清湿去，则诸症自除。

根据现代药理研究结果显示，保和丸中的神曲含有多种促进消化功能的酶，而山楂、莱菔子、麦芽等均为具有促进消化功能的健胃药，山楂又有扩张血管的功能，可以改善消化道的血液循环，山楂和连翘都可以抗菌，能达到清洁消化道，预防和消除感染的作用。所以保和丸对于消化不良和消化道感染可以达到良好的治疗效果。

方剂制备

方中各药碾为粉末，合熟面为丸，如梧桐子大小，每次服用70~80粒，白开水送下，1日2~3次。或者原方剂量1/10以水煎服。

使用注意

1. 本方属攻伐之剂，故不宜久服。
2. 本方以消食为主，主要针对饮食过度。如属脾胃虚弱而导致的消化不良以及食滞内停，则不适用。

临症加减

1. 过食米面等主食，或水果等，可以加入麦芽或直接用麦芽煎汤送服丸药。

2. 食滞严重者，酌量添加枳实、槟榔、谷芽等。

3. 郁热较重而口苦苔黄脉数者，可加黄连、黄芩等。

4. 腹部胀满疼痛，大便里急后重者，可加木香、槟榔等。

5. 腹痛而大便秘结者，可加大黄、枳实等。

6. 食滞而脾胃较虚弱的，可加白术。

典型案例

王某，女，36岁。前日多吃狗肉饮酒后，今日上午突发泄泻，至晚已八九行，奇臭难闻，且腹痛剧烈，噤腐吞酸，不思饮食。脉滑数，舌苔黄腻。素体健壮，暴病泄泻，确属饮食所伤。治宜通因通用，化其酒肉陈腐之积。

处方：山楂炭12g，神曲12g，炒莱菔子12g，制半夏9g，陈皮6g，茯苓12g，炮鸡金6g，炒麦芽12g，黄芩9g，水煎服。

病名

急性胃肠炎、痢疾、
肠伤寒

中医病名

湿热食积证

症状

湿热食积。主要表现为脘腹胀痛，下痢泄泻，或大便秘结，小便短赤，舌苔黄腻，脉沉有力。本方为治疗湿热食积，内阻胃肠证的常用方。临床应用以脘腹胀满，大便失常，苔黄腻，脉沉有力为辨证要点。

本症是由于食积和湿热互结、气机阻滞而导致的，所以食积、湿热、气滞三者并存，脘腹胀痛是其表现。食积如阻塞肠道，则会导致大便不通，如湿热下迫，则可出现腹泻，但由于食积于肠道，气机闭阻，必然导致肠道传导不畅，所以排便不爽，便后有里急后重感。又因食积与湿热互相影响，大便色如黄酱，有恶臭气味，与一般的腹泻有着显著的区别。同时湿热蕴于肠胃，可以出现发热症状，以腹部尤为严重。这些症状在外感热病中表现得比较突出。其他如小便短赤等，属于里热之象，舌苔垢腻黄浊，脉象沉滑有力，都是湿热瘀积食互阻的表现。



【用方】 枳实导滞丸

——《内外伤辨惑论》

方剂说明

消食导滞，清热祛湿。

适用于胃肠功能紊乱、慢性痢疾等属湿热积滞者。

组成

大黄9g，枳实、神曲各9g，茯苓、黄芩、黄连、白术各3g，泽泻6g。

歌曰：枳实导滞首大黄，芩连曲术茯苓襄。泽泻蒸饼糊丸服，湿热积滞力能攘。

配伍说明

本方证因湿热食滞，内阻胃肠所致。湿热饮食积滞内停，气机壅塞，故见脘腹胀满疼痛；食积不消，湿热不化，则大便泄泻或下痢；若热壅气阻，又可见大便秘结。治宜消积导滞，清热利湿。方中以苦寒之大黄为君，攻积泻热，使积热从大便而下。以苦辛微寒之枳实为臣，行气消积，除脘腹之胀满。佐以苦寒之黄连、黄芩清热燥湿，又可厚肠止痢；茯苓、泽泻甘淡，渗利水湿而止泻；白术甘苦性温，健脾燥湿，使攻积而不伤正；神曲甘辛性温，消食化

滞，使食消则脾胃和。诸药相伍，积去食消，湿去热清，诸症自解。此方用于湿热食滞之泄泻、下痢，亦属“通因通用”之法。

根据现代药理研究结果显示，枳实导滞丸中的主要成分大黄可以泻下通便，并能抗菌、健胃，对于胃肠道的各种炎症都有较好的治疗效果。枳实则有增强胃肠蠕动的作用，神曲是帮助消化的良药。全方对于胃肠道感染症所伴随的消化不良有着确切的疗效。

方剂制备

方中各药研为细末，和热汤蒸饼后制成丸，每粒如梧桐子大小。每次服50~70粒，空腹用温开水送下。可根据病情轻重适当调整用量。也可作为煎剂，水煎服时大黄后下。

使用注意

1. 泄泻无积滞及孕妇均不宜使用。
2. 本方针对的腹痛腹泻必须是有湿热和积食郁结于内的，不适用于寒证和虚症的腹痛腹泻。
3. 临床应用时不可贪图速效重剂猛投，应轻法频下，以免湿热之邪未去而损伤正气。

临症加减

1. 腹胀满较甚，里急后重者，可加木香、槟榔等以助理气导滞之功。

2. 湿热之邪蕴蒸于里，使肠胃功能衰退，湿热与肠道中的糟粕相结合，形成食滞的，可去茯苓、黄芩、白术、泽泻，加山楂、槟榔、厚朴、连翘、紫草、川木通、甘草导滞通下，清化湿热。

典型案例

王某，男，42岁。间断性腹泻月余，近两周病情加重。1月前聚餐后觉胃脘部胀满不舒，第二天开始腹泻，日大便3~4次，呈稀水样，经用小檗碱（黄连素）等药物治疗后，腹泻好转，大便基本成形，但仍腹部胀满，纳食不香。于半月前，因饮食不慎，腹泻复作，并每至黎明之际腹痛下坠，急欲如厕，便后腹安，泻下清稀，伴有不消化食物残渣，肛门有灼热感。查形体一般，舌淡红，苔薄黄，脉弦滑。辨证：胃有宿积，脾胃受损。治以消积导滞，健脾和胃为主。处方：枳壳10g，黄连6g，木香6g，大黄3g，焦三仙各12g，苍术10g，茯苓10g，车前子20g，厚朴6g，甘草6g，水煎服。

病名

肠梗阻

中医病名

湿热内结证

症状

湿热内结证。主要表现为腹满而疼痛、便秘。兼见身热而不恶寒，口渴心烦躁，汗出，神志不清或胡言乱语。舌苔黄燥甚至灰黑燥裂，脉沉滑有力。

邪热与肠内燥屎互结，就称之为热结。热结之物阻滞于肠道之内，则传导之功能失职，加上热结之物属于有形之邪，故见腹满胀痛，大便不能通畅。正因为热结于内，恶性循环又直接引发邪热不能外泄而炽盛于里，所以但见身热不恶寒，也可能在下午三点至五点时段出现潮热，称为日晡潮热。由于里热蒸腾，逼迫津液外泄，所以周身有汗。邪热上扰心神，就会出现烦躁不安，严重者可能神志不清、胡言乱语。邪热灼伤津液，水运失常，证见口渴咽干，舌苔黄燥甚至灰黑燥裂也都是阴津被热所伤之象。而燥屎壅阻于肠道，气机被阻，故脉象不浮，经常表现为沉滑有力。本证的诊断中，大便秘结不通固然是一个非常重要的判断标准，但也有表现为腹



泻的情况出现。这是由于燥屎阻滞于肠道，大便不得排出，肠中水液从旁溢出，故见大便稀水，但肯定是腥臭异常，并伴有肛门灼热感，中医称之为热结旁流，属于非常罕见的症状。本症中的发热症状虽然非常常见，但是内伤杂病中，发热并非必见症。另外本病起于邪热郁燥屎郁结于内，阴阳不能顺畅运行，阳气难以通外而温煦四肢，出现四肢厥冷者也不在少数，即热厥的一种。

【用方】

调胃承气汤

——《伤寒论》

方剂说明

攻下热结。多用于急性肝炎、暴发型肝炎、肠伤寒、流行性乙型脑炎、肺炎、细菌性痢疾、流行性出血热、败血症、急性阑尾炎、胆道感染、腹膜炎、结膜炎、咽喉炎、牙周炎、化脓性扁桃体炎等。还可以用于治疗内伤杂病，例如急性慢性肾炎用本方后可以通过通大便而利小便，明显改善症状，而糖尿病、脑血管意外、皮质醇增多症等患者表现为实热内结也可以使用。

组成

大黄（去皮酒洗）12g，炙甘草6g，芒硝12g。

歌曰：调胃承气硝黄草，腑实腹痛急煎尝。

配伍说明

本病源于邪热郁燥屎结于肠道，所以用大黄攻下之能，使大便通畅，则郁结于内的邪热可以随之外泄，大黄即为本方主药。方中配合使用的芒硝，可以软化燥结，方便阻滞之物顺利排出。甘草能调和两味药物，并保护胃气，防止攻下猛烈胃气受伤。全方虽以通便为主要目的，但是最重要的还是在于驱除热邪，而不是单纯攻下燥结的大便而已。

根据现代药理研究显示，调胃承气汤的成分可以增强胃肠的蠕动，增加肠道容积，改善肠壁血液循环，也有一定的抗菌、利胆、利尿功能，还能增强人体的免疫力。本方中的大黄对多种病毒病菌都有抑制作用，对病毒、真菌、原虫等微生物也有抑活效果。能够在健胃的同时，比较和缓的促进体内钾元素的排出，也能降低血尿素氮的含量。利胆、收敛、消炎、解痉，降低血压以及血液胆固醇含量、利尿、促进血小板生成以及维持血小板活性以促进止血等功能，临床上应用范围非常广泛。由此可见，本方的治疗作用远远不止攻下热结这么简单。

方剂制备

药材三味加水约600毫升，先下大



黄、甘草，至药液剩余约一半左右，滤去药渣，加入芒硝稍微煎一两滚，趁温热一次服下。

使用注意

调胃承气汤虽然是一剂应用范围很广泛的组方，也经常用在很多未必有大便秘结或发热症状的疾病的治疗中，但是并非代表可以随意使用。调胃承气汤药效比较猛烈直接，属通下之法，如使用不当极易损伤脾胃阳气，甚至过度耗伤人体正气以及津液。所以必须严格掌握治疗原理及适应证，也就是最重要的一点：肠腑热结。另外，本方在使用中，大便得通后就应停止继续服用。药剂制备时，芒硝应溶于药汤内，不要过分煎煮，而大黄取决于想要重用其泻下作用还是清解作用，根据用途不同，掌握适当的熬煮时间，如需加强泻下则不宜久煎，反之则可稍微久煎。用制大黄替换大黄也有减弱泻下力的效果。

临症加减

1. 热结肠腑而有明显气机郁闭不畅症状的患者，可去甘草，加厚朴、枳实，成大承气汤，可调理气机运行。
2. 热结肠腑日久，人体津液大伤，特别肠道阴津不足，导致大便难排出者，去甘草，加生地、玄参、麦冬等，成增液承气汤。
3. 因热性病造成的阴液耗损热结肠

腑者，可加当归、人参、麦冬、生地、玄参、海参、姜汁，即新加黄龙汤。

典型案例

何某，男，40岁，因腹部胀满，按压疼痛，大便不行，1周来诊。自述下午有低热，头部胀痛不舒，心烦欲呕。查体口唇干燥，舌苔灰干，舌质红，脉弦滑。诊断为阳明腑实证，处方：大黄（去皮酒洗）12g，炙甘草6g，芒硝12g，生地9g，麦冬9g，水煎服。

病名

急性肠炎、痢疾、
肠伤寒

中医病名

胃肠湿热证

症状

胃肠湿热证。主要表现为身热汗出、腹痛腹泻、排泄物有恶臭，肛门灼热。或见微恶风寒，胸脘烦热，口干口渴，喘急气息不畅，舌红苔黄腻，脉数。本方是治疗热泻、热痢的常用方。临床应用以身热下利，苔黄脉数为辨证要点。

由于湿热蕴阻于肠腑，肠道上下传导及分泌清浊功能失常，导致水谷清



浊不分，合而下行成为腹泻。本病属于湿热之邪为患，所以伴有周身热，泻下之物多为黄褐色，气味臭秽，或者泻下急迫，呈现水注样。也可同时发生轻微的恶寒。湿热侵扰于体内，可见胸脘烦热，热邪久客则阴津伤，可见口干口渴。同时里热蒸腾而汗出。肠腑郁热上迫于肺，则可见喘急之证。但是，这些恶寒汗出喘急等症状并非本证的必见证，至于舌苔黄腻、脉数等表现均为湿热旺盛于内的表现。

肠道湿热内蕴也是痢疾的常见病因。痢疾临床以里急后重、便下脓血为主要特征，但是中医学理论中，对痢疾的辨证一般认为属于饮食积滞与湿热之邪互相纠结于肠道脏腑，所以诊断及治疗方法与本证可有不同之处，详细可以参考其他脏腑消化系统用方。

【用方】

葛根芩连汤

——《伤寒论》

方剂说明

清湿热，安肠腑。

适用于急性肠炎、细菌性痢疾、肠伤寒、胃肠型感冒等属表证未解，里热甚者。

组成

葛根15g，甘草3g，黄芩9g，黄连6g。

歌曰：葛根黄芩黄连汤，再加甘草共煎尝。邪陷阳明成热痢，清化肠热保安康。

配伍说明

本方证是因伤寒表证未解，邪陷阳明所致。此时表证未解，里热已炽，故见身热口渴、胸闷烦热、口干作渴；里热上蒸于肺则作喘，外蒸于肌表则汗出；热邪内迫，大肠传导失司，故下利臭秽、肛门有灼热感；舌红苔黄，脉数，皆为里热偏盛之象。表未解而里热炽，治宜外解肌表之邪，内清肠胃之热。方中重用葛根为君，甘辛而凉，入脾胃经，既能解表退热，又能升发脾胃清阳之气而治下利。以苦寒之黄连、黄芩为臣，清热燥湿，厚肠止痢。甘草甘缓和中，调和诸药，为本方佐使。四药合用，外疏内清，表里同治，使表解里和，热利自愈。原方先煮葛根，后纳诸药，可使“解肌之力优而清中之气锐”（《伤寒来苏集》）。本方功能解表清里，然从药物配伍作用来看，显然以清里热为主，正如尤怡所云：“其邪陷于里者十之七，而留于表者十之三。”由于葛根能清热升阳止痢，汪昂称之“为治泻主药”，故本方对热泻、热痢，不



论有无表证，皆可用之。

根据现代药理研究结果显示，葛根具有能解热同时缓解平滑肌的痉挛状态的作用，还可以提高胃液以及胆汁等消化道分泌物的分泌量，一定程度上改善胃肠功能。黄芩和黄连都具有广谱抗菌功能，合用后对一些肠道致病菌群尤为有效。甘草除了能发挥类肾上腺皮质激素作用外，也可以抗炎抗过敏。整个配方能对肠道炎症类疾病取得良好的疗效，是有其药理基础支持的。

方剂制备

全部4味药，用水约1600毫升，先煎葛根，煮至药汁约剩余3/4时加入其他3味药材，煮至剩余400毫升左右，滤去药渣，分两次温服。

使用注意

本症主要标志性症状是腹泻，然而腹泻有很多原因，表现不一，如果不是由于肠道湿热导致的腹泻，切不可使用本方。即使已经判明属于肠道湿热导致的腹泻，仍然需要分别是否兼有气滞、血瘀、积滞等情况，如有，则单用本方的效果一般并不理想，需要另外搭配能够理气、化瘀、消积的方剂药物。

临症加减

1. 湿热与积滞互结于肠道的痢疾，去葛根，加芍药、大黄、槟榔、当归、木

香、肉桂以清湿热，行气血，导积滞。

2. 湿热痢疾日久，去葛根、黄连，加芍药、大枣成黄芩汤以清热止痢。

3. 痢疾兼呕吐，加姜半夏以降逆止呕。

4. 痢疾兼见食积难消，加山楂、神曲以消食。

5. 痢疾而腹痛难忍者，加木香、芍药行气止痛。

6. 兼有肺热咳嗽喘急的，加桑白皮、杏仁、贝母、枇杷叶等清肺化痰，或可与麻杏石甘汤合用。

典型案例

马某，男，70岁，前日饮食不慎，突然腹痛泄泻，一日4~5次，腹痛即须如厕，便后有下坠感，微觉恶寒发热，食欲不振。舌苔薄白，脉象弦数。患者年已七旬，脾胃本弱，饮食不洁，再受外感，则发寒热腹泻。水谷不分，病出中焦，脉象弦数，内蕴有热，处方：酒黄芩6g，苍术炭6g，血余炭（炒车前子10g同布包）6g，酒黄连5g，白术炭6g，煨葛根10g，焦内金10g，炙草梢3g，白通草5g，焦薏仁15g，炒香豉10g，赤小豆10g，赤茯苓10g，水煎服。



病名

肠伤寒、急性胃肠炎、
霍乱

中医病名

湿热蕴中证

症状

湿热蕴中证。主要表现为胸脘痞满，呕吐腹泻，周身发热，汗出仍不解，口渴不欲多饮水，小便短赤，舌苔黄腻，脉数。

湿热之邪从性质上来说，最喜侵犯脾胃，而夏秋相交的时节湿热盛而易感，所以，本证发病时机多集中于夏秋时令，病因则多见于饮食不节等。湿热之邪犯于脾胃之后，常表现为中焦被阻，气机不行，故可见胸脘痞闷不舒，甚则出现胀满闷痛。除此之外，阻滞于中焦的湿热之邪还影响脾胃分泌清浊的升降功能，胃气不降上逆为呕，脾气不升，清浊不分，水谷混杂下为腹泻。湿热长时间滞于中焦煎熬阴津，津液受损则可见发热口渴、小便短赤、舌苔黄腻、舌质红赤脉数等虚热症状，虽然津液受损，但是中焦所困者为湿热之邪，表现不出极度缺水的症状，只欲漱水而不欲咽。

本证诊断时的主要观察方向为辨

别湿与热的侧重，如果脘腹胀满严重，口渴不甚明显，喜饮热水，小便色浅不清，舌苔较白腻者，是为热邪不重的表现；相反，发热盛，汗出不止，汗出热仍不解，口渴显著，小便色深而短涩，舌苔黄腻，脉象滑数者，就属于热邪较盛的情况。另外，本证发热症状具体热度的高低也与病种有一定关系，一般来说如热势较高，达到39~40摄氏度甚至以上者，基本见于肠伤寒，其他如急性胃肠炎、痢疾、霍乱等虽然可见热证，但体温并不一定上升很多。

【用方】

连朴饮 —— 《霍乱论》

方剂说明

理气和中，清热化湿。

适用于治疗急性消化道感染病，如急性胃肠炎、肠伤寒、副伤寒、细菌性痢疾等辨证属于湿热内蕴者。

组成

制厚朴6g，姜黄连3g，石菖蒲3g，制半夏3g，香豆豉9g，栀子炭9g，鲜芦根60g。

歌曰：连朴饮内用豆豉，菖蒲半夏芦根栀。胸脘痞闷兼吐泻，湿热蕴中此方治。

配伍说明

连朴饮方中黄连清热燥湿，厚朴行气化湿，两味药材同为主药，作用互相配合，气行则湿化，湿化则纠结之热可去。辅以栀子助黄连清热燥湿，豆豉则能宣透积滞之气，使热邪外达，石菖蒲性属芳香类，可化湿浊兼合脾胃，姜制半夏可燥湿，强调降逆止吐的功能，芦根也可以清热利湿，同时也有降逆和胃而止呕的功效。本方配伍以黄连、栀子等苦寒之品与厚朴、半夏等辛温之品相结合，这种配伍方法称为“辛开苦降”，或者也可称为“苦辛通降”，以苦寒之品清热燥湿，辛温之品行气化湿，互相辅助。因而本方可以取得湿热清泻，脾胃舒缓，升清降浊，止吐缓泻的作用。

根据现代药理研究结果表明，黄连、厚朴、栀子等药物均具有良好的细菌抑活作用，而半夏、厚朴、石菖蒲等则对胃肠功能有调节作用。连朴饮方剂成分对消化道多种感染性疾病均能收到良好的效果。

方剂制备

取水约1600毫升，将上述所有药材一起煎至药汁约剩余1/3左右，滤去药渣，分3次服用。

使用注意

连朴饮所针对的症状是由湿热两邪共同导致的，临床应用时应注意病人症状的性质，湿邪与热邪孰轻孰重，根据湿热不同的侧重调整方剂中清热药物与化湿药物的比例及用量，以求达到最理想的效果。本症如果出现比较严重的吐泻症状，则可能伴有一定程度的脱水表现，必要时可以辅助口服或静脉补液法。如吐泻物呈现米泔水样者，需及时化验，以便尽早诊断或排除烈性传染病霍乱，便于及早采取隔离及治疗措施。

临症加减

1. 急性消化道感染症时，如果患者呕吐较严重，可加炒竹茹、姜汁降逆止呕。
2. 湿邪较盛者，加藿香、佩兰、鲜荷叶化湿。
3. 热邪炽盛者，加黄芩、生石膏等清热药物。

典型案例

王某，女，26岁。十余日前开始恶寒发热，近一周来已不恶寒，但体温逐渐升高，下午尤其明显，最高可超过40摄氏度。其他症状见胸闷不舒，不思饮食，头身困重，口渴但不欲饮水，时感恶心，汗出不多，小便短赤，大便溏泻，日行两次。查体舌苔薄而黄腻，舌



质红，脉滑数。诊断为湿热蕴中证，处方：制厚朴6g，姜黄连3g，石菖蒲3g，制半夏3g，香豆豉9g，栀子炭9g，鲜芦根60g，水煎服。

病名

胃肠道出血证、
精神分裂症

中医病名

下焦蓄血证

症状

下焦蓄血证。主要表现为少腹急结，小便自利。本证小便自利为下焦蓄血而非蓄水，病在血分，膀胱气化正常，故小便自利，这是蓄血证与蓄水证的区别。甚则谵语烦躁，其人如狂，至夜发热。以及血瘀经闭，痛经，脉沉实而涩者。本方为治疗瘀热互结，下焦蓄血证的常用方。临床应用以少腹急结，小便自利，脉沉实或涩为辨证要点。

本证为瘀血蓄于下腹部，必然阻滞气机运行，所以见小腹部紧张拘急。如瘀滞较重，还可见小腹发硬胀满疼痛，按之疼痛加重，这是有里实证的表现。舌质紫暗或上有瘀点、瘀斑是瘀血证的特征之一。由于瘀血与邪热互结于下焦，上扰心神，往往可以出现一些神

志症状，轻则健忘或者烦躁，重者哭笑无常甚至如痴如狂。如果瘀血积蓄于肠道或者胞宫，对膀胱的功能可能没有直接的影响，所以小便通利。如果血直接蓄于膀胱，可出现尿血、小便涩痛等表现。瘀血阻滞导致的行血不畅，在脉象上体现为沉涩。此外女子月经来潮时，因突然受寒或患有其他热性疾病时，外邪趁机内犯，会形成瘀血内结的病症。辨证时需详细询问月经情况。综上所述，本证的临床表现，除有瘀血证的基本特征外，还有小腹部的症状和明显的神志症状。

【用方】

桃核承气汤

——《伤寒论》

方剂说明

破血下瘀。

适用于急性盆腔炎、胎盘滞留、附件炎、肠梗阻、子宫内膜异位症、急性脑出血等属瘀热互结下焦者。

组成

桃仁12g，大黄12g，桂枝6g，炙甘草6g，芒硝6g。

歌曰：桃核承气五般施，甘草硝黄并桂枝。瘀热互结小腹胀，如狂蓄血功最奇。

配伍说明

本方由调胃承气汤减芒硝之量，再加桃仁、桂枝而成。《伤寒论》原治邪在太阳不解，化热随经传腑，与血相搏结于下焦之蓄血证。瘀热互结于下焦少腹部位，故少腹急结；病在血分，与气分无涉，膀胱气化未受影响，故小便自利；夜属阴，热在血分，故至夜发热；心主血脉而藏神，瘀热上扰，心神不宁，故烦躁谵语、如狂。证属瘀热互结下焦，治当因势利导，逐瘀泻热，以祛除下焦之蓄血。方中桃仁苦甘平，活血破瘀；大黄苦寒，下瘀泻热。二者合用，瘀热并治，共为君药。芒硝咸苦寒，泻热软坚，助大黄下瘀泻热；桂枝辛甘温，通行血脉，既助桃仁活血祛瘀，又防硝、黄寒凉凝血之弊，共为臣药。桂枝与硝、黄同用，相反相成，桂枝得硝、黄则温通而不助热；硝、黄得桂枝则寒下又不凉遏。炙甘草护胃安中，并缓诸药之峻烈，为佐使药。诸药合用，共奏破血下瘀泻热之功。服后“微利”，使蓄血除，瘀热清，而邪有出路，诸症自平。

据现代药理研究结果显示，本方中的桃仁具有很显著的折制血凝、抗炎和抗过敏的作用，各种活血化瘀的中药材里被认为是增加血液流量作用最强的药物之一。桂枝则可以促进血液循环，扩张血管；大黄和芒硝通过增强胃肠蠕

动，可排泄体内毒素，改善肠道血液环境，降低毛细血管的通透性，并有较好的抗菌、增强体内免疫功能的作用。因而全方有改善血液循环、消肿止痛，促进体内损伤修复等多方面作用。但是本方治疗神志异常的作用机制仍然有待进一步的研究。

方剂制备

上除芒硝四味药，用水约1500毫升煎煮至剩余500毫升左右药汁时，去药渣，加入芒硝，置火上稍微熬煮，至汤汁稍微沸腾即取下，每次在进食后服用100毫升，1日3次，服后可能解出稀溏大便数次，属于正常反应。

使用注意

1. 本方的作用不外乎破血下瘀，引热下行。如果表证未解者，先当解表，而后用本方。
2. 因本方为破血下瘀之剂，故孕妇禁用。
3. 治疗外感热病的下焦蓄血证时，由于本方清热作用较弱，所以当热势炽盛时切不可单用本方。

临症加减

1. 治疗精神分裂等精神疾病时，可酌量添加琥珀、红花、郁金、青皮等。
2. 妇女伴有附件炎症、月经不调痛经等症状时，可加当归、红花、丹参等



药物活血。

3. 气滞而小腹胀满较严重者，可加香附、乌药、木香等。

4. 瘀血与邪热相夹杂，并且来势较急者，可加黄连、黄芩、栀子、丹皮等。

5. 瘀血内结而疼痛较甚或导致妇女闭经者，可加蒲黄、五灵脂、乳香、没药、延胡索等。

典型案例

王某，女，19岁。小腹胀痛，月经已五月未行。最初发病于体力劳动中，当时月经来潮，淋雨后次日开始小腹疼痛而停经，大便艰涩，小便正常。查体见小腹按之发硬，腹壁拘急，舌质略呈暗紫色，脉细涩。诊断为下焦蓄血证，处方：桃仁12g，大黄12g，桂枝6g，炙甘草6g，芒硝6g，乳香6g，没药6g，水煎服。

病名

慢性消化不良、小儿营养不良、慢性胃炎

中医病名

脾虚食滞证

症状

脾虚食滞证。主要表现为食少难消，脘腹痞闷，大便溏薄，苔腻微黄，脉象虚弱。本方为治疗脾虚食滞之常用方。临床应用以脘腹痞闷，食少难消，大便溏薄，苔腻微黄，脉虚弱为辨证要点。

由于脾胃虚弱，运化水谷的功能减退，所以胃脘胀满，多食则无力消化，导致胀满加剧，脾虚又有食积于内，所以不思饮食。脾虚则食物不得消化，水湿内生，故见大便溏薄。如果食滞比较严重，大便可以有腐臭气味，也可能呈现稀便或者粘液便。全身倦怠无力以及脉虚弱都是脾胃气虚的征象，而苔白腻提示有脾湿。



【用方】 健脾丸——《证治准绳》

方剂说明

健脾和胃，消食止泻。

适用于慢性胃炎、消化不良属脾虚食滞者。

组成

白术15g，木香、黄连、甘草各6g，白茯苓10g，人参9g，神曲、陈皮、砂仁、麦芽、山楂、山药、肉豆蔻各6g。

歌曰：健脾参苓苓草陈，肉蔻香连合砂仁。楂肉山药曲麦炒，消补兼施此方寻。

配伍说明

本方证因脾虚胃弱，运化失常，食积停滞，郁而生热所致。脾胃纳运无力，故见食少难消，大便溏薄；气血生化不足，则倦怠乏力、脉象虚弱；食积阻滞气机，生湿化热，故脘腹痞闷、苔腻微黄。治当健脾与消食并举。本方重用白术、茯苓为君，健脾祛湿以止泻。山楂、神曲、麦芽消食和胃，除已停之积；人参、山药益气补脾，以助苓、术健脾之力，是为臣药。木香、砂仁、陈皮皆芳香之品，功能理气开胃，醒脾化湿，既可解除脘腹痞闷，又使全方补

而不滞；肉豆蔻温涩，合山药以涩肠止泻；黄连清热燥湿，且可清解食积所化之热，皆为佐药。甘草补中和药，是为佐使之用。诸药合用，脾健则泻止，食消则胃和，诸症自愈。

现代药理研究表明健脾丸中的组成成分人参和白术能加强消化系统中各脏器的生理功能，改善消化吸收和代谢的能力。同时可以兴奋神经系统，增强人体的抵抗力，与其他健脾益气的药物同用，对于消化系统的慢性疾病有较好的治疗效果，方中的木香、砂仁、陈皮等药物也有促进胃肠道蠕动，止痛止泻的效果。

方剂制备

方中诸药共研为细末，上笼蒸熟搓成丸药，每粒如绿豆大小，一次服50粒左右，约合6~9g，于空腹时用米汤或白开水送服，1天2次。

使用注意

健脾丸作用平和，不属于大补大泻之剂，但由于方中含有消食清湿热之品，所以由于脾胃虚弱而导致的胃脘痞满、腹部按之空虚柔软者，不适宜使用本方。

临症加减

1. 脾虚食滞者，可去黄连、肉豆蔻，减少神曲、麦芽、山楂等消食导滞药物的用量。



2. 脾虚有食积而无湿热者，或无热反而见四肢不温、便溏、口淡不渴甚至自泛清水者，为脾虚兼寒证，去黄连，酌情添加干姜、附子以温中祛寒。

典型案例

孙某，女，6岁。自幼鼻息不畅，流黏涕，夜间张口呼吸，感冒时尤甚。平素纳谷不馨，大便较干、量少，形体瘦弱，面色不华，鼻镜下见鼻腔黏膜淡红，双下鼻甲稍大，鼻道有黏涕，咽部充血不明显，双侧扁桃体11度肿大，舌质淡红，苔薄腻。处方白术15g，木香6g，黄连6g，甘草6g，白茯苓10g，人参9g，神曲6g，陈皮6g，砂仁6g，麦芽6g，山楂6g，山药6g，肉豆蔻6g，和为丸后嚼服，每次20粒，每日3次。外感鼻塞加重时酌加鼻炎片。

病名

各种急慢性胃肠炎、慢性
胆囊炎、慢性肝炎

中医病名

脾虚食滞证

症状

脾虚食滞证，又名寒热互结之痞证。主要表现为心下痞，但满而不痛，

或呕吐，肠鸣不利，舌苔腻而微黄。本方为治疗中气虚弱、寒热错杂、升降失常而致肠胃不和的常用方，又是体现调和寒热、辛开苦降治法的代表方。临床应用以心下痞满，呕吐泻利，苔腻微黄为辨证要点。

由于脾胃阳气不足，热邪中阻，导致气机不畅，因而胃脘部痞满不舒，但又没有痰饮、瘀血、食滞等有形之邪内结，所以按之柔软而不痛。脾胃虚弱，运化水谷功能下降，在加上热邪影响了脾胃功能，所以造成脾胃升降失常，胃气上逆则干呕或者呕吐，水谷不能正常运化下行，则肠鸣腹泻。诊断时，要注意是否有腹泻，胃脘痞满、肠鸣如大鼓等能反映寒热错杂的病理特点的特征性症状。从病邪性质来说，本证不仅寒热错杂，而且也是虚实并存，一派正虚邪实之象。

【用方】

半夏泻心汤

——《伤寒论》

方剂说明

寒热平调，散结除痞。

适用于急慢性胃肠炎、慢性结肠炎、慢性肝炎、早期肝硬化等属中气虚弱，寒热互结者。



组成

半夏12g，黄芩、干姜、人参各9g，黄连3g，大枣4枚，炙甘草9g。

歌曰：半夏泻心草枣姜，人参芩连共为汤。

配伍说明

此方所治之痞，原系小柴胡汤证误行泻下，损伤中阳，少阳邪热乘虚内陷，以致寒热错杂，而成心下痞。痞者，痞塞不通，上下不能交泰之谓；心下即是胃脘，属脾胃病变。脾胃居中焦，为阴阳升降之枢纽，今中气虚弱，寒热错杂，遂成痞证；脾为阴脏，其气主升，胃为阳腑，其气主降，中气既伤，升降失常，故上见呕吐，下则肠鸣下利。本方证病机较为复杂，既有寒热错杂，又有虚实相兼，以致中焦失和，升降失常。治当调其寒热，益气和胃，散结除痞。方中以辛温之半夏为君，散结除痞，又善降逆止呕。臣以干姜之辛热以温中散寒；黄芩、黄连之苦寒以泄热开痞。以上四味相伍，具有寒热平调，辛开苦降之用。然寒热错杂，又缘于中虚失运，故方中又以人参、大枣甘温益气，以补脾虚，为佐药。使以甘草补脾和中而调诸药。综合全方，寒热互用以和其阴阳，苦辛并进以调其升降，补泻兼施以顾其虚实，是为本方的配伍特点。寒去热清，升降复常，则痞满可

除、呕利自愈。

本方即小柴胡汤去柴胡、生姜，加黄连、干姜而成。因无半表证，故去解表之柴胡、生姜，痞因寒热错杂而成，故加寒热平调之黄连、干姜，变和解少阳之剂，而为调和肠胃之方。后世师其法，随证加减，广泛应用于中焦寒热错杂、升降失调诸症。

根据现代药理研究结果显示，半夏泻心汤方中的半夏具有止呕、祛痰的作用，黄连有广谱抗菌和抑制病毒的作用，还可以兴奋消化道平滑肌。黄芩也有抗菌、抗过敏的作用，与黄连配合，还可以加强利胆及改善人体免疫系统功能的效果。人参、甘草都有强壮作用，可见本方是通过多方面作用来调整胃肠道消化吸收功能的方剂。

方剂制备

方中七味药以水约2000毫升，煎取1200毫升药液后去除药渣继续煎至剩余约600毫升，分1日3次温服。

使用注意

本方主治虚实互见之证，若因气滞或食积所致的心下痞满，不宜使用。

临症加减

1. 水热互结痞证。心下痞硬，干噫食臭，腹中雷鸣下利者，加生姜以和胃消痞，宣散水气。



2. 胃气虚弱痞证。下利日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞硬而满，干呕，心烦不得安者，可用甘草以和胃补中，降逆消痞。

3. 胃中有热，肠中有邪气，腹中痛，欲呕吐的上热下寒证者，可加桂枝寒热并用，以和胃降逆。

典型案例

李某，女性，63岁。失眠反复发作，日渐严重，竟至烦躁不食，胃脘满闷，昼夜不眠，每日只得服安眠药片，才能勉强略睡一时。脉涩而不流利，舌苔黄厚黏腻，大便数日未行，腹部并无胀痛。诊断为寒热互结之痞证，处方：半夏12g，黄芩、干姜、人参各9g，黄连3g，大枣4枚，炙甘草9g，枳实6g，水煎服。

病名

神经性呕吐、
胃扩张

中医病名

呕逆

症状

胃气虚弱，痰浊内阻证。主要表现为心下痞硬，噎气不除，或反胃呕逆，吐涎沫，舌淡，苔白滑，脉弦而虚。本方为治

疗胃虚痰阻气逆证之常用方。临床应用以心下痞硬，噎气频作，或呕吐，呃逆，苔白腻，脉缓或滑为辨证要点。

【用方】

旋覆代赭汤

——《伤寒论》

方剂说明

降逆化痰，益气和胃。

适用于胃神经官能症、胃扩张、慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、幽门不全性梗阻、神经性呃逆、膈肌痉挛等属胃虚痰阻者。

组成

旋覆花9g，人参6g，生姜10g，代赭石9g，炙甘草6g，半夏9g，大枣4枚。

歌曰：旋覆代赭用人参，半夏姜甘大枣随。重以镇逆咸软痞，痞硬噎气力能禁。

配伍说明

本方证因胃气虚弱，痰浊内阻所致胃脘痞闷胀满、频频噎气，甚或呕吐、呃逆等证。原书用于“伤寒发汗，若吐若下，解后，心下痞硬，噎气不除者。”此乃外邪虽经汗、吐、下而解，但治不如法，中气已伤，痰涎内生，胃失和降，痰气上逆之故。而胃虚当

补、痰浊当化、气逆当降，所以拟化痰降逆，益气补虚之法。方中旋覆花性温而能下气消痰，降逆止呕，是为君药。代赭石质重而沉降，善镇冲逆，但味苦气寒，故用量稍小为臣药；生姜于本方用量独重，寓意有三：一为和胃降逆以增止呕之效；二为宣散水气以助祛痰之功；三可制约代赭石的寒凉之性，使其镇降气逆而不伐胃，半夏辛温，祛痰散结，降逆和胃，并为臣药。人参、炙甘草、大枣益脾胃，补气虚，扶助已伤之中气，为佐使之用。诸药配合，共成降逆化痰，益气和胃之剂，使痰涎得消，逆气得平，中虚得复，则心下之痞硬除而呕气、呕呃可止。后世用治胃气虚寒之反胃、呕吐涎沫，以及中焦虚痞而善呕气者，亦效。

方剂制备

方中诸药以水约2000毫升，煎煮至1200毫升后。去除药渣继续煎煮至600毫升。温服200毫升，一日3次。

临症加減

1. 胃气不虚者，去人参、大枣。
2. 痰湿较重者，可加茯苓、川朴、陈皮等。
3. 兼有寒邪客胃脾胃阳气不足者，可加丁香、柿蒂、刀豆等，生姜改用干姜。
4. 胃中有虚热者，可加竹茹、芦根、石斛等清胃止呃。

典型案例

韩某，女，56岁。多年来经常眩晕呕吐，屡治少效，曾诊断为“美尼尔氏综合征”。近半月来，头晕旋转，目黑眼花，卧床不起，起则眩倒，日夜呕吐不止，吐出物纯系黏滑痰涎，饮食不能下咽，烦闷心悸，面色苍黄，两颧微红，精神不振。脉象虚弦而滑，舌苔白腻、中心微黄。诊断证属虚风僭越，痰浊壅阻，病在肝胃二经。法当潜敛肝风，镇平胃逆，尤以温化痰浊为当务之急。处方：旋覆花、枳实、竹茹各9g，煅赭石15g，法半夏、陈皮各6g，生姜3片，水煎服。

病名

急性肠炎、
神经性腹泻

中医病名

痛泻

症状

痛泻。主要表现为肠鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，泻后痛不减或减不足言，舌苔薄白，脉两关不调，弦而缓者。本方为治肝脾不和之痛泻的常用方。临床应用以肠鸣腹痛，大便泄泻，



泻必腹痛，泻后痛缓，脉左弦而右缓为辨证要点。

【用方】 痛泻要方

——《丹溪心法》

方剂说明

补脾柔肝，祛湿止泻。

适用于急性肠炎、慢性结肠炎、肠道易激综合征等属肝旺脾虚者。

组成

白术6g，陈皮4.5g，白芍6g，防风3g。

歌曰：痛泻要方用陈皮，术芍防风共成剂。肠鸣泄泻腹又痛，治在泻肝与实脾。

配伍说明

痛泻之证由土虚木乘，肝脾不和，脾运失常所致。《医方考》说：“泻责之脾，痛责之肝；肝责之实，脾责之虚，脾虚肝实，故令痛泻。”其特点是泻必腹痛。治宜补脾抑肝，祛湿止泻。方中白术苦甘而温，补脾燥湿以治土虚，为君药。白芍酸寒，柔肝缓急止痛，与白术相配，于土中泻木，为臣药。陈皮辛苦而温，理气燥湿，醒脾和胃，为佐药。配伍少量防风，具升散之性，

与术、芍相伍，辛能散肝郁，香能舒脾气，且有燥湿以助止泻之功，又为脾经引经之药，故兼具佐使之用。四药相合，可以补脾胜湿而止泻，柔肝理气而止痛，使脾健肝柔，痛泻自止。

方剂制备

本方作汤剂，水煎服，用量按原方比例酌减。

使用注意

须与食积导致的腹痛相鉴别，以免误投。

临症加减

本方对急性肠炎、慢性肠炎、神经性以及神经性腹泻等出现肝旺脾虚症状者有较好的疗效，如夹有湿热，可加辣蓼、地锦草等。

典型案例

陈某，男，35岁。患慢性肠炎，日泄泻五次。泻前腹中漉漉作响而痛，痛则急登厕，矢气多，溏便掺泡沫。诊断属风泄证，处方：白术12g，白芍9g，陈皮6g，防风3g，水煎服，以和肝健脾。

病名

腹 泻

中医病名

五更泄

症 状

五更泄，亦名肾泄。主要表现为五更泄泻，不思饮食，食不消化，或腹痛肢冷，神疲乏力，舌淡，苔薄白，脉沉迟无力。本方为治命门火衰，火不暖土所致五更泄泻或久泻的常用方。临床应用以五更泄泻，不思饮食，舌淡苔白，脉沉迟无力为辨证要点。

【用 方】

四神丸 —— 《内科摘要》

方剂说明

温肾暖脾，固肠止泻。

适用于慢性结肠炎、肠结核、肠道易激综合征等属脾肾虚寒者。

组 成

肉豆蔻6g，补骨脂12g，五味子、吴茱萸各6g。

歌曰：四神骨脂与茱萸，肉蔻五味

四般须。大枣生姜为丸服，五更肾泄最相宜。

配伍说明

肾泄，又称五更泄、鸡鸣泻，多由命门火衰，火不暖土，脾失健运所致。《素问·金匱真言论》说：“鸡鸣至平旦，天之阴，阴中之阳也，故人亦应之。”五更正是阴气极盛，阳气萌发之际，命门火衰者应于此时，因阴寒内盛，命门之火不能上温脾土，脾阳不升而水谷下趋，故令五更泄泻。正如《医方集解》所云：“久泻皆由肾命火衰，不能专责脾胃”；脾失健运，故不思饮食、食不消化；脾肾阳虚，阴寒凝聚，则腹痛、腰酸肢冷。《素问·生气通天论》曰：“阳气者，精则养神”，脾肾阳虚，阳气不能化精微以养神，以致神疲乏力。治宜温肾暖脾，固涩止泻。方中重用补骨脂辛苦性温，补命门之火以温养脾土，《本草纲目》谓其“治肾泄”，为君药。臣以肉豆蔻温中涩肠，与补骨脂相伍，既可增温肾暖脾之力，又能涩肠止泻。吴茱萸温脾暖胃以散阴寒；五味子酸温，固肾涩肠，合吴茱萸以助君、臣药温涩止泻，为佐药。用法中姜、枣同煮，枣肉为丸，意在温补脾胃，鼓舞运化。诸药合用，俾火旺土强，肾泄自愈。方名“四神”，正如《绛雪园古方选注》所说：“四种之药，治肾泄有神功也。”本方由《普济



本事方》的二神丸与五味子散两方组合而成。二神丸（肉豆蔻、补骨脂）主治“脾肾虚弱，全不进食”；五味子散（五味子、吴茱萸）专治“肾泄”。两方相合，则温补脾肾、固涩止泻之功益佳。原方肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸均未标剂量，后世方书多参照《证治准绳》卷6之四神丸而补。《医方集解》记载本方服法宜在“临睡时淡盐汤或白开水送下”，正如汪昂所云：“若平旦服之，至夜药力已尽，不能敌一夜之阴寒故也。”故嘱患者临睡时服药，更为奏效。本方与真人养脏汤同为固涩止泻之剂，但所治不尽相同。本方重用补骨脂为君药，以温肾为主，兼以暖脾涩肠，主治命门火衰、火不暖土所致的肾泄；真人养脏汤重用罂粟壳为君药，以固涩为主，兼以温补脾肾，主治泻痢日久、脾肾虚寒以脾虚为主的大便失禁。

方剂制备

以上五味，粉碎成细粉，过筛，混匀。另取生姜200g，捣碎，加水适量压榨取汁，与上述粉末泛丸，干燥即得。每服9g，每日1~2次，临睡用淡盐汤或温开水送服；亦作汤剂，加姜、枣水煎，临睡温服，用量按原方比例酌减。

使用注意

本方不适于实邪引起的泄泻，以免助长邪气。

临症加减

1. 伴有腰酸肢冷者，可加附子、肉桂等。
2. 久泻脱肛者，可加黄芪、升麻、葛根等。

典型案例

刘某，男，28岁。患泄泻之症，误治后转为痢疾，小便不通，缠绵经月，被误用俊伐之药，仅服一次即直泻不止，几乎气脱，势甚危殆，气息奄奄。六脉沉细无力，左尺脉浮扎，右尺脉沉伏。诊断为肾命火衰，水泛无归，被妄下，肾命之火愈衰，急宜温固。处方：肉豆蔻6g，补骨脂12g，五味子、吴茱萸各6g为丸以温之。

病名

便血

中医病名

肠风下血

症状

肠风（脏毒）下血。主要表现为便前出血（近血），或便后出血（远血），或粪中带血，以及痔疮出血，血色鲜红或晦暗。本方是治疗肠风下血的



常用方。临床应用以便血，血色鲜红，舌红，脉数为辨证要点。

【用方】 槐花散

——《普济本事方》

方剂说明

清肠凉血，疏风行气。

适用于治疗痔疮、结肠炎或其他大便下血属风热或湿热邪毒，壅遏肠道，损伤脉络者。肠癌便血亦可应用。

组成

槐花12g，侧柏叶12g，荆芥炭6g，枳壳6g。

歌曰：槐花散用治肠风，侧柏荆芥枳壳充。为末等分米饮下，宽肠凉血逐风功。

配伍说明

本方所治肠风、脏毒皆因风热或湿热邪毒，壅遏肠道血分，损伤脉络，血渗外溢所致。“肠风者，下血新鲜，直出四射，皆由便前而来……脏毒者，下血瘀晦，无论便前便后皆然”（《成方便读》）。治宜清肠凉血为主，兼以疏风行气。方中槐花苦微寒，善清大肠湿热，凉血止血，为君药。侧柏叶味苦微寒，清热止血，可增强君药凉血止血之

力，为臣药。荆芥穗辛散疏风，微温不燥，炒用入血分而止血；因大肠气机被风热湿毒所遏，故用枳壳行气宽肠，以达“气调则血调”之目的，共为佐药。诸药合用，既能凉血止血，又能清肠疏风，俟风热、湿热邪毒得清，则便血自止。本方具有寓行气于止血之中，寄疏风于清肠之内，相反相成的配伍特点。

方剂制备

为细末，每服6g，开水或米汤调下；亦可作汤剂，水煎服，用量按原方比例酌定。

使用注意

本方药性寒凉，故只可暂用，不宜久服。便血日久属气虚或阴虚者，以及脾胃素虚者均不宜使用。

临症加减

1. 如肠热较盛者，可加黄连、黄柏清肠泻热。
2. 出血量多者，可加地榆、茜草炭等止血。

典型案例

李某，男，25岁。大便有血超过1年，便后肛门灼热疼痛，血色鲜红。舌红苔黄，脉数。诊断为肠热便血症。处方：槐花12g，侧柏叶12g，荆芥炭6g，枳壳6g，黄连6g，黄柏6g，水煎服。



便秘

病名

便秘

中医病名

肠燥便秘证

症状

肠燥便秘证即为脾约证，由于肠胃燥热，脾津不足所致。脾为胃行其津液，胃中燥热，脾受约束，津液不能四布，但输膀胱故小便频数；燥热伤津，肠失濡润，则大便秘结。本方为治疗肠胃燥热，脾津不足的常用方，又是润下法的代表方。临床应用以大便秘结，小便频数，舌苔微黄少津为辨证要点。

【用方】

麻子仁丸（脾约丸）

——《伤寒论》

方剂说明

润肠泻热，行气通便。

适用于虚人及老人肠燥便秘、习惯性便秘、产后便秘、痔疮术后便秘等属胃肠燥热者。

组成

麻子仁20g，白芍9g，枳实9g，大黄12g，厚朴9g，杏仁10g。

歌曰：麻仁丸用小承气，杏芍麻仁治便秘。

配伍说明

本方证乃因胃肠燥热，脾津不足所致，《伤寒论》称之为“脾约”。成无己说：“约者，约结之约，又约束也。经曰：脾主为胃行其津液者也，今胃强脾弱，约束津液不得四布，但输膀胱，致小便数而大便硬，故曰其脾为约。”

（《伤寒明理论》）根据“燥者润之”“留者攻之”的原则，故当润肠泻实，宜润肠药与泻下药同用。方中麻子仁性味甘平，质润多脂，功能润肠通便，是为君药。杏仁上肃肺气，下润大肠；白芍养血敛阴，缓急止痛为臣。大黄、枳实、厚朴即小承气汤，以轻下热结，除胃肠燥热为佐。蜂蜜甘缓，既助麻子仁润肠通便，又可缓和小承气汤攻下之力，以为佐使。综观本方，虽用小承气以泻下泄热通便，而大黄、厚朴用量俱从轻减，更取质润多脂之麻仁、杏仁、芍药、白蜜等，一则益阴增液以润肠通便，使腑气通，津液行，二则甘润减缓小承气攻下之力。本方具有下不伤正、润而不膩、攻润相合的特点，以达润肠、通便、缓下之功，使燥热去，阴液

复，而大便自调。

本方为丸剂，而且只服10小丸，依次渐加，均意在缓下，润肠通便。

方剂制备

上六味，蜜和丸，如梧桐子大，饮服十丸，日三服，渐加，以知为度（现代用法：上药为末，炼蜜为丸，每次9g，每日1~2次，温开水送服。亦可按原方用量比例酌减，改汤剂煎服）。

使用注意

本方虽为润肠缓下之剂，但含有攻下破滞之品，故年老体虚，津亏血少者不宜常服，孕妇慎用。

临症加减

1. 津伤严重者，可加沙参、生地、麦冬、玄参等。
2. 大便坚硬难解者，可加玄明粉等。

典型案例

丁某，男，72岁。平素体虚，大便秘结，小便频数，数年。查体舌苔微黄少津，脉虚数。处方：麻子仁20g，白芍9g，枳实9g，大黄12g，厚朴9g，杏仁10g，用蜜和丸，如梧桐子大，饮服10丸，1日3次。

病名

黄疸性肝炎

中医病名

黄疸

症状

湿热黄疸（阳黄）。主要表现一身面目俱黄，黄色鲜明，腹微满，口中渴，小便短赤，舌苔黄腻，脉沉数等。本方为治疗湿热黄疸之常用方，其证属湿热并重。临床应用以一身面目俱黄，黄色鲜明，舌苔黄腻，脉沉数或滑数有力为辨证要点。

【用方】

茵陈蒿汤

——《伤寒论》

方剂说明

清热利湿退黄。

适用于急性黄疸型传染性肝炎、胆囊炎、胆石症、钩端螺旋体病等所引起的黄疸，证属湿热内蕴者。

组成

茵陈18g，栀子9g，大黄6g。



歌曰：茵陈蒿汤治阳黄，栀子大黄组成方。栀子柏皮加甘草，茵陈四逆治阴黄。

配伍说明

本方为治疗湿热黄疸之常用方，《伤寒论》用其治疗瘀热发黄，《金匮要略》以其治疗谷疸。病因皆缘于邪热入里，与脾湿相合，湿热壅滞中焦所致。湿热壅结，气机受阻，故腹微满、恶心呕吐、大便不爽甚或秘结；无汗而热不得外越，小便不利，则湿不得下泄，以致湿热熏蒸肝胆，胆汁外溢，浸渍肌肤，则一身面目俱黄、黄色鲜明；湿热内郁，津液不化，则口中渴。舌苔黄腻，脉沉数为湿热内蕴之征。治宜清热，利湿，退黄。方中重用茵陈为君药，本品苦泄下降，善能清热利湿，为治黄疸主药。臣以栀子清热降火，通利三焦，助茵陈引湿热从小便而去。佐以大黄泻热逐瘀，通利大便，导瘀热从大便而下。三药合用，利湿与泄热并进，通利二便，前后分消，湿邪得除，瘀热得去，黄疸自退。

方剂制备

方中三味药，以水2400毫升先煮茵陈，至1200毫升时放入栀子、大黄，煮至600毫升去除药渣后分3次服用。

临症加減

1. 伤寒身热发黄者，加甘草、黄柏。功用：清热利湿。

2. 黄色晦暗，皮肤冷，背恶寒，手足不温，身体沉重，神倦食少，脉紧细或沉细无力者，加干姜、炙甘草、附子。功用：温里助阳，利湿退黄。

典型案例

男婴，3个月。因发热咳嗽，按支气管肺炎治疗，经用大量抗生素至第6天高热不退，巩膜皮肤出现黄染，以后黄疸日益加深，纳呆泛恶。检查肝脾肿大，HBsAg酶联法阳性，在其新鲜尿内找到巨细胞核内包涵体而确诊为巨细胞包涵体病。尔后黄疸进一步加深，黄中带青，诊视患儿精神极度萎顿，纳呆，泛恶，指纹已达命关，色紫红。细审黄疸，青黄之中仍映鲜红，小便如麝色，为胎毒内蕴，湿热熏蒸至深，阳黄重证，大实而见羸状，速投绵茵陈10g，焦山栀10g，生苡仁15g，制川军6g，虎杖10g，秦艽10g，土茯苓15g，平地木10g，焦麦芽15g，生甘草6g，水煎剂。



病名

肠道蛔虫病、
胆道蛔虫病

中医病名

蛔厥证

症状

蛔厥证。腹痛时作，心烦呕吐，时发时止，常自吐蛔，手足厥冷。本方为治疗脏寒蛔厥证的常用方亦治久痢久泻。临床应用以腹痛时作，烦闷呕吐，常自吐蛔，手足厥冷为辨证要点。

【用方】

乌梅丸——《伤寒论》

方剂说明

温脏安蛔。

适用于治疗胆道蛔虫病、慢性菌痢、慢性胃肠炎、结肠炎等证属寒热错杂，气血虚弱者。

组成

乌梅30g，细辛3g，干姜9g，黄连6g，当归6g，附子6g，蜀椒5g，桂枝6g，人参6g，黄柏6g。

歌曰：乌梅丸用细辛桂，黄连黄柏

及当归。人参椒姜加附子，清上温下又安蛔。

配伍说明

蛔厥之证，是因患者素有蛔虫，复由肠道虚寒，蛔虫上扰所致。蛔虫本喜温而恶寒，故有“遇寒则动，得温则安”之说。蛔虫寄生于肠中，其性喜钻窜上扰。若肠道虚寒，则不利于蛔虫生存而扰动不安，故脘腹阵痛、烦闷呕吐，甚则吐蛔；由于蛔虫起伏无时，虫动则发，虫伏则止，故腹痛与呕吐时发时止；痛甚气机逆乱，阴阳之气不相顺接，则四肢厥冷，发为蛔厥。本症既有虚寒的一面，又有虫扰气逆化热的一面，针对寒热错杂、蛔虫上扰的病机，治宜寒热并调、温脏安蛔之法。方中重用味酸之乌梅，取其酸能安蛔，使蛔静则痛止，为君药。蛔动因于肠寒，蜀椒、细辛辛温，辛可伏蛔，温可祛寒，共为臣药。黄连、黄柏性味苦寒，苦能下蛔，寒能清解因蛔虫上扰，气机逆乱所生之热；附子、桂枝、干姜皆为辛热之品，既可增强温脏祛寒之功，亦有辛可制蛔之力；当归、人参补养气血，且合桂枝以养血通脉，以解四肢厥冷，均为佐药。以蜜为丸，甘缓和中，为使药。本方的配伍特点：一是酸苦辛并进，使“蛔得酸则静，得辛则伏，得苦则下”；二是寒热并用，邪正兼顾。关于久泻久痢，多呈脾胃虚寒，肠滑失



禁，气血不足而湿热积滞未去之寒热虚实错杂证候，本方集酸收涩肠、温阳补虚、清热燥湿诸法于一方，切中病机，故每可奏效。

方剂制备

乌梅用50%醋浸一宿，去核捣烂，和入余药捣匀，烘干或晒干，研末，加蜜制丸，每次服9g，日服2~3次，空腹温开水送下；亦可作汤剂，水煎服，用量按原方比例酌减。

临症加减

1. 无寒象者，可去附子、桂枝。
2. 正气不虚者，可去人参、当归。
3. 腹痛甚者，可加木香、延胡索。
4. 呕吐甚者，可加姜半夏、吴茱萸。

典型案例

患者女性，48岁。患大便溏泄七八年。服多种中西药乏效。西医诊断为过敏性结肠炎。平日大便1~2次，扁而细。如饮食过多，或食肥肉，或食脂肪过多（如牛乳），即便次增多，每日2~6次。腹隐痛，人瘦，面色萎白，舌红苔白，脉象正常。处方：乌梅30g，细辛3g，干姜9g，黄连6g，当归6g，附子6g，蜀椒5g，桂枝6g，人参6g，黄柏6g，练蜜为桐子大小丸，每服10丸，食前以温水送下，1日3次。

病名

急性肠炎、痢疾、
肠伤寒

中医病名

肠道湿热证

症状

肠道湿热证，主要表现为身热下利，胸脘烦热，口中作渴，喘而汗出，舌红苔黄，脉数或促。本方简称葛根芩连汤，是治疗热泻、热痢的常用方。临床应用以身热下利，苔黄脉数为辨证要点。

由于湿热蕴阻于肠道，小肠及大肠的分清泌浊与传导功能异常，清浊不分，合污而下则作腹泻。因属湿热为患，所以伴有身热，泻下物多色黄褐而臭秽，或泻下急迫，势如水注，或腹痛即泻。此证如从表证转变而来，但表证仍未解者，则可伴见微恶寒。湿热内扰，则胸脘闷热，热邪伤阴则口干口渴。里热外蒸则汗出，肠热上迫于肺，则可见喘急。但上述恶寒、汗出、喘急诸症并非必见症。苔黄腻脉数则为湿热内盛的表现。肠道湿热内蕴也可以导致痢疾，其腹泻以里急后重、便下脓血为特点，但中医学辨证时一般认为其属积滞与湿热互结于肠道，因而其诊治与本证略有不同，可参考痢疾辨证与治法。

【用方】

葛根黄芩黄连汤 (葛根芩连汤)

——《伤寒论》

方剂说明

解表清里。

适用于急性肠炎、细菌性痢疾、肠伤寒、胃肠型感冒等属表证未解、里热甚者。

组成

葛根15g，甘草6g，黄芩、黄连各9g。

歌曰：葛根黄芩黄连汤，再加甘草共煎尝。邪陷阳明成热痢，清化肠热保安康。

配伍说明

本方证是因伤寒表证未解，邪陷阳明所致。此时表证未解，里热已炽，故见身热口渴、胸闷烦热、口干作渴；里热上蒸于肺则作喘，外蒸于肌表则汗出；热邪内迫，大肠传导失司，故下利臭秽、肛门有灼热感；舌红苔黄，脉数，皆为里热偏盛之象。表未解而里热炽，治宜外解肌表之邪，内清肠胃之热。方中重用葛根为君，甘辛而凉，入脾胃经，既能解表退热，又能生发脾胃清阳之气而治下利。以苦寒之黄连、黄

芩为臣，清热燥湿，厚肠止利。甘草甘缓和中，调和诸药，为本方佐使。四药合用，外疏内清，表里同治，使表解里和，热利自愈。原方先煮葛根，后纳诸药，可使“解肌之力优而清中之气锐”（《伤寒来苏集》）。本方功能解表清里，然从药物配伍作用来看，显然以清里热为主，正如尤怡所云：“其邪陷于里者十之七，而留于表者十之三。”由于葛根能清热升阳止利，汪昂称之“为治泻主药”，故本方对热泻、热痢，不论有无表证，皆可用之。

根据现代药理研究，葛根能解热和缓解平滑肌的痉挛状态、提高胃液和胆汁的分泌数量，所以能够显著改善胃肠功能。黄芩、黄连都含有广谱抗菌的成分，尤其对一些肠道细菌更为有效。甘草可以抗过敏、止痛。综合全方的作用，对肠道的炎症能取得较好的疗效是有其药理基础支持的。

方剂制备

方中诸药，以水1600毫升先煮葛根，约剩余1200毫升时放入其他各味，煮取400毫升，去药渣，温服。

使用注意

虚寒下利者忌用。

临症加减

1. 腹痛者，加炒白芍以柔肝止痛。



2. 热痢里急后重者，加木香、槟榔以行气而除后重。

3. 兼呕吐者，加半夏以降逆止呕。

4. 夹食滞者，加山楂以消食。

实例练习

马某，男，70岁，前日饮食不慎，骤患腹痛泄泻，一日四五次，腹痛即急如厕，便后有下坠感，微觉恶寒热，食欲不振。舌苔薄白，脉象弦数。辨证：年已七旬，脾胃本弱，饮食不洁，再受外感，则发寒热腹泻。水谷不分，病出中焦，脉象弦数，内蕴有热，处方：酒黄芩6g，苍术炭6g，血余炭（炒车前子10g同布包）6g，酒黄连5g，白术炭6g，煨葛根10g，焦内金10g，炙草梢3g，白通草5g，焦薏仁15g，炒香豉10g，赤小豆10g，赤茯苓10g，水煎服。

《高士王常杜中醫神書》

中醫秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

中者、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

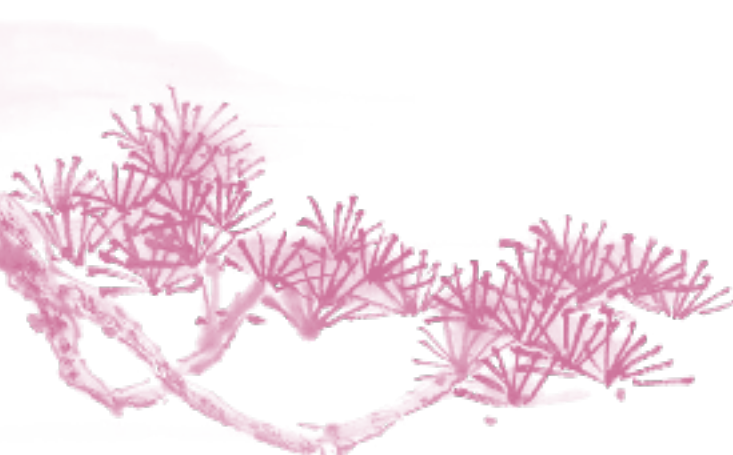
秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方



第四章

循环系统疾病

本書上中冊杜中醫視毒、
視毒中書視方、脈方、
視方等視方圖的視方中詩
書中書書書是視視四
視方，共視而百餘方。視
方古今視多名方、視
視方，不勝易視、易
視方、指錄指書，而上
視方，對某些視視視
視視想不視視懷視，視
視視，視視合廣大中視
視視視。

這些視方大視分視四大
一視視視方，二視食視
三視中書樂視方，四
視方用視方，五視日常
視方，六視視視方視



病名

败血症、脓毒血症

中医病名

火毒壅盛证

症状

火毒热盛证。主要表现为大热烦躁，口燥咽干，谵语不眠；或热病吐血，衄血；或热甚发斑，身热下利，湿热黄疽；外科痈疡疔毒，小便黄赤，舌红苔黄，脉数有力。本方为苦寒直折，清热解毒的基础方。临床应用以大热烦躁，口燥咽干，舌红苔黄，脉数有力为辨证要点。

本证为火热之毒壅盛闭塞于局部位置或充斥于全身上下内外所导致，因火毒炽盛，故必有发热、口燥咽干等表现，同时又因为火毒壅堵，阻遏气机运行所以可见局部位置发生红肿热痛，甚至出现化脓、疮疡疔毒等。另外火毒盛于内，常迫血妄行，溢出于血脉之外则可见皮肤发斑或各种出血，如吐血、衄血、便血、尿血等。火热上扰心神，则可见狂躁易怒，或者神志不清，胡言乱语，火热灼伤阴津，津液不足，可见小便黄赤短少，口苦也是火热郁结于内而成毒的一个代表性标志，是本病的一个主要症状。另外本证中的头痛、

身痛等疼痛可以表现得非常剧烈，与外感表证的外邪客于体表经脉之气阻滞不通所导致的头身疼痛有本质的区别，本证的头身疼痛是因火热毒邪过盛灼伤经筋引起的，故常剧烈表现为头痛如劈、身痛如被杖。而舌红苔黄也是火热内盛的典型表现。

本证与阳明气分证一样是由无形热邪所引起，但是阳明气分证邪热浮盛于肌表，如气热之名，邪热客于气分，故见证身大热、汗大出、口大渴、脉洪大的典型四大证。而本证邪热倾向于壅滞于内，郁结不发，故往往导致红肿痛疽，发斑出血等症状，而没有大汗大渴的迫津外出的表现。此二证临床表现都具有比较明显的特点，一般不容易混淆，不过有时也可同时出现，形成火热之邪充斥表里上下的局面，临床诊断是应加以注意。

【用方】

黄连解毒汤

——《外台秘要》

方剂说明

泻火解毒。

适用于败血症、脓毒血症、痢疾、肺炎、泌尿系感染、流行性脑脊髓膜炎、乙型脑炎以及感染性炎症等属热毒为患者。



组成

黄连9g，黄芩6g，黄柏6g，栀子9g。

歌曰：黄连解毒柏栀芩，火盛三焦是病因。烦狂大热兼痈疮，吐衄发斑此方寻。

配伍说明

本方证乃火毒充斥三焦所致。火毒炽盛，内外皆热，上扰神明，故烦热错语；血为热迫，随火上逆，则为吐衄；热伤络脉，血溢肌肤，则为发斑；热盛则津伤，故口燥咽干；热壅肌肉，则为痈肿疔毒；舌红苔黄，脉数有力，皆为火毒炽盛之证。综上诸症，皆为实热火毒为患，治宜泻火解毒。方中以大苦大寒之黄连清泻心火为君，因心主神明，火主于心，泻火必先泻心，心火宁则诸经之火自降，且兼泻中焦之火。臣以黄芩清上焦之火。佐以黄柏泻下焦之火；使以栀子清热解毒、利湿，善清泻心肺胃三焦而泻火除烦，且又可凉血止血、消肿止痛。其炒炭则入血分而凉血止血，通泻三焦，导热下行，是火热从小（小便）而去。四药合用，苦寒直折，火邪去而热毒解，诸证可愈。

中医学中，对于无形之邪的清热之法，按照药物所具有的不同性质来划分的话，可以主要分为辛寒、苦寒、干寒三个大的类别。辛寒清热的药物主要适

用于阳明气分的邪热浮盛之证，代表方剂是白虎汤，以向外透达的方式解在气分的邪热；苦寒的药材适用于火热壅聚于内，郁阻而成毒之证，代表方剂可推黄连解毒汤，可以直接挫折火势，清除火热之邪毒；而甘寒之品则多用于因阴液不足而发热之阴虚热证，概甘性之品可以补不足之故。

根据现代药理研究结果显示，黄连解毒汤的药理成分中，含有具有较强的抗菌抗病毒作用的成分，可以促进淋巴细胞比如吞噬细胞的活性，刺激其吞噬作用，并对调节人体免疫系统的状态有较大效果。而本方中所使用的黄连、黄芩、黄柏三黄及栀子都分别具有抗菌、利胆、降血压和调节免疫功能的作用，协同使用可以获得配合发挥药效的效果。

方剂制备

本方药材取水约1200毫升，煎煮至药液量约剩余1/3为止，滤去残渣后，药液均分3份，顿服。也有制成水丸或蜜丸的剂型。

使用注意

1. 本方泻火解毒之力颇强，以大热烦扰，口燥咽干，舌红苔黄，脉数有力为证治要点。但大苦大寒之剂，久服易伤脾胃，非火盛者不宜使用。

2. 火毒与热毒的区别：火毒多指外



亮的痈疡等；热毒多指身热发斑等。

3. 如病人素体虚寒而患火毒之证，适用本方时应特别注意不可过量过久，以免阳气受伤。

4. 如表证发热或阳明气分证发热而误投本方，可能导致病邪入里蛰伏而难治，同时本方对于有形之热邪结于内的病症也没有治本之能，辨证时尤应留心。

临症加减

1. 火毒内蕴而身发黄疸，可加茵陈、大黄。

2. 热盛而阴津耗伤过甚，加生地、麦冬、玄参等滋养阴液。

3. 热毒炽盛、迫血妄行，导致出血证的，可去栀子、黄柏，黄芩用到9g，再加黄连3g泻火解毒，即取大黄泻心火之能。

典型案例

刘某，男，35岁。因贪凉饮冷而下痢。症见高热不已，腹痛腹泻，里急后重，下脓血便，日行10余次。诊时患者急性病容，舌红，苔黄，脉数。体温39.2摄氏度。大便常规：脓细胞++，红细胞+++。诊断为急性细菌性痢疾（湿热型，热重于湿）。治以清热燥湿，凉血止痢。方用黄连解毒汤合白头翁汤加减：黄连4g，炒栀子10g，黄芩10g，黄柏10g，白头翁20g，地榆炭15g，秦皮12g，木香6g，槟榔12g，水煎服。

病名

急性白血病、DIC（弥散性微血管内凝血）

中医病名

血分热盛证

症状

1. 热入血分证。主要表现为身热谵语，斑色紫黑，舌绛起刺，脉细数，或喜忘如狂，漱水不欲咽，大便色黑易解等。2. 热伤血络证。主要表现为高热，吐血，衄血，便血，尿血等，舌红绛，脉数。本方是治疗温热病热入血分证的常用方。临床应用以各种失血，斑色紫黑，神昏谵语，身热舌绛为辨证要点。

血分热盛证重要的病理特点是血分有热而迫血妄行，即所谓热盛动血，所以症状除了可有发热、舌色深降等热证表现外，还有血液溢出脉外的出血表现。比如皮下有溢血则可见斑疹，早期发现时一般颜色鲜红，过一段时间后则会呈现紫黑色，而肺或胃被热伤而出血的话，则会从上溢出，表现为吐血，衄血，而肠腑、膀胱、子宫等器官受热伤出血的话则血从下溢，表现为便血，尿血，阴道不正常出血等症状。如邪热上扰心神，则也可见神志不清，甚至胡言乱语等症状。而内有出血不化，时间



一久则凝成瘀血，加之本身血分有热，煎熬之下也会形成瘀血，所以本证另外有一个重要的病理特点，就是瘀血内生并与邪热相纠结，形成瘀热。有热瘀血瘀阻于内，津液不能上下而分布之职不行，所以可见口干，但因津液并未大量耗伤，又可表现为漱水而不欲咽。

本症虽然以发热为主要表现症状，但在内伤杂病中其实并不一定伴有身体物理温度的升高，多为患者自身自觉身体发热，尤其以手足心及头面部口唇等处明显，这也是血分有热的有力佐证。对于血分热盛证来说，因为会导致发斑、出血等症状，所以也有称为血分热毒证的说法，也就是属于火毒壅盛证范围，但是病变还是主要局限于血分范围内，也具有一定的诊断意义。

【用方】犀角地黄汤——

《小品方》录自《外台秘要》

方剂说明

清热解毒，凉血散瘀。

适用于重症肝炎、肝昏迷、弥漫性血管内凝血、尿毒症、过敏性紫癜、急性白血病、败血症等属血分热盛者。

组成

犀角30g，地黄24g，赤芍药12g，牡

丹皮9g。

歌曰：犀角地黄芍药丹，热盛血分服之安。

配伍说明

本方治证由热毒炽盛于血分所致。心主血，又主神明，热入血分，一则热扰心神，致躁扰昏狂；二则热邪迫血妄行，致使血不循经，溢出脉外而发生吐血、衄血、便血、尿血等各部位之出血，离经之血留阻体内又可出现发斑、蓄血；三则血分热毒耗伤血中津液，血因津少而浓稠，运行涩滞，渐聚成瘀，故舌紫绛而干。此际不清其热则血不宁，不散其血则瘀不去，不滋其阴则火不熄，正如叶天士所谓“入血就恐耗血动血，直须凉血散血。”治当以清热解毒，凉血散瘀为法。方中以水牛角为君，清心肝而解热毒，直入血分而凉血；臣以生地清热凉血，养阴生津，一可收复已失之阴血，二是助水牛角解血分热，又能解血分热。用苦微寒之赤芍与辛苦微寒之丹皮共为佐药，清热凉血，活血散瘀，可收化斑之功。四药相配，共成清热解毒，凉血散瘀之剂。本方配伍特点是凉血与活血散瘀并用，使热清血宁而无耗血动血之虑，凉血止血又无冰伏留瘀之弊。本方与清营汤均以犀角、生地为主，以治热入营血证。但清营汤是在清热凉血中伍以银花、连翘等轻清宣透之品，寓有“透热转气”之

意，适用于邪初入营尚未动血之证；本方配伍赤芍、丹皮泄热散瘀，寓有“凉血散血”之意，用治热入血分而见耗血、动血之证。

根据现代药理研究显示，本方中的主要药材犀角中还有具有强心、镇静作用的成分，而地黄除了能强心之外，增加血液粘稠度，促进血液凝固，有止血外溢的功能。赤芍本身对多种致病菌有抑制作用，同时还能够扩张血管，加快血液流动，丹皮也具有兴奋血液循环的功能，此外还能镇静镇痛抗炎解热。由分析结果可见，犀角地黄汤并不是一个单纯退热的方剂，而是针对血分热证的各方面病理原因及表现症状能发挥多种效能药材的良方。

与清营汤的区别：两者均以犀角、生地为主，以治热入营血证。但清营汤是在清热凉血中伍以清气分之品，以使入营之热转从气分而解，适用于邪初入营尚未动血证。而本方着重清热解毒，凉血散瘀，用治热毒深陷血分，而见耗血、动血证。

方剂制备

犀角研磨细汁，其余各味药材用水煎，煎好滤去药渣，将犀角汁混入药汁中相和服用，或犀角切片，与其他药材共同水煎服。

使用注意

1. 热入营分与热入血分的区别：营分：身热夜甚，时有谵语，神烦少寐，斑疹隐隐，脉数，舌绛而干；血分：身热，谵语，喜忘如狂，斑色紫黑，脉细数入血耗津，舌绛起刺。

2. 本方针对病症多数是危重紧急的情况，故须特别注意辨证及用药量的准确性，比如阳气不足、心脾不足等导致的不能摄血或阴液亏虚而虚热旺盛、迫血妄行等所引发的出血症均不适用本方。同时犀角地黄汤性质寒凉，故平素即阳虚脾胃运化能力不强，使用本方是要适时适量，不可久服。除部分慢性病之外，适用本方的病人均应住院，处于医生的严密监护之下，以便出现危机状况时能得到及时的抢救。

临症加减

1. 热毒炽盛者，可加黄连、金银花、连翘、板蓝根、大青叶等药物清解。
2. 心火亢盛，心烦躁热不安者，加黄连、栀子清泻心火。
3. 邪热闭阻心包而神志昏蒙不清者，可加安宫牛黄丸同用。
4. 吐血、衄血严重者，可加白茅根、侧柏叶、旱莲草等。
5. 如有便血，可加地榆炭、槐花炭等。
6. 患者有尿血症状，加白茅根、小



藟等。

7. 火热之毒不只攻陷血分，而充斥于表里上下者，可与黄连解毒汤或清瘟败毒饮合用，清热解毒之力可大幅增强。

典型案例

蒋某，男，32岁。暑期中每日游泳，因骄阳外袭，水湿内蕴。夏末秋初之际，渐发高热，因身体强健，最初尚不以为意；一月后，渐渐疲备，难以支持。脉浮按弦，重按细而数。舌绛苔黄，仅能食流质，尤喜冷饮。小溲短赤，大便日行而量少。诊为湿郁化热，热传下焦，恐有伤络便血之虞，处方：犀角1.5g（另煎分冲），生赤芍9g，粉丹皮9g，鲜生地15g，鲜扁斛15g，黑山栀9g，淡芩4.5g，赤苓9g，青蒿9g，天花粉9g，水煎服。

病名

渗出性胸膜炎、肝硬化腹水、肾炎水肿

中医病名

水饮证

症状

1. 悬饮。主要表现为咳唾胸胁引痛，心下痞硬，干呕短气，头痛目眩，

或胸背掣痛不得息，舌苔滑，脉沉弦。

2. 水肿。主要表现为一身悉肿，尤以下半身重，腹胀喘满，二便不利。

水饮分布的部位不同可以出现相应的不同症状。例如水饮停于胸胁部位即为胸水，位置决定必定影响肺的宣降功能，症状上可见气短呼吸困难，喘急等。同时可能导致胸胁疼痛，疼痛的特点是在咳嗽和深呼吸时加剧，还会伴有可以延伸到背部的牵引痛。同时水饮影响肺部功能会引发咳嗽气喘，影响胃部则使胃气不平而干呕。如水饮停留于腹部，既是腹水，症状可见腹部肿大胀满，甚至腹大如鼓。水饮聚集则气机阻滞，在胃脘部可以表现为痞满、胀闷，严重者可见腹壁坚硬。如水饮泛滥于肌肤，则表现为水肿，特点一般表现为肿胀严重，日久不消，并且以下肢为甚。

由于水饮内停，水液不能正常代谢，所以小便量小。有的病人还会表现出大便秘结，这与水气阻滞、肠腑传导功不能正常运行有关。而舌苔滑润、脉诊沉弦均为水饮内停的表现。由此可见，水饮证的症状多由有形之邪引起，在诊断时除了注意以上临床表现之外，还可以结合胸水、腹水的现代检查方法，包括听诊、叩诊、X射线检查、超声检查和穿刺等帮助诊断。然而水饮又往往是由体内脾、肺、肾、心、肝等脏腑发生病变后，影响了水液代谢而产生的，所以发现现有水饮停聚的现象后，还需要进一步

检查辨证，找出水饮产生的根本原因，不能只停留在水饮证的诊断上。

【用方】 十枣汤——《伤寒论》

方剂说明

攻逐水饮。

临床上常应用于结核性胸膜炎、肝硬化腹水、晚期血吸虫病腹水、结核性腹膜炎等病引起的胸腔或腹腔积液，也用于慢性肾炎产生的全身水肿。服用后，随着大便排出大部分水液，小便量也会相应增多，体内水饮可逐渐减少以至消失。由于本方对人体的内脏、血液循环、神经、免疫等系统都具有一定的调节作用，所以本方还可以用于胃酸过多、精神分裂症、神经痛等多种疾病出现水饮内伏症状的情况，尤其对于一些顽固难去的水饮，多数可以起到一定效果。

组成

甘遂、大戟、芫花各等分，分别捣为散，煮大枣十枚，纳药末。强人服2g，羸人服1g，温服，平旦服。得快下利后，糜粥自养。

歌曰：十枣遂戟与芫花，攻逐水饮效堪夸。

配伍说明

十枣汤所针对的内停水饮均为水液大量积聚的有形之邪，并非一般化湿、利水的方法可以奏效。故方中使用大戟、甘遂、芫花等峻泻逐水之品。方中甘遂苦寒有毒，善行经髓络脉之水湿。芫花辛温有毒，善消胸胁伏饮痰癖。大戟苦寒有毒，善泻脏腑之水邪。三药峻烈，各有专攻，合用之，则攻逐水饮之功甚著。用大枣十枚煎汤送服，意在益脾缓中，防止逐水过猛伤及脾胃，并可缓和诸药之毒性，使邪去而不伤正气。本方之所以命名为十枣汤，也是由于大枣在本方中所占有的重要地位。

根据现代药理研究结果显示，十枣汤的成分组成中，大戟、甘遂和芫花均有刺激肠道平滑肌，增加肠蠕动频率，引起腹泻特别是水泻的作用，三药均可利尿，其中大戟的效果稍微缓和，药毒性也比较低。在通利大小便的同时，这三味药材也能对人体的内脏、血液循环系统、神经系统和免疫系统起到一定的调节作用。

方剂制备

上三味药材分别研磨为细末，混合均匀。取约300毫升清水，煮大枣10枚，取枣汤约160毫升，身体健壮者取药末1~1.5g，体质虚弱者取药末0.6~1g，混合枣汤服下。清晨空腹温服，一日一



次。正常取效应药后大便作水泻，如水饮未净可隔日再依法服用。现代也有将混合药粉装入胶囊内，每粒0.5g，根据身体状况一次1~3粒，以大枣10~15枚煎汤，清晨空腹送服。

使用注意

1. 使用方法：一是三药为散，大枣煎汤送服；二是从小量开始，且于清晨空腹服用；三是服药得快利后，宜食糜粥以保养脾胃。

2. 十枣汤为攻邪治标之剂，虽有大枣保护胃气，毕竟易伤正气，所以在使用时除需要对水饮证的辨证准确无误之外，还需要注意病人体质不同及服药后的反应。如果病人体质差，需要先补养正气，或攻补兼施。服药后如水饮未尽，需要确认病人正气尚强才可以继续服用，否则需要暂停用药，待正气恢复后再用。在剂量上也要先用小量，如病人身体可以承受并且水饮尚余，才可以继续服药，决不能贸然妄用。

3. 如服药后腹泻不止，可服冷稀粥以止泻，注意病人是否有脱水状况及电解质失衡表现。

4. 去除水饮之邪后还需找到引发水饮的病因。

临症加减

壮实人风痰郁热，肢体麻痹，走注疼痛湿热肿满，气血壅滞，不得宣通，

及积痰翻胃者，原方不用大枣，加大黄、黑丑、轻粉，合为水丸，名三花神佑丸。

典型案例

韩某，女，19岁。发热胸痛5天，以右侧为主，深呼吸及咳嗽的时候加重，呼吸浅短急促，自觉头昏重。查体右侧胸廓、肋间饱满，呼吸运动减弱，气管向左移位，叩诊右胸成浊音，下部实音。听诊呼吸音减弱，语颤消失。舌苔白滑，舌质嫩红。脉诊沉弦。诊断为水饮悬胸证，处方十枣汤。

病名

中风、中风后遗症

中医病名

气虚血瘀证

症状

气虚血瘀证。主要表现为半身不遂，口眼歪斜，语言蹇涩，口角流涎，小便频数或遗尿不禁，舌暗淡，苔白，脉缓。本方既是益气活血法的代表方，又是治疗中风后遗症的常用方。临床应用以半身不遂，口眼歪斜，舌暗淡，苔白，脉缓无力为辨证要点。

本症由于正气亏虚而瘀血阻滞于人体脉络，导致筋脉肌肉失养，故见半身不遂、口眼歪斜。舌根失于濡养，则见语言蹇涩不利，口角流涎。面色萎黄是气虚之象。小便频数或者失禁，是气虚不能固摄膀胱之故。舌色淡紫，脉细涩虚幻，皆为气虚而瘀血内停的反应。本证与中风后肝肾亏损而肝阳上亢者的主要区别在于，肝肾亏损而肝阳上亢证，可见头晕耳鸣，面目红赤，口唇红紫，口苦心烦，舌色深红，脉弦滑数等。此外还可以参考血压数据，肝阳上亢者血压多升高，而气虚血瘀证一般表现为低血压。

【用方】

补阳还五汤

——《医林改错》

方剂说明

补气活血通络。

适用于脑血管意外后遗症、冠心病、小儿麻痹后遗症，以及其他原因引起的偏瘫、截瘫、或单侧上肢、或下肢痿软等属气虚血瘀者。

组成

黄芪120g，当归尾3g，赤芍5g，地龙3g，川芎3g，红花3g，桃仁3g

歌曰：补阳还五赤芍芍，归尾通经佐地龙。四两黄芪为主药，血中瘀滞用桃红。

配伍说明

本方症由中风之后，正气亏虚，气虚血滞，脉络瘀阻所致。正气亏虚，不能行血，以致脉络瘀阻，筋脉肌肉失去濡养，故见半身不遂、口眼喎斜，正如《灵枢·刺节真邪第七十五》所言：

“虚邪偏客于身半，其入深，内居荣卫，荣卫稍衰则真气去，邪气独留，发为偏枯。”本方证以气虚为本，血瘀为标，即王清任所谓“因虚致瘀”。治当以补气为主，活血通络为辅。本方重用生黄芪，补益元气，意在气旺则血行，瘀去络通，为君药。当归尾活血通络而不伤血，用为臣药。赤芍、川芎、桃仁、红花协同当归尾以活血祛瘀；地龙通经活络，力专善走，周行全身，以行药力，亦为佐药。全方的配伍特点是：重用补气药与少量活血药相伍，使气旺血行以治本，祛瘀通络以治标，标本兼顾；且补气而不壅滞，活血又不伤正。合而用之，则气旺、瘀消、络通，诸症向愈。

根据现代药理研究结果显示，补阳还五汤煎剂含有能够缓解心肌缺血、纠正异常心律、改善脑血流量以及肢体血流量的药理成分，并且可以对抗去甲肾上腺素的收缩血管作用，



降低血液胆固醇浓度。由此可见，药理学研究是支持补阳还五汤对心脑血管疾病的治疗作用的。

方剂制备

上药加水约1200毫升，煎至约剩余300毫升后滤去药渣，药汁直接温服，此为第一次药。剩余药渣再加水约800毫升，煎取300毫升左右，滤去药渣温服，此为第二次药。1日2次即可。

使用注意

1. 本方证以正气虚为主，故用生黄芪量宜重（从30~60g开始，效果不显再逐渐增加），祛瘀药宜轻。同时黄芪有助火之弊，对肝阳上亢者不可轻易使用，治疗高血压患者时尤其需要谨慎。

2. 用本方需久服才能有效，愈后还应继续服用，以巩固疗效，防止复发。王氏谓：“服此方愈后，药不可断，或隔三五日吃一付，或七八日吃一付。”但若中风后半身不遂属阴虚阳亢，痰阻血瘀，见舌红苔黄、脉洪大有力者，非本方所宜。

临症加减

1. 语言蹇涩者，可加石菖蒲、远志等。
2. 半侧肢体无力活动，口角歪斜者，可加制南星、白附子、白僵蚕等。
3. 肢体麻木者，可加乌蛇、桑枝、乳香、桂枝、鸡血藤等。

4. 上肢偏瘫者，可加桂枝、桑枝等。
5. 下肢偏瘫者，可加川断、桑寄生、牛膝、狗脊等。
6. 小便失禁者，可加金樱子、桑螵蛸、益智仁、山茱萸等。
7. 瘫痪而手足发冷者，可加熟附子、桂枝等。
8. 倦怠乏力、气短懒言者，可加党参、白术等。
9. 兼有痰浊而胸脘痞闷、舌苔腻垢者，可加制半夏、白附子、天竺黄等。
10. 久病难以恢复者，可加地鳖虫、水蛭、虻虫、丹参等。

典型案例

陈某，男，78岁。患中风后遗症口喎舌强、双下肢活动不利1年余。曾用曲克芦丁（维脑路通）等药治疗未见效果。口角向左歪斜，流涎，舌强，语言蹇涩，双下肢震颤而乏力，举动艰难，步履蹒跚，神智虽清但反应迟钝，思维不灵，近事喜忘，心悸。舌苔薄黄而腻，舌体胖大，向左斜，脉弦硬。血压150/90mmHg。头部CT显示：脑萎缩，腔隙性脑梗死。辨证为痰瘀阻络，机窍不灵。治以益气活血，化痰通络。处方：当归10g，川芎10g，生黄芪30g，桃仁10g，赤芍12g，红花8g，炙甘草6g，炙地龙15g，竹茹10g，枳实10g，瓜蒌皮15g，天竺黄6g，制南星6g，制半夏8g，水煎后兑入竹沥水20毫升（每日3次）。



病名

各种眩晕症、高血压病、
神经衰弱症

中医病名

风痰上扰证

症状

本方为治风痰眩晕、头痛的常用方。这类眩晕头痛多由高血压、神经衰弱、内耳前庭水肿等原因引起，临床应用以旋转性眩晕、头痛，如晕船而泛恶，伴舌苔白腻，脉弦滑为辨证要点。常用于耳源性眩晕、高血压病、神经性眩晕、癫痫、面神经瘫痪等属风痰上扰者。

本症由痰湿与肝风相夹杂引起，所以其症状上一般都与痰湿及肝风有关。痰湿内阻可以上蒙清阳之气，加上肝风上逆，相互纠结上犯于头部，可以导致眩晕或者头痛。这种眩晕一般表现为旋转感，即感觉周围物体甚至自身在旋转，不能睁眼。与这些症状同时发生的，还有风痰上逆犯胃，会伴有恶心呕吐的症状，有时会相当剧烈。痰邪阻于内，气机亦不能通畅运行，故可见胸膈痞满，或者胃脘部位胀满不舒。而咳吐痰涎和舌苔白腻都是痰湿症的重要诊断佐证。如果肝风上逆及痰湿比较严重，亦可导致风痰蒙蔽心窍，此时会发生神

志症状比如突然昏厥，不省人事，半身不遂等，既为中风发作，因风痰上扰所导致的癫痫的病理原因亦是如此。本证如出现风痰走串经络的情况，则可能出现肢体麻木，即可以单独出现，也可以与前面症状并见。

【用方】

半夏白术天麻汤

——《医学心悟》

方剂说明

燥湿化痰，平肝熄风。

适用于耳源性眩晕、高血压病、神经性眩晕、癫痫、面神经瘫痪等属风痰上扰者。

组成

半夏9g，天麻、茯苓、橘红各6g，白术15g，甘草3g。

歌曰：半夏白术天麻汤，苓草橘红大枣姜。眩晕头痛风痰证，热盛阴亏切莫尝。

配伍说明

本方证缘于脾湿生痰，湿痰壅遏，引动肝风，风痰上扰清空所致。风痰上扰，蒙蔽清阳，故眩晕、头痛；痰阻气滞，升降失司，故胸膈痞闷、恶心呕吐；内有痰浊，则舌苔白腻；脉



来弦滑，主风主痰。治当化痰熄风，健脾祛湿。方中半夏燥湿化痰，降逆止呕；天麻平肝熄风，而止头眩，两者合用，为治风痰眩晕头痛之要药。李东垣在《脾胃论》中说：“足太阴痰厥头痛，非半夏不能疗；眼黑头眩，风虚内作，非天麻不能除。”故以两味为君药。以白术、茯苓为臣，健脾祛湿，能治生痰之源。佐以橘红理气化痰，脾气顺则痰消。使以甘草和中调药；煎加姜、枣调和脾胃，生姜兼制半夏之毒。综观全方，风痰并治，标本兼顾，但以化痰熄风治标为主，健脾祛湿治本为辅。本方亦系二陈汤加味而成，在原燥湿化痰的基础上，加入健脾燥湿之白术、平肝熄风之天麻，而组成化痰熄风之剂。《医学心悟·头痛》中另有一半夏白术天麻汤，较本方多蔓荆子9g，白术减为3g，治痰厥头痛、胸膈多痰，动则眩晕之证。

根据现代药理研究结果显示，半夏白术天麻汤方中的天麻含有镇静、止痉、抗癫痫的药理成分，可使冠状动脉、脑及外周血管阻力下降，改善血液循环，营养神经，因而对于各种神经性、血管性以及贫血性眩晕都具有良好的临床疗效。白术的成分则可以起到健胃、利尿、镇静、强壮身体、保护肝脏等多方面作用。跟天麻配合使用，药理学上讲有协同互补的效果。

方剂制备

加生姜1片，大枣2枚，以水约800毫升煎煮至约剩余250毫升，再加水400毫升，继续煮至剩余约250毫升，滤去药渣，温服。

使用注意

临床上，眩晕头痛的发生原因是多种多样的，内伤杂病中就有肝阳上亢、肾虚、气虚、血虚、瘀血等多种分类。本方只适用于痰湿夹杂肝风所致之眩晕头痛，如遇肝风上逆较甚而导致昏厥、不省人事者，须另行配合镇惊、开窍、息风之品，单用本方不足以取效。另阴虚阳亢，气血不足等所致之眩晕，也不宜使用。

临症加减

1. 眩晕较甚者，加僵蚕、钩藤、胆星、石决明等。
2. 头痛剧烈者，可加全蝎、地龙、蜈蚣、蔓荆子等。
3. 脾胃虚弱运化力弱者，可加党参、黄芪。

典型案例

张某，女，38岁。平素好晕车船，平地时发性自觉眩晕欲倒经年，伴有耳鸣。前日发作，自觉视物旋转，不能睁眼，于床上平卧休息亦觉房屋旋转，烦

恶欲呕，呕吐物先为胃内容物食物等，后为清水痰涎。胸脘部位胀满不舒。口不渴。查体舌苔白腻，脉诊细滑。诊断为风痰上扰证。处方：半夏9g，天麻6g，茯苓6g，橘红6g，白术15g，甘草3g，党参6g，黄芪6g，水煎服。

病名

高血压病、高血压脑病、
脑血管意外

中医病名

肝阳化风证

症状

肝阳偏亢，肝风上扰证。主要表现为头痛，眩晕，失眠多梦，或口苦面红，舌红苔黄，脉弦或数。本方是治疗肝阳偏亢，肝风上扰的常用方。临床应用以头痛，眩晕，失眠，舌红苔黄，脉弦为辨证要点。

本症多在肝炎上亢的基础上进一步发展而形成。肝阳上亢的特征是眩晕、耳鸣、头胀痛或跳掣而痛，遇劳累加重，遇恼怒也加重，时时面部潮红，甚至整天面目红赤，性情急躁易怒，口苦，睡眠质量不佳，多梦，舌质红苔黄等。本症则在此基础上形成肝风上逆，扰动头部则有眩晕头痛，视物昏花

等表现。肝肾不足不能滋养筋脉的情况下，肝风横窜于脉络之中，则可能造成肢体麻木或振颤等表现。肝风上逆会导致气血逆行，运行紊乱，加上亢盛的肝阳煎熬津液成痰，可能发生肝风挟痰上蒙清窍导致昏厥，不知人事等情况，也属于风痰之类。与典型的风痰不同，虽然症状有相似之处，但是本症症状较严重，且有肝阳亢盛的表现以及亢盛的肝阳扰乱肢体筋脉、经络等导致的一系列症状，因而不难进行区别。由于风痰阻于舌根或半侧经络，导致言语蹇涩不利、半身肢体不能活动的情况也时有发生。

本症在诊断时要注意肝阳化风的临床表现是多种多样的，其中有的只是表现为手指或者舌尖略感麻木，或蠕动，有的则发生昏厥、痉挛、瘫痪等，病情轻重差距较大。但是不管表现症状轻重，本症都属于急重证，即使病情轻微，也不可等闲视之。但凡原来已有肝阳上亢表现的，又见手指或舌尖麻木，手指蠕动，或者短暂意识丧失等，均为动风之先兆，应及时给予适当的治疗。现在已经可以配合血压、血液粘度、血管弹性、血液动力学等各项现代化检查帮助诊断，及早做出准确的病情描述。



【用方】 天麻钩藤饮——

《中医内科杂病证治新义》

方剂说明

平肝熄风，清热活血，补益肝肾。

常用于高血压病、急性脑血管病、内耳性眩晕等属于肝阳上亢，肝风上扰者。

组成

天麻90g，钩藤12g，生决明18g，山
梔、黄芩各9g，川牛膝12g，杜仲、益母
草、桑寄生、夜交藤、朱茯神各9g。

歌曰：天麻钩藤饮决明，梔杜寄生
膝黄芩，夜藤茯神益母草，肝风内动诸
证平。

配伍说明

本方证由肝肾不足，肝阳偏亢，
生风化热所致。肝阳偏亢，风阳上扰，
故头痛、眩晕；肝阳有余，化热扰心，
故心神不安、失眠多梦等。证属本虚标
实，而以标实为主，治以平肝熄风为
主，佐以清热安神、补益肝肾之法。方
中天麻、钩藤平肝熄风，为君药；石
决明咸寒质重，功能平肝潜阳，并能
除热明目，与君药合用，加强平肝熄风
之力；川牛膝引血下行，并能活血利
水，共为臣药。杜仲、寄生补益肝肾以

治本；梔子、黄芩清肝降火，以折其亢
阳；益母草合川牛膝活血利水，有利于
平降肝阳；夜交藤、朱茯神宁心安神，
均为佐药。诸药合用，共成平肝熄风，
清热活血，补益肝肾之剂。根据现代药
理研究结果显示，天麻钩藤饮方水煎剂
中的成分对血压正常的动物及人体没有
降低血压的作用，但是对有高血压的动
物及人却可以起到一定的降低血压的效
果。说明本方对病理性高血压病的确具
有治疗效果，并且各个成分都具有各自
的独特药理功能，全方并非只是具有降
压功能的单一效果。

方剂制备

上述药材约用水1500毫升，煎至约
剩余300毫升药汁，即为第一遍药液，温
服。剩余滤出药渣再加水1000毫升，至
剩余约300毫升，为第二遍药汁，仍然温
服，1日2次。

使用注意

眩晕头痛、肢体麻木等症发生的原因
甚多，除肝阳化风或风痰上扰所致者，还
有因血虚、痰湿、瘀血等原因导致的，辨
证时须谨慎分辨明确诊断。对本症的治疗
应注意平时生活方面的调适，如多食清淡
食物，忌辛辣、烟酒等动火饮食，也不宜
过食甘美肥腻之品。同时注意情绪上的调
整，切忌恼怒生气，保持心情愉快，作息
有常，避免过分劳累伤身。

临症加减

1. 肝风亢盛者，加代赭石、羚羊角、龙骨、牡蛎等。
2. 肝肾虚弱者，加入生地、白芍、玄参、天冬、龟板、鳖甲等加强补益肝肾之力。
3. 内热较重而口渴多饮，并且面目红赤者，加生石膏、龙胆草泻热。

典型案例

董某，男，64岁。因头晕，左半身无力，语言不清，饮水时呛水已3天。患者神志清楚，语言謇涩，左上肢肌力III级；血压190/110mmHg，舌质红，舌苔薄黄，脉弦。CT报告：脑干有0.4cm腔隙梗死灶。诊断为多发性腔隙性脑梗死。辨证属中风之风中经络型，源于肝火上亢。治疗应清火平肝熄风。处方：天麻10g，钩藤15g，生石决明30g，山栀子10g，黄芩10g，川牛膝12g，地龙12g，桑寄生10g，益母草20g，鸡血藤15g，水煎服。

病名

心力衰竭、各类脑炎

中医病名

少阴虚寒证

症状

少阴病。四肢厥逆，即手冷过肘，足冷过膝。恶寒蜷卧，呕吐不渴，腹痛下利，神衰欲寐，舌苔白滑，脉微；或太阳病误汗亡阳。本方是回阳救逆的基础方。临床应用以四肢厥逆，神衰欲寐，面色苍白，脉微细为辨证要点。

本症是因少阴心肾阳气衰竭所引发的。中医学理论中认为，相对于后天之本的脾，肾作为先天之本有资助脾阳的作用，而脾则有补充肾阳的能力，也就是说脾与肾是一种协同作用的关系，共同温煦肢体，运化水谷精微。如果肾阳虚衰，势必造成脾阳随之不足，就会导致人体虚寒内盛，脏气不温而运化失职，水液停滞不行等后果。脾肾皆阳虚，则肢体得不到阳气温煦，故见四肢发凉，甚者可见周身不温，并表现为乏力恶寒，喜好蜷卧。同时本症为少阴虚寒证，除肾阳不足外，心阳也虚衰，表现为无力鼓动血液运行，这也会加重虚寒症状，故诊脉微细，甚至难以触及。



阳气不足则无力温化水湿及饮食，所以易腹泻且完谷不化并呕吐。一片虚寒之象而舌苔白滑。同时阳气不足而阴寒盛于内，可见脘腹拘急冷痛，面色晄白，吐息也寒凉。而心阳不足也可导致心神失养而表现出心烦不安等症状。

本证病情如进一步发展，可能因为阳气大虚，阴寒过盛，阳气不能内守被阴寒逼迫而虚阳外浮，表现出真寒假热的危急之象。具体表现为手足清冷、呕吐清稀、恶寒腹泻等虚寒之象。同时又有发热、面部红赤等假热表现。这是病情危急的征兆，绝不可掉以轻心。因为本证容易转为危重，治疗时不能拖延，故诊断应提高对心肾衰竭症状的警惕，做到尽早发现，比如精神萎靡不振、脉象细弱无力、面色晄白无华等等，必要时配合现代医学检查手段，监测血压心电等生命指征数据的变化，以免延误病情。

本症在表现上与太阴虚寒证有很多类似之处，因同属极虚的阴寒之症。不过症状上还是各有侧重，太阴阳气虚衰之证病在脾胃，因为直接损及先天之阳，全身虚寒表现较轻，不似本症心阳肾阳皆衰败，全身阳衰表现显著，比如萎靡嗜睡、恶寒肢凉，脉象微细欲绝等。

【用方】

四逆汤——《伤寒论》

方剂说明

回阳救逆。

适用于心肌梗死、心力衰竭、急性胃肠炎吐泻过多、或某些急证大汗而见休克属阳衰阴盛者。

组成

附子15g，干姜9g，炙甘草6g。

歌曰：四逆汤中附草姜，四肢厥冷急煎尝。腹痛吐泻脉微细，急投此方可回阳。

配伍说明

本方证乃因心肾阳衰，阴寒内盛所致。阳气不能温煦周身四末，故四肢厥逆、恶寒蜷卧；不能鼓动血行，故脉微细。《素问·生气通天论》曰：“阳气者，精则养神，柔则养筋。”今心阳衰微，神失所养，则神衰欲寐；肾阳衰微，不能暖脾，升降失调，则腹痛吐利。此阳衰寒盛之证，非纯阳大辛大热之品，不足以破阴寒，回阳气，救厥逆。故方中以大辛大热之生附子为君，入心、脾、肾经，温壮元阳，破散阴寒，回阳救逆。生用则能迅达内外以温阳逐寒。臣以辛热之干姜，入心、脾、



肺经，温中散寒，助阳通脉。附子与干姜同用，一温先天以生后天，一温后天以养先天，相须为用，相得益彰，温里回阳之力大增，是回阳救逆的常用组合。炙甘草之用有三：一则益气补中，使全方温补结合，以治虚寒之本；二则甘缓姜、附峻烈之性，使其破阴回阳而无暴散之虞；三则调和药性，并使药力作用持久，是为佐药而兼使药之用。综观本方，药简力专，大辛大热，使阳复厥回，故名“四逆汤”。

根据现代药理研究结果显示，四逆汤的成分对心血管功能有改善作用，能增强血液循环，升高休克机体的血压。本方附子和甘草都具有类似肾上腺皮质激素的功能，改善毛细血管的通透性，提高血液循环效率，减少炎性渗出，同时附子和干姜搭配应用，可暂时增强心肌收缩能力。研究表明，附子干姜甘草三味药物同时煎煮，经过一系列化学和物理变化，所得药剂强心作用明显增强而对身体的毒副作用则显著降低。同时，四逆汤还具有使体温趋向正常的双向调节作用，对高热者可解热降温，对体温偏低四肢不温者又能使体温上升。此外，四逆汤还能调整胃肠道消化功能。虽然只有三味药物组成，药力作用却非常复杂。

方剂制备

以水约800毫升先煎煮附子，然后

下入其他二味药材同煎，至水量约剩余1/3，煮好后滤出药渣，分两次温服。

使用注意

1. 四逆汤经常用于治疗危重病症，比如急性心力衰竭，休克或休克前期，心肌梗塞，也可用于急慢性肠胃炎因吐泻过甚或急性病汗出过多而导致的虚脱。一般小儿腹泻或慢性肠痉挛等出现吐泻不止、四肢厥冷的症状也可应用。

2. 本方所治疗的厥证，为心肾阳气大虚所致，即所谓寒厥。治疗时应与因热邪内陷，阳气不伤而未能达于四肢所造成的热厥进行鉴别。热厥者，必有胸腹灼热，便秘口渴、小便黄赤、舌红脉数等一系列里热表现，属于真热假寒之证，切忌使用本方。与表寒证也要注意分别。

3. 附子有毒，使用时最好选择熟附子而不要用生品，用量也要严格控制，并先煎久煎以减弱其毒性。

临症加减

1. 少阴病。下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，或利止。脉不出等。重用附子，干姜以回阳通脉。

2. 阴寒内盛，四肢厥逆，恶寒蜷卧，脉微而复自下利，利虽止而余证仍在者，加入参6g以取回阳益气，救逆固脱之功。

**病名**

风湿性心脏病、心力衰竭

中医病名

气阴两虚证

症状

1. 温热、暑热，耗气伤阴证。主要表现为汗多神疲，体倦乏力，气短懒言，咽干口渴，舌干红少苔，脉虚数。
2. 久咳肺虚，气阴两伤证。主要表现为干咳少痰，短气自汗，口干舌燥，脉虚细。本方是治疗气阴两虚证的常用方。临床应用以体倦，气短，咽干，舌红，脉虚为辨证要点。

心肺之气不足，则可导致倦怠乏力，气短，甚至可导致气促而喘。汗出过多不止会消耗阴液，也耗散阳气，心肺阴液不足则口干而渴，或者渴欲饮水，舌苔干燥少津。阳气消耗则会进一步加重气虚症状。呛咳少痰是由于肺阴不足、肺气上逆。脉虚无力则是正气虚衰的表现。本症如发生于外感热病中，如气阴虚及而欲脱，还可见汗出淋漓，高热骤降等症状。如结合血压检查，可见血压下降。本症如进一步发展，则可因出汗过多气阴不断耗伤而导致虚脱。

3. 少阴病，下利脉微者。去炙甘草，加葱白四茎通阳破阴。

4. 阳气暴脱，手足逆冷，头晕气短，汗出脉微者，去干姜、炙甘草，加人参12g益气回阳。

5. 同时有脾胃虚寒而水湿不运饮停于内导致的水肿、水泻者，加党参、茯苓、泽泻、车前子等。

6. 因寒湿而关节疼痛者，加桂枝、白术、苍术等。

7. 阴阳之气将脱的极重症，加人参、熟地、当归尾六味回阳饮，阴阳双补。

典型案例

苏某，女，38岁。月经期间不慎淋凉水，当日夜间忽发寒战，继而神志昏沉，人事不省，脉诊微细欲绝，手足厥逆冰冷。以针灸法刺人中及十宣穴出血，血色紫暗难以挤出。针时能呼痛，并一度苏醒，但不久仍沉沉入睡。此因阴寒太盛，阳气大衰，气血凝滞之故。急当温经散寒换扶阳气，拟大剂四逆汤。处方：炮附子25g，北干姜12g，炙甘草12g。水煎，嘱分4次温服，每半小时灌服1次。

【用方】 生脉散——《医学启源》

方剂说明

益气生津，敛阴止汗。

适用于肺结核、慢性支气管炎、神经衰弱所致咳嗽和心烦失眠，以及心脏病心律不齐属气阴两虚者。生脉散经剂型改革后制成的生脉注射液，经药理研究证实，具有毒性小、安全度大的特点，临床常用于治疗急性心肌梗死、心源性休克、中毒性休克、失血性休克及冠心病、内分泌失调等病属气阴两虚者。

组成

人参9g，麦冬9g，五味子6g。

歌曰：生脉散治气阴虚，人参麦冬五味齐。补气生津又敛阴，气短自汗诸证去。

配伍说明

本方所治为温热、暑热之邪，耗气伤阴，或久咳伤肺，气阴两虚之证。温暑之邪袭人，热蒸汗泄，最易耗气伤津，导致气阴两伤之证。肺主皮毛，暑伤肺气，卫外失固，津液外泄，故汗多；肺主气，肺气受损，故气短懒言、神疲乏力；阴伤而津液不足以上承，则

咽干口渴。舌干红少苔，脉虚数或虚细，乃气阴两伤之象。咳嗽日久伤肺，气阴不足者，亦可见上述征象，治宜益气养阴生津。方中人参甘温，益元气，补肺气，生津液，是为君药。麦门冬甘寒养阴清热，润肺生津，用以为臣。人参、麦冬合用，则益气养阴之功益彰。五味子酸温，敛肺止汗，生津止渴，为佐药。三药合用，一补一润一敛，益气养阴，生津止渴，敛阴止汗，使气复津生，汗止阴存，气充脉复，故名“生脉”。《医方集解》说：“人有将死脉绝者，服此能复生之，其功甚大。”至于久咳肺伤，气阴两虚证，取其益气养阴，敛肺止咳，令气阴两复，肺润津生，诸症可平。

根据现代药理研究结果显示，生脉散用于各种冠心病或者休克，有显著的增强心肌收缩力、改善血液循环、特别是改善冠状动脉血液循环的作用，并能促进全身内分泌系统的功能，调整全身功能状态，有明显持久的升高血压，强心作用。生脉散对人体免疫系统功能也有调节作用。由此可见生脉散对人体极度虚弱的情况有较好的挽回作用。

方剂制备

上药加水约800毫升，煎取300毫升药液，一天内分次服完。



使用注意

若属外邪未解，或暑病热盛，气阴未伤者，均不宜用。久咳肺虚，亦应在阴伤气耗，纯虚无邪时，方可使用。对邪热炽盛于里而导致的大汗、大渴之症不可妄投。

临症加减

1. 急性热病中出现大汗、神情萎靡、四肢发冷、脉微细的阴阳两脱证者，可加附子、肉桂、干姜等。
2. 心肺之气大虚而自汗，心悸者，可加黄芪、炙甘草等。
3. 形瘦久咳、不思进食、夜寐不安者，可加淮山药、茯苓、莲子、白术等。
4. 心阴不足而失眠、心烦、汗出者，可加茯神、丹参、龙骨、牡蛎等。
5. 心动过速者，可加茯神、龙齿、磁石、酸枣仁、生地、炙甘草等。

典型案例

马某，女，63岁。因慢性支气管炎合并气管肺炎继发心力衰竭而住院。给与抗感染、利尿、强心药物治疗。傍晚突发面色苍白、倦怠无力、汗出淋漓、胸闷气急、伴恶心呕吐，口干渴，舌干红，脉细缓。血压75/20毫米汞柱。诊断为气阴两虚证。处方：人参9g，麦冬9g，五味子6g，肉桂6g，黄芪6g，急煎服。

病名

冠心病、心律不齐、风湿性心脏病

中医病名

心悸

症状

1. 阴血不足，阳气虚弱证。主要表现为脉结代，心动悸，虚羸少气，舌光少苔，或质干而瘦小者。2. 虚劳肺痿。主要表现为咳嗽，痰唾多，形瘦短气，虚烦不眠，自汗盗汗，咽干舌燥，大便干结，脉虚数。本方为阴阳气血并补之剂。临床应用以脉结代，心动悸，虚羸少气，舌光色淡少苔为辨证要点。

【用方】

炙甘草汤

——《伤寒论》

方剂说明

滋阴养血，益气温阳，复脉止悸。

适用于功能性心律不齐、期外收缩、冠心病、风湿性心脏病、病毒性心肌炎、甲状腺功能亢进等而有心动悸、气短、脉结代等属阴血不足，阳气虚弱者。

组 成

炙甘草12g，生姜9g，桂枝9g，人参6g，生地50g，阿胶6g，麦冬10g，麻仁9g，大枣10枚，以清酒、水酒各半煎服。

歌曰：炙甘草汤参姜归，麦冬生地大麻仁。大枣阿胶加酒服，虚劳肺痿效如神。

配伍说明

本方是《伤寒论》治疗心动悸、脉结代的名方。本症是由伤寒汗、吐、下或失血后，或杂病阴血不足，阳气不振所致。阴血不足，血脉无以充盈，加之阳气不振，无力鼓动血脉，脉气不相接续，故脉结代；阴血不足，心体失养，或心阳虚弱，不能温养心脉，故心动悸。治宜滋心阴，养心血，益心气，温心阳，以复脉定悸。方中重用生地黄滋阴养血为君，《名医别录》谓地黄“补五脏内伤不足，通血脉，益气力”。配伍炙甘草、人参、大枣益心气，补脾气，以资气血生化之源；阿胶、麦冬、麻仁滋心阴，养心血，充血脉，共为臣药。佐以桂枝、生姜辛行温通，温心阳，通血脉，诸厚味滋腻之品得姜、桂则滋而不腻。用法中加清酒煎服，以清酒辛热，可温通血脉，以行药力，是为使药。诸药合用，滋而不腻，温而不燥，使气血充足，阴阳调和，则心动

悸、脉结代，皆得其平；虚劳肺痿属气阴两伤者，使用本方，是用其益气滋阴而补肺，但对阴伤肺燥较甚者，方中姜、桂、酒减少用量或不用，因为温药毕竟有耗伤阴液之弊，故应慎用。本方与生脉散均有补肺气，养肺阴之功，可治疗肺之气阴两虚，久咳不已。但本方益气养阴作用较强，敛肺止咳之力不足，重在治本，且偏于温补，阴虚肺燥较著或兼内热者不宜；而生脉散益气养阴之力虽不及本方，因配伍了收敛的五味子，标本兼顾，故止咳之功甚于炙甘草汤，且偏于清补，临证之时可斟酌选用。

方剂制备

上以清酒七升，水八升，先煮八味，取三升，去滓，内胶烊消尽，温服一升，日三服（现代用法：水煎服，阿胶烊化，冲服）。

临症加减

1. 气虚严重者，加黄芪。
2. 血虚严重者，加当归、熟地。
3. 心慌者，加酸枣仁、茯神、五味子、柏子仁。
4. 兼有瘀血者，加丹参、桃仁、红花等。
5. 兼有阳虚汗出怕冷、舌淡者，可加熟附子、龙骨、牡蛎、黄芪等。



典型案例



陈某，女，65岁。发热不退二月以上。经西医检查始疑伤寒，后谓风湿，复拟结核，终无定论，病家惶惑，莫衷一是。中西药物杂投，皆无功效。体温起伏在37.9~38.8之间，朝轻暮重，始终难以退尽，自汗、盗汗，洒淅恶风，四肢酸楚冷痛，手足指趾发麻，头晕眼花，两耳蝉鸣，心烦嘈杂，时觉泛恶，口渴饮冷，所饮不多，烦躁不寐，大便干结，二日一行，小便短赤，咳嗽气促，时有浊唾，舌苔薄白而略干，质偏红，脉浮大无力带数。诊为阴阳俱虚，营卫失调，处方：炙甘草15g，生地15g，阿胶10g，麻仁15g，麦冬10g，西党参10g，桂枝8g，白芍10g，姜半夏10g，生姜3片，大枣6枚，水煎服。

《高士王常杜中醫神書》

中醫秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

中者、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

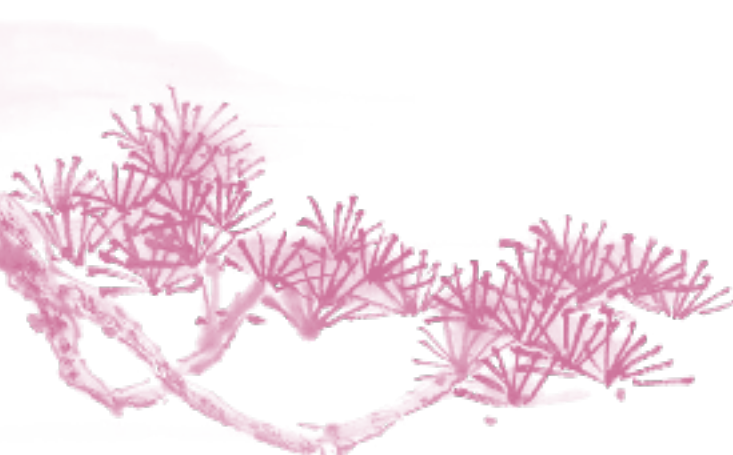
秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方

秘方、秘方、秘方



第五章

泌尿生殖 系统疾病

本書以中醫杜中醫視毒、
以及歷中醫視方、脈方、
方等方圓的視方中詩
書中書卷常見視四
方、其視而百方。史
于古今視多名方、其
視方、不勝易辨、易
多用、皆錄諸書、而上
視方、對某些病視視
視是想不到視懷詩、
視方、是適合廣大中醫
視視用。

這些視方大對視視四火
一視視視方、二視食視
三視中草藥視方、四
視方用視方、五視日常
視方、并視視視方視

病名

急慢性肾炎

中医病名

蓄水证

症状

1. 蓄水证。小便不利，头痛微热，烦渴欲饮，甚则水入即吐，舌苔白，脉浮。2. 水湿内停。主要表现为水肿，泄泻，小便不利，以及霍乱等。3. 痰饮。主要表现为脐下动悸，吐涎沫而头眩，或短气而咳者。

由于病邪之气影响了膀胱的气化功能，整个身体的水液运行输布排泄失常，才引发了本证的一系列症状。例如水液阻滞于内，则津液不能输布上达于口腔，表现为口渴，但是水液内阻，其实身体并非出于缺水状态，故饮水而不欲咽，往往饮水后立即吐出。同时内停的水液积蓄于膀胱，则小便不利小腹胀满。水液泛滥外泛于肌肤可见水肿，气机阻滞清阳受抑制，见头痛眩晕。如果同时肌表外邪未解，则可以伴随表证，如发热、恶风寒等等。表证犯表之邪内传，或者因蓄水导致的内热炽盛，均可见较严重的发热现象。因而本证即可以表现为里证，也可以表现为表里同病。

【用方】

五苓散——《伤寒论》

方剂说明

利水渗湿，温阳化气。

适用于肾炎、肝硬化所引起的水肿，以及急性肠炎、尿潴留、脑积水等，属水湿内盛者。

组成

猪苓9g，泽泻15g，白术9g，茯苓9g，桂枝6g。

歌曰：五苓散治太阳府，泽泻白术与二苓。温阳化气添桂枝，利便解表治水停。

配伍说明

本方主治病症虽多，但其病机均为水湿内盛，膀胱气化不利所致。在《伤寒论》中原治蓄水证，乃由太阳表邪不解，循经传腑，导致膀胱气化不利，而成太阳经腑同病。太阳表邪未解，故头痛微热；膀胱气化失司，故小便不利；水蓄不化，郁遏阳气，气不化津，津液不得上承于口，故渴欲饮水；其人本有水蓄下焦，饮入之水不得输布而上逆，致水入即吐，故此又称“水逆证”；水湿内盛，泛滥肌肤，则为水肿；水湿之邪，下注大肠，则为泄泻；水湿



稽留肠胃，升降失常，清浊相干，则为霍乱吐泻；水饮停于下焦，水气内动，则脐下动悸；水饮上犯，阻遏清阳，则吐涎沫而头眩；水饮凌肺，肺气不利，则短气而咳。治宜利水渗湿为主，兼以温阳化气之法。方中重用泽泻为君，以其甘淡，直达肾与膀胱，利水渗湿。臣以茯苓、猪苓之淡渗，增强其利水渗湿之力。佐以白术、茯苓健脾以运化水湿。《素问·灵兰秘典论》谓：“膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣”，膀胱的气化有赖于阳气的蒸腾，故方中又佐以桂枝温阳化气以助利水，解表散邪以祛表邪，《伤寒论》示人服后当饮暖水，以助发汗，使表邪从汗而解。诸药相伍，甘淡渗利为主，佐以温阳化气，使水湿之邪从小便而去。

根据现代药理研究结果显示，五苓散所含有的成分对人体内水分、电解质、脂肪、糖类、蛋白质等物质的代谢均具有一定的调节作用，特别是对电解质和水分代谢的调节产生的利尿效果十分明显，对急性乙醇中毒等有预防和治疗的功能作用。五味药材单独也都含有利尿的成分，茯苓、猪苓和白术还能够增强人体的免疫功能、保护肝脏、松弛病态紧张的平滑肌，还能降低血液胆固醇含量。桂枝和猪苓共同作用，加强了抗菌的效果，桂枝自身也能扩张血管，改善脏器血液循环、促进发汗散热，缓解炎症反应。证明了本方除

了利水排尿之外，也是具有多种复杂的药理作用的。

方剂制备

现代用法：做散剂服用时，每次服6~10g，做汤剂服用时，水煎服。服药期间多饮热水，取微汗，用量按原方比例酌定。

使用注意

1. 头痛微热，代表表邪未解，临床上应注意配合使用药材解表散邪。
2. 五苓散为利水祛湿峻剂，用之不当耗伤人体阴液，因而一般不能久服，尤其平素容易阴虚火盛者更需慎重。
3. 本方所针对的水湿证以未夹杂热邪者为宜，如水湿已与热邪相夹杂，则应施以清利湿热的治法，桂枝等温热之品不宜再投。
4. 入汤剂不宜久煎。

临症加减

1. 水肿严重者，加车前子、冬瓜皮、大腹皮、生姜皮等。
2. 蓄水证兼阴虚有热者，去桂枝、白术，加滑石、阿胶。
3. 眩晕、呕吐严重者，加郁金、钩藤、石决明等。
4. 小便滞涩疼痛，兼有腰痛，口渴心烦、舌红脉数一片热相者，属湿热内蕴脾肾两虚，可在本方基础上加生地、



熟地、知母、黄柏等。

5. 小便不利兼见身体虚弱气短者，加用人参益气。

实例练习

程某，女，6岁。颜面及下肢浮肿1年以上，经医治时消时肿，近日浮肿加剧，伴随恶寒午后潮热，口渴漱水不欲饮，小便黄赤短少，小腹胀满不舒，查体苔白稍腻，脉象浮数。诊断为虚热蓄水证。处方：猪苓6g，泽泻12g，茯苓6g，滑石6g，车前子3g。水煎服，1日3次。

病名

慢性肾炎、肾病综合征

中医病名

阳虚水泛证

症状

阳虚水泛证主要有两类症状：

1. 脾肾阳虚，水气内停证。主要表现为小便不利，四肢沉重疼痛，腹胀下利，或肢体浮肿，苔白不渴，脉沉。
2. 太阳病发汗太过，阳虚水泛。主要表现为汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲扑地。

肾中阳气虚衰，寒水内停，则小

便不利；水湿泛滥于四肢，则沉重疼痛，或肢体浮肿；水湿流于肠间，则腹痛下利；上逆肺胃，则或咳或呕；水气凌心，则心悸；水湿中阻，清阳不升，则头眩。若由太阳病发汗太过，耗阴伤阳，阳失温煦，加之水渍筋肉，则身体筋肉瞤动、站立不稳。

人体水液的吸收分布与排泄与体内很多脏腑有关，其中脾之健运与肾之开合起着比较关键的作用，尤其是与脾胃阳气的功能状态密切相关。脾阳与肾阳两者有着互养互补的关系，脾阳久虚则肾阳衰，肾阳久不足则脾阳虚。了解了这个理论，就可以解释阳虚水泛证的形成以及各症状产生的机理。脾肾两虚，水液不能正常外泄，表现为小便不利，肢体浮肿。水滞于内，则可见口不渴，苔白滑，脉沉细。水湿无处可泄外溢于肌表，则见四肢沉重疼痛，甚至水肿。水气上逆则眩晕呕吐，犯于心则心悸不舒。脾虚的同时水湿不能得到正常运化，则腹痛腹泻。脾肾阳气的虚衰，本质也就是体内虚寒，兼有水湿内泛，周身畏寒，四肢不温正是虚寒症的典型表现。阳气不能温煦肢体经脉，所以有肌肉跳动或无故颤抖，甚至站立不稳等表现。



【用方】 真武汤——《伤寒论》

方剂说明

温阳利水。

本方在临床上可治疗多种疾病，具有广泛的适应范围。各种水肿，无论是心源性、肾源性、肝源性、营养性、内分泌性、妊娠性等，只要表现为脾肾阳虚症状的，均可取效。并且作用不仅限于利水，还有强心、壮肾、保肝、补养、调理内分泌等多方面的功效。常用于慢性肾小球肾炎、心源性水肿、甲状腺功能低下、慢性支气管炎、慢性肠炎、肠结核等属脾肾阳虚，水湿内停者。

组成

茯苓9g，芍药9g，白术6g，生姜9g，附子9g。

歌曰：真武汤壮肾中阳，茯苓术芍附生姜。少阴腹痛有水气，悸眩喘惕保安康。

配伍说明

本方为治疗脾肾阳虚，水湿泛滥的基础方。盖水之制在脾，水之主在肾，脾阳虚则湿难运化，肾阳虚则水不化气而致水湿内停。肾中阳气虚衰，寒水内停，则小便不利；水湿泛滥于四肢，

则沉重疼痛，或肢体浮肿；水湿流于肠间，则腹痛下利；上逆肺胃，则或咳或呕；水气凌心，则心悸；水湿中阻，清阳不升，则头眩。若由太阳病发汗太过，耗阴伤阳，阳失温煦，加之水渍筋肉，则身体筋肉瞤动、站立不稳。其证因于阳虚水泛，故治疗当以温阳利水为基本治法。本方以附子为君药，本品辛甘性热，用之温肾助阳，以化气行水，兼暖脾土，以温运水湿。臣以茯苓利水渗湿，使水邪从小便去；白术健脾燥湿。佐以生姜之温散，既助附子温阳散寒，又合苓、术宣散水湿。白芍亦为佐药，其义有四：一者利小便以行水气，《本经》言其能“利小便”，《名医别录》亦谓之“去水气，利膀胱”；二者柔肝缓急以止腹痛；三者敛阴舒筋以解筋肉瞤动；四者可防止附子燥热伤阴，以利于久服缓治。如此组方，温脾肾以助阳气，利小便以祛水邪。

根据现代药理研究结果显示，真武汤中的主要成分茯苓、白术、附子都具有一定的利尿作用，其中附子还有强心，升高血压、镇痛等功能。芍药除了镇静镇痛外，还具有缓和痉挛的平滑肌等功效，也能利尿抗菌，同时止汗。附子与芍药的配合使用，加强了镇静止痛作用，因而经常使用于虚寒性的腹痛和因风寒湿邪导致的四肢疼痛的治疗中。

方剂制备

上五味药，取水约1600毫升，煎煮至剩余约600毫升后离火，滤去药渣，分3次温服，每日3~4次。

使用注意

1. 阳虚水泛证虽然多表现为慢性疾病，但也有一些属于危重病症，因而不要掉以轻心，需要慎重处理。
2. 本方虽然可以应用于发热证的治疗，但应使用于阳气虚衰或阳气外浮所导致的病症中，不适用于表热或里热壮盛等实热证。

临症加减

1. 如果患者水肿较重，小便不利，可加车前子、泽泻、冬瓜皮等。
2. 如果患者咳嗽，并咳吐清稀痰涎，可加五味子、细辛、干姜等。
3. 脾阳虚衰较重腹泻严重者，去芍药，加干姜。
4. 肾阳虚衰严重者，加肉桂、黄芪、熟地。
5. 风寒内侵，骨节疼痛严重者，去生姜，附子、白术加倍，另加人参温阳祛寒湿。

典型案例

严某，男，64岁，患慢性支气管炎多年。近年天气转冷便咳嗽剧烈，身体

面部四肢均浮肿，以下肢为重。现症状加重来诊，自述畏寒、四肢冰冷，查体口唇紫暗，舌苔薄腻，舌质暗红，脉沉细而滑。辨为肾阳虚衰真武汤证，处方：方茯苓9g，芍药9g，白术6g，生姜9g，附子9g，黄芪6g，熟地6g，1日3次水煎服。

病名

急性肾炎

中医病名

少阳水饮证

症状

少阳水饮证。主要表现为寒热往来，胸脘满闷如有物支撑，小便不利。心烦口渴，不呕，全身仅头部有汗。舌苔薄白，脉沉弦。

本证其实属于小柴胡汤证的一种变证，因而同样具有邪在少阳的主要症状，比如寒热往来，胸胁满闷不舒，心烦不安等。但同时也有水饮内停，阻滞于少阳经络，水饮为有形之邪，郁阻不通所造成的影响比单纯的气机郁滞更为严重。故胸胁胀满的症状比小柴胡汤证重，甚至自觉如有物支撑。水饮内停后，津液运行失去常态，所以出现小便



不利的症状。邪热停于少阳，与水饮相结，郁于胸中，上蒸头面，则见头部出汗而周身无汗。本症中出现的口渴症状，一方面是热邪耗伤身体阴液所致，一方面是由于内停的水饮阻碍了人体正常水液的输布上升。舌苔薄白和弦脉都是少阳有邪的证明，而脉沉而不现则是水饮内停的体现。

【用方】 柴胡桂枝干姜汤 ——《伤寒论》

方剂说明

和解少阳，温水化饮。

适用于治疗疟疾、急性肾盂肾炎、肺结核、冠心病、胸膜炎、肝炎、胆囊炎、癫痫、神经衰弱症、冠心病、乳房小叶增生等多种疾病出现少阳水饮证表现者。

组成

柴胡15g，桂枝9g，干姜6g，瓜蒌根（天花粉）12g，黄芩9g，牡蛎6g，炙甘草6g。

歌曰：柴胡桂枝干姜汤，瓜蒌芩牡草同方。

配伍说明

柴胡桂枝干姜汤也是一个由小柴胡汤发展变化出来的成方。方中以柴胡

与黄芩配伍用以和解少阳之邪。为温化水饮而使用了桂枝、干姜、甘草几味温热通阳之品。瓜蒌根和牡蛎则可以散结逐瘀，这里用来祛除内停水饮。而瓜蒌根的清热之性与黄芩合用，可以利气生津，清除郁结的里热。本症没有呕吐症状，故原小柴胡汤方中的半夏弃之不用，而人参、大枣等过于壅补之品，不利于清除水饮，也去掉。调整之后的本方对于和解清热生津而化水饮功效卓著，能使少阳之邪从汗而解，水饮由内而化。

据现代药理研究结果显示，本方中的干姜、桂枝等能使血管兴奋，并作用于交感神经，对改善血液循环有较好效果。同时桂枝还能清热利尿，也符合本方清热利水的主旨。其他药材与小柴胡汤配伍的原理大同小异。

方剂制备

全方药材用水约2400毫升，煮至约剩一半量时，撇去药渣，继续煮至剩余最初水量1/4左右即可。平均分为3份，每次取1份，一日服用3次。最初服用后有心下微烦症状则代表药效已见，继续服用可汗出而愈。

使用注意

1. 本方临床应用范围与小柴胡汤类似，但更适合于有少阳郁热的同时水饮内停的症状。有水饮内停表现的患者，

排除其他病理病变之外一般皆可应用本方治疗。临床上在肾炎、肝炎、胆囊炎、肺结核、肾盂肾炎、冠心病等各疾病出现少阳水饮证的皆广泛使用。

2. 如无水饮郁热，则方中不可用桂枝、干姜。

3. 本方使用后因药力帮助正气驱逐外邪，如表里阳气通畅，则可汗出而愈，所以服药后见汗出而愈者，并非与解表剂发汗相同机理。

临症加减

1. 患者津液不足，口渴干咳者，加天冬、玉竹。

2. 虚热盗汗，素体虚弱者，加黄芪、鳖甲、碧桃干等。

3. 眩晕且水饮症状严重者，加泽泻、茯苓、白术。

4. 心悸不安，失眠易惊，加酸枣仁、远志、夜交藤等。

典型案例

黄某，男，43岁。自觉右侧胁肋部疼痛5天，吸气时疼痛加剧。畏寒潮热，体虚盗汗，头晕头痛，食欲降低。偶尔咳嗽，小便短赤。诊脉沉弦，舌苔白腻。X线检查胸膜腔有炎症表现。诊断为少阳水饮证，处方：柴胡15g，桂枝9g，干姜6g，瓜蒌根（天花粉）12g，黄芩9g，牡蛎6g，炙甘草6g，黄芪9g，水煎服。

病名

月经不调、不孕症

中医病名

寒凝血瘀证

症状

冲任虚寒，瘀血阻滞证。主要表现为漏下不止，月经不调，或前或后，或一月再行，或停经不至而见入暮发热，手心烦热，唇口干燥。亦治妇人久不受孕。本方为妇科调经的常用方，主要用于冲任虚寒而有瘀滞的月经不调、痛经、崩漏、不孕等。临床应用以月经不调，小腹冷痛，经血夹有瘀块，时有烦热，舌质暗红，脉细涩为辨证要点。

本症有寒邪客于小腹，寒邪性凝滞，能阻碍气机和血液的运行，所以小腹觉寒冷而疼痛，或伴有拘急胀满。寒邪与气血凝滞于胞宫，必然引起月经不调或闭经。月经来潮时经血呈紫黑色且有血块，正是寒邪与瘀血相结合的反映。胞宫中寒邪与瘀血互阻，则导致不能受孕。由于瘀阻久留，影响阴血化生，日久则阴血亏损，而出现手足心烦热，或傍晚发热等阴虚生热症状。虚热症状并不是本证的必见症状，如出现发热，则多数并非单纯的寒凝血瘀证，而



是夹杂寒热瘀虚等情况的复杂症型。

【用 方】

温经汤——《金匱要略》

方剂说明

温经散寒，祛瘀养血。

适用于功能性子宫出血、慢性盆腔炎、痛经、不孕症等属冲任虚寒，瘀血阻滞者。

组 成

吴茱萸9g，当归6g，芍药6g，川芎6g，人参6g，桂枝6g，阿胶6g，牡丹皮6g，生姜6g，甘草6g，半夏6g，麦冬9g。

歌曰：温经汤用吴萸芎，归芍丹桂姜夏冬。参草益脾胶养血，调经重在暖胞宫。

配伍说明

本方证因冲任虚寒，瘀血阻滞所致。冲为血海，任主胞胎，二脉皆起于胞宫，循行于少腹，与经、产关系密切。冲任虚寒，血凝气滞，故少腹里急、腹满、月经不调、甚或久不受孕；若瘀血阻滞，血不循经，加之冲任不固，则月经先期、或一月再行，甚或崩中漏下；若寒凝血瘀，经脉不畅，则致痛经；瘀血不去，新血不生，不能濡润，故唇口干燥；至于傍晚发热、

手心烦热为阴血耗损，虚热内生之象。

本方证虽属瘀、寒、虚、热错杂，然以冲任虚寒，瘀血阻滞为主，治当温经散寒，祛瘀养血，兼清虚热之法。方中吴茱萸、桂枝温经散寒，通利血脉，其中吴茱萸功擅散寒止痛，桂枝长于温通血脉，共为君药。当归、川芎活血祛瘀，养血调经；丹皮既助诸药活血散瘀，又能清血分虚热，共为臣药。阿胶甘平，养血止血，滋阴润燥；白芍酸苦微寒，养血敛阴，柔肝止痛；麦冬甘苦微寒，养阴清热。三药合用，养血调肝，滋阴润燥，且清虚热，并制吴茱萸、桂枝之温燥。人参、甘草益气健脾，以资生化之源，阳生阴长，气旺血充；半夏、生姜辛开散结，通降胃气，以助祛瘀调经；其中生姜又温胃气以助生化，且助吴茱萸、桂枝以温经散寒，以上均为佐药。甘草尚能调和诸药，兼为使药。诸药合用，共奏温经散寒，养血祛瘀之功。本方的配伍特点有二：一是方中温清补消并用，但以温经补养为主；二是大队温补药与少量寒凉药配伍，能使全方温而不燥、刚柔相济，以成温养化瘀之剂。

根据现代药理研究结果显示，温经汤的主要成分吴茱萸不仅有健胃、止痛、止吐、治酸、抑菌等作用，还可以促进子宫收缩。当归、川芎、芍药等均有较好的解痉镇痛和扩张血管的作用，当归、人参、阿胶等则可以增加血液中

红细胞和血红蛋白的数量和质量。本方是一个科学严谨而有效的调经验方。

方剂制备

上十二味药以水约2000毫升煎至约剩余600毫升左右，滤去药渣，分3次温服。

使用注意

月经不调属实热或无瘀血内阻者特别是出现烦热症状的，属于气郁化火、湿热内蕴、火热内生者皆忌用；服药期间忌食生冷之品。

临症加减

1. 终日觉冷，下肢尤甚，面色萎黄，倦怠无力者，去丹皮、麦冬，加艾叶、制香附、炮姜、小茴香等暖宫。

2. 瘀血内阻严重者，表现为月经内多有紫黑血块，小腹拘急坚实，舌色暗红或有瘀点，方中可适当加入桃仁、红花、乳香、没药、丹参等。

3. 兼夹痰湿内阻，胸脘痞闷不舒，舌苔腻垢者，可加入苍术、陈皮、川朴等。

典型案例

周某，女，51岁。7年前曾小产一次，已停经3年，于半年前偶见漏下，未予治疗。1个月后，病情加重，经水淋漓不断，经色浅，时见少腹疼痛。曾诊断为“功能性子宫出血”，经注射止血针，服用止血药，虽止血数日，但

少腹胀满时痛，且停药后复漏下不止。

又服中药数十剂，也没有效果。身体日渐消瘦。面色白，五心烦热，午后潮热，口干咽燥，大便秘结。舌质淡红，苔薄白，脉细涩。诊断证属冲任虚损，瘀血内停。治以温补冲任，养血祛瘀。处方：吴茱萸9g，当归9g，川芎6g，白芍12g，党参9g，桂枝6g，阿胶9g（烊化），丹皮6g，半夏6g，生姜6g，炙甘草6g，麦冬9g，水煎服。

病名

糖尿病、消渴、
慢性肾炎

中医病名

肝肾阴虚证

症状

肾阴虚证。主要表现为腰膝酸软，头晕目眩，耳鸣耳聋，盗汗，遗精，消渴，骨蒸潮热，手足心热，舌燥咽痛，牙齿动摇，足跟疼痛，小便淋漓，以及小儿囟门不合，舌红少苔，脉沉细数。本方是治疗肝肾阴虚证的基础方。临床应用以腰膝酸软，头晕目眩，口燥咽干，舌红少苔，脉沉细数为辨证要点。

由于肝肾主筋骨，而肝肾阴液不足，不能充养腰膝，则可见腰膝酸软。



肝肾阴虚而虚火上扰，所以头晕耳鸣健忘、视物昏花。五心烦热、颧红盗汗、舌红等都是虚热之象，而咽干口燥、口渴欲饮水则为阴液不足的表现。精血不足，则妇女月经少或者经闭，但如虚热内盛，血热妄行，又可能导致崩漏难止。虚火内扰心神会导致失眠，如果扰于精室则有遗精。同时肾主骨生髓，而脑被中医称为“髓之海”，全仗肾阴滋养，所以肝肾阴虚证的临床症状与脑的关系非常密切。又因肾主人体的泌尿生殖功能，所以许多泌尿系统、生殖系统的病变经常发生于肝肾阴虚证中，这与肺胃阴伤证多出现呼吸系统及消化系统疾病有所区别。而在外感热性病的后期所表现的肝肾阴虚证，每见于危重病证之后，除了表现出上述相关症状之外，还可以有低热久留不去，或者手足抽搐、强直等筋脉失于滋养、虚风动于内的表现。

【用方】

六味地黄丸

——《小儿药证直诀》

方剂说明

滋阴补肾。

适用于慢性肾炎、高血压病、糖尿病、肺结核、肾结核、甲状腺功能亢进、中心性视网膜炎及无排卵性功能性

子宫出血、更年期综合征等属肾阴虚弱为主者。

组成

熟地24g，山茱萸、山药各12g，泽泻、牡丹皮、茯苓各9g。

歌曰：六味地黄益肝肾，茱萸丹泽地苓专，更加知柏成八味，阴虚火旺自可煎。养阴明目加杞菊，滋阴都气五味先，肺肾两调金生水，麦冬加入长寿丸。

配伍说明

肾藏精，为先天之本，肝为藏血之脏，精血互可转化，肝肾阴血不足又常可相互影响。腰为肾之府，膝为筋之府，肾主骨生髓，齿为骨之余，肾阴不足则骨髓不充，故腰膝酸软无力、牙齿动摇、小儿囟门不合；脑为髓海，肾阴不足，不能生髓充脑，肝血不足，不能上荣头目，故头晕目眩；肾开窍于耳，肾阴不足，精不上承，或虚热生内热，甚者虚火上炎，故骨蒸潮热、消渴、盗汗、小便淋沥、舌红少苔、脉沉细数。治宜滋补肝肾为主，适当配伍清虚热、泻湿浊之品。方中重用熟地黄滋阴补肾，填精益髓，为君药。山茱萸补养肝肾，并能涩精，取“肝肾同源”之意；山药补益脾阴，亦能固肾，共为臣药。三药配合，肾肝脾三阴并补，是为“三补”，但熟地黄用量是山茱萸与山药之和，故仍以补肾为主。泽泻利湿而泄肾

浊，并能减熟地黄之滋腻；茯苓淡渗脾湿，并助山药之健运，与泽泻共泻肾浊，助真阴得复其位；丹皮清泄虚热，并制山萸肉之温涩。三药称为“三泻”，均为佐药。六味合用，三补三泻，其中补药用量重于“泻药”，是以补为主；肝、脾、肾三阴并补，以补肾阴为主，这是本方的配伍特点。

六味地黄丸系宋·钱乙从《金匱要略》的肾气丸减去桂枝、附子而成，原名“地黄丸”，用治肾怯诸证。《小儿药证直诀笺正》说：“仲阳意中，谓小儿阳气甚盛，因去桂附而创立此丸，以为幼科补肾专药。”

根据现代药理研究结果显示，六味地黄丸有明显的增强细胞免疫功能的作用，可以刺激和提高抗体的生成，并有一定的强壮作用。本方也可以促进尿素的排出，所以可以用于治疗慢性肾炎。本方还对肾性高血压有降压功能，也能改善肾脏的功能，并可以改善神经系统以及性腺的功能，具有延缓衰老和抗肿瘤的作用。方中成分熟地可以降血糖、强心、利尿、抗过敏。山萸萸在大剂量使用时有较好的升高血压抗休克作用，而对病理性高血压却可以起到降压的作用，显示其针对血压具有双向调节的能力。山药除富含营养成分及淀粉酶等，也可以强壮滋补身体，帮助消化。丹皮可以扩张血管，改善毛细血管的通透性，泽泻则可以降血脂，减轻动脉粥样硬化的程度和发生可

能，改善肾脏功能。茯苓也可以利尿并增强细胞免疫功能。因而显示本方对人体的免疫功能失常和多种脏器的病变有较好的治疗作用。

方剂制备

方中诸药研为末，炼蜜为丸，如梧桐子大小。每次用温开水或盐汤服用6~9g，空腹服用，1日3次。亦可用1500毫升左右水煎服。

使用注意

1. 本方虽然有“补中有泻”之称，但是毕竟以滋补为主，若肝肾阴虚而伴有明显的水湿、虚火、痰浊、瘀血等情况时，应配合相应祛邪药物使用。

2. 脾虚泄泻者慎用。

临症加减

1. 知柏地黄丸：六味地黄丸加知母盐炒、黄柏盐炒各6g。功用：滋阴降火。主治：阴虚火旺证。骨蒸潮热，虚烦盗汗，腰脊酸痛，遗精等症。

2. 杞菊地黄丸：六味地黄丸加枸杞子、菊花各9g，功用：滋肾养肝明目。主治：肝肾阴虚证。两目昏花，视物模糊，或眼睛干涩，迎风流泪等。

3. 都气丸：六味地黄丸加五味子6g，功用：滋肾纳气。主治：肾虚气喘，或呃逆之证。

4. 麦味地黄丸：六味地黄丸加麦



冬9g，五味子6g，功用：滋补肺肾。主治：肺肾阴虚，或喘或咳者。

典型案例

贺某，男，46岁。声嘶日久，说话低沉，自觉咽部干涩、疼痛，午后加重，腰膝酸软，手足心发热，小便黄，舌质白，少津，脉弦细。处方：熟地黄30g，山药30g，山茱萸10g，丹皮10g，泽泻10g，蝉蜕10g，桔梗10g，石斛10g。水煎服，每日1剂，分2次服。

病名

膀胱炎、尿道炎、肾盂肾炎、前列腺炎

中医病名

热淋证

症状

湿热淋证。主要表现为尿频尿急，淋漓不畅，尿色浑赤，甚则癃闭不通，小腹急满，口燥咽干，舌苔黄腻，脉滑数。本方为主治湿热淋证之常用方。临床应用以尿频尿急，溺时涩痛，舌苔黄腻，脉滑数为辨证要点。

【用方】

八正散

《太平惠民和剂局方》

方剂说明

清热泻火，利水通淋。

适用于膀胱炎、尿道炎、急性前列腺炎、泌尿系结石、肾盂肾炎、术后或产后尿潴留等属湿热下注者。

组成

车前子、瞿麦、篇蓄、滑石、山栀子仁、炙甘草、大黄、木通各9g，煎时入灯心草。

歌曰：八正木通与车前，篇蓄大黄滑石研。草梢瞿麦兼栀子，煎加灯草痛淋蠲。

配伍说明

本方为治疗热淋的常用方，其症因湿热下注膀胱所致。湿热下注蕴于膀胱，水道不利，故尿频尿急、溺时涩痛、淋漓不畅，甚则癃闭不通；湿热蕴蒸，故尿色浑赤；湿热郁遏，气机不畅，则少腹急满；津液不布，则口燥咽干。治宜清热利水通淋。方中以滑石、木通为君药。滑石善能滑利窍道，清热渗湿，利水通淋，《药品化义》谓之：“体滑主利窍，味淡主渗热”；木通上

清心火，下利湿热，使湿热之邪从小便而去。篇蓄、瞿麦、车前子为臣，三者均为清热利水通淋之常用品。佐以山栀子仁清泄三焦，通利水道，以增强君、臣药清热利水通淋之功；大黄荡涤邪热，并能使湿热从大便而去。甘草调和诸药，兼能清热、缓急止痛，是为佐使之用。煎加灯心草以增利水通淋之力。

《太平惠民和剂局方》原用本方“治大人、小儿心经邪热，一切蕴毒……”乃取方中木通、山栀子仁、大黄、车前子、灯心草诸药，皆入心经，俱有清心泻火解毒之功。同时，还能通利小肠，导湿热下行，合滑石、篇蓄、瞿麦以增利水通淋之效，故又云：“治小便亦涩，或癃闭不通，及热淋、血淋。”为湿热下注膀胱所致。

方剂制备

散剂，每服6~10g，灯心草煎汤送服；汤剂，加灯心草，水煎服，用量根据病情酌定。

临症加减

1. 淋而带血，可加小蓟、白茅根、生蒲黄等。
2. 有结石者，可加金钱草、海金沙等。

典型案例

王某，男，55岁。由发热而致小便淋漓不爽，甚至带出血块。诊断此热结

膀胱，高年之所忌也。处方：篇蓄、山栀子仁、细木通、滑石块、牛膝梢、赤猪苓、丹皮、车前子、甘草梢、泽泻、瞿麦、淡竹叶各9g，沉香6g，西血珀12g，二味研细先调服，其余水煎服。

病名

急性泌尿系统感染、
尿路结石

中医病名

尿血证

症状

血淋、尿血。主要表现为尿中带血，小便频数，赤涩热痛，舌红，脉数。本方为治疗血淋、尿血属实热证的常用方。临床应用以尿中带血，小便赤涩热痛，舌红，脉数为辨证要点。

【用方】

小蓟饮子——

《济生方》录自《玉机微义》

方剂说明

凉血止血，利水通淋。

适用于急性泌尿系统感染、泌尿系结石等属下焦瘀热，蓄聚膀胱者。



组 成

生地30g，小蓟15g，滑石15g，木通6g，蒲黄9g，藕节9g，淡竹叶9g，当归6g，栀子9g，炙甘草6g。

歌曰：小蓟饮子藕蒲黄，木通滑石生地襄，归草黑栀淡竹叶，血淋热结服之良。

配伍说明

本方证因下焦瘀热，损伤膀胱血络，气化失司所致。热聚膀胱，损伤血络，血随尿出，故尿中带血，其痛者为血淋，若不痛者为尿血；由于瘀热蕴结下焦，膀胱气化失司，故见小便频数、赤涩热痛；舌红脉数，亦为热结之症。治宜凉血止血，利水通淋。方中小蓟甘凉入血分，功擅清热凉血止血，又可利尿通淋，尤宜于尿血、血淋之症，是为君药。生地黄甘苦性寒，凉血止血，养阴清热；蒲黄、藕节助君药凉血止血，并能消瘀，共为臣药。君臣相配，使血止而不留瘀。热在下焦，宜因势利导，故以滑石、竹叶、木通清热利水通淋；栀子清泄三焦之火，导热从下而出；当归养血和血，引血归经，尚有防诸药寒凉滞血之功，合而为佐。使以甘草缓急止痛，和中调药。诸药合用，共成凉血止血为主，利水通淋为辅之方。本方是由导赤散加小蓟、藕节、蒲黄、滑石、栀子、当归而成，由清心养阴，利水通

淋之方变为凉血止血，利水通淋之剂。

其配伍特点是止血之中寓以化瘀，使血止而不留瘀；清利之中寓以养阴，使利水而不伤正。这是治疗下焦瘀热所致血淋、尿血的有效方剂。血淋、尿血，为下焦郁热，损伤膀胱血络，故尿中带血。膀胱刺激症：尿频、尿急、尿道刺痛、尿血。

方剂制备

作汤剂，水煎服，用量据病证酌情增减。

使用注意

方中药物多属寒凉通利之品，只宜于实热证。若血淋、尿血日久兼寒或阴虚火动或气虚不摄者，均不宜使用。

临症加减

1. 下焦热盛者，可加知母、黄柏、虎杖等。
2. 排尿涩痛者，可加琥珀、海金沙等。
3. 病久气阴两伤者，可酌减滑石、川木通，加黄芪、阿胶等。

典型案例

唐某，男，9岁。因血尿2天来院，诊断为“急性肾炎”，当时肉眼可见血尿，排尿时有灼热感，但无尿痛，脉弦，舌苔黄腻。诊断：尿血证。处方：生地30g，小蓟15g，滑石15g，木通6g，

蒲黄9g, 藕节9g, 淡竹叶9g, 当归6g, 栀子9g, 炙甘草6g, 水煎服。

病名

尿频、小儿尿失禁

中医病名

遗尿证

症状

膀胱虚寒证。主要表现为小便频数, 或遗尿不止, 舌淡, 脉沉弱。

【用方】

缩泉丸——《妇人良方》

方剂说明

温肾祛寒, 缩尿止遗。

组成

乌药6g, 益智仁9g, 酒煎山药末为糊, 作丸。

歌曰: 缩泉丸将遗尿治, 山药台乌加益智。

配伍说明

方中益智仁辛温, 温补脾肾, 固精

气, 缩小便, 为君; 乌药辛温, 调气散寒, 除膀胱肾间之冷气, 止小便频数, 为臣; 以山药糊丸, 取其健脾补肾, 固涩精气, 为佐使。

方剂制备

上药为细末, 以酒制山药粉为糊, 制成小丸, 每服6~9g, 以米汤送服, 1日2~3次。

临症加减

如患者症状较重, 可加菟丝子、金樱子、桑螵蛸、覆盆子、补骨脂等做汤剂服用。

典型案例

陈某, 男, 69岁。小便频数数年, 重者亦日十数次, 自觉腰膝酸软, 筋骨无力。查体形寒肢冷, 舌淡, 脉沉弱。诊断为肾虚遗尿证。处方: 乌药6g, 益智仁9g, 菟丝子9g, 补骨脂9g, 以酒制山药粉为糊, 制成小丸, 每服6~9g, 以米汤送服, 1日2~3次。

**病名**

遗精、遗尿

中医病名

肾虚遗精证

症状

遗精。遗精滑泄，神疲乏力，腰痛耳鸣，舌淡苔白，脉细弱。

【用方】**金锁固精丸**

——《医方集解》

方剂说明

补肾涩精。

组成

沙苑蒺藜、芡实、莲须各12g，龙骨、煅牡蛎各10g，莲子粉糊丸。

歌曰：金锁固精芡莲须，蒺藜龙骨与牡蛎，莲粉糊丸盐汤下，补肾涩精止滑遗。

配伍说明

方中以沙苑蒺藜甘温补肾固精为君；芡实、莲须甘涩而平，益肾固精，补脾，

且莲子亦可交通心肾，为臣；佐以龙骨甘涩平，牡蛎咸平微寒，俱能固涩止遗；莲须甘平，尤为收敛固精之佳品。

方剂制备

上药共为细末，以莲子粉糊丸，每次服9g，空腹淡盐水送下，1日2~3次。亦可按原方用量水煎服。

使用注意

本方为纯固涩之剂，治标之方。常与水陆二仙丹合方。此方证之遗精为肾虚封藏失职，精关不固，以致遗精滑泄，除此之外不适用。

临症加减

男子遗精白浊，小便频数，女子带下，纯属肾虚不摄者以水陆二仙丹一芡实、金樱子各12g水煎服，补肾涩精。

典型案例

黄某，男，25岁。遗精2年有余，近年次数愈发频繁，遗精滑泄，神疲乏力，腰痛耳鸣，舌淡苔白，脉细弱。诊断为肾虚遗精证，处方：沙苑子、芡实、莲须各12g，龙骨、煅牡蛎各10g，莲子粉糊丸。

病名

慢性宫颈炎、慢性
盆腔炎

中医病名

湿浊带下证

症状

脾虚肝郁，湿浊带下。主要表现为带下色白，清稀如涕，肢体倦怠，舌淡苔白，脉缓或濡弱。本方为治脾虚肝郁，湿浊下注带下之常用方。临床应用以带下清稀色白舌淡苔白，脉濡缓为辨证要点。

【用方】

完带汤

——《傅青主女科》

方剂说明

补脾疏肝，化湿止带。

适用于阴道炎、宫颈糜烂、盆腔炎而属脾虚肝郁，湿浊下注者。

组成

白术20g，山药30g，人参6g，白芍15g，车前子9g，苍术9g，甘草3g，陈皮2g，黑芥穗2g，柴胡2g。

歌曰：完带汤中用白术，山药人参白芍辅，苍术车前黑芥穗，陈皮甘草与柴胡。

配伍说明

本方为治疗白带的常用方剂，所主病症乃由脾虚肝郁、带脉失约、湿浊下注所致。脾虚生化之源不足，气血不能上荣于面致面色晄白；脾失健运，水湿内停，清气不升致倦怠便溏；脾虚肝郁，湿浊下注，带脉不固致带下色白量多、清稀如涕；舌淡白，脉濡弱为脾虚湿盛之象。治宜补脾益气，疏肝解郁，化湿止带。方中重用白术、山药为君，意在补脾祛湿，使脾气健运，湿浊得消；山药并有固肾止带之功。臣以人参补中益气，以助君药补脾之力；苍术燥湿运脾，以增祛湿化浊之力；白芍柔肝理脾，使肝木条达而脾土自强；车前子利湿清热，令湿浊从小便分利。佐以陈皮之理气燥湿，既可使补药补而不滞，又可行气以化湿；柴胡、芥穗之辛散，得白术则升发脾胃清阳，配白芍则疏肝解郁。使以甘草调药和中，诸药相配，使脾气健旺，肝气条达，清阳得升，湿浊得化，则带下自止。本方的配伍特点是寓补于散，寄消于升，培土抑木，肝脾同治。

方剂制备

上药以水约2000毫升，煎至约剩余



600毫升，滤去药渣，分3次温服。

使用注意

带下证属湿热下注者，非本方所宜。

临症加减

1. 带下量多或夹杂出血，可加煅龙骨、煅牡蛎、乌贼骨、茜草等。
2. 肾虚亏损严重者，可加沙苑子、蒺藜、熟地、肉苁蓉、山茱萸等。
3. 带下色黄，粘稠腥臭者，可加入黄柏、椿皮、丹皮等。

典型案例

孙某，女，29岁。带下量多两月有余，呈白色，清稀如涕，肢体倦怠，舌淡苔白，脉濡弱。诊断为脾虚湿浊下注，处方：白术20g，山药30g，人参6g，白芍15g，车前子9g，苍术9g，甘草3g，陈皮2g，黑芥穗2g，柴胡2g，肉苁蓉3g，水煎服。

《高麗王實杜中翫祇意》

《中翫祇方、祇方》

《高麗方國地補方中翫

中者、高麗見所地、

其方兩百餘方、

其方今、諸多名方、

不陸易見、

皆錄其方、而

對其些病、

其方不斷、

同、適合度、

其方、

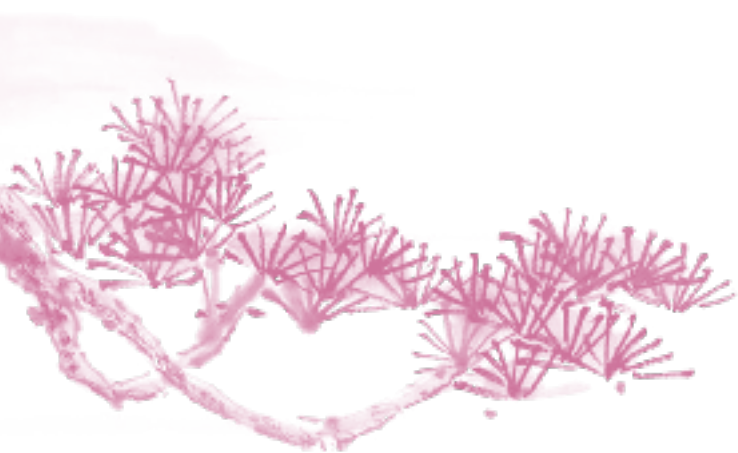
三、編方、

二、經方、

一、中翫祇方、

又、日、

其方、



第六章

其他疾病

本書上至醫社中醫視毒、
視民視中醫視方、脈方、
視方等視方圓的視方中視
視方中視方常見視方四
視方，共視而百餘方。視
視方古今視多視方、視
視方，不視易視、易
視方、視視視視、而視
視方，對視些視視視視
視方，不視視視視，視
視方，視視合視大視
視方。

視些視方大視，視四視
一視視視方，二視視視
二視中視視視方，四
視方視視方，五視日視
視方，視視視視方視

病名

荨麻疹、湿疹、过敏性

皮炎

中医病名

风疹

症状

风疹、湿疹。主要表现皮肤疹出色红，或遍身云片斑点，瘙痒，抓破后渗出津水，苔白或黄，脉浮数。

外风证往往并非风邪单独致病，一般会同时夹杂寒、热、湿邪等。如夹杂寒邪，则皮损呈现苍白颜色，周身恶寒无汗，有遇冷感寒症状加重的表现；如夹杂热邪，一般皮损肿块颜色红赤而灼热，烦躁而口苦，遇热则病情加重；如夹杂湿邪，可见皮损分泌粘液、溢水，周身困重等表现。本方一般针对的是夹杂热邪或者湿邪的外风证。

本症皮肤瘙痒的表现主要为游走无定处，此外风证的特性之一，也是本证的主要诊断依据，是风邪侵犯人体肌表，走串活动所致。如果风邪与湿邪相兼挟，风湿蕴藏于肌肤血脉之中，经常会导致皮肤糜烂渗液、产生脓水。由于本证经常夹杂热邪，所以也有一些热邪上扰心神导致心烦口苦，神志不安等现象。本证迁延日久，外邪陷瘀于肌肤，

可以导致皮肤血液运行不畅，失去足够的养分，进一步加剧皮肤的瘙痒和其他损害。另一方面，老年人或本身素体阴血不足者，皮肤平素即血液濡养不足，也往往是外风证的易感人群，并且一旦感染不易治愈。而单纯由于血液不能濡养肌肤所造成的皮肤瘙痒主要病因为血燥，不属于本方外风的范围。

【用方】

消风散——《外科正宗》

方剂说明

疏风养血，清热除湿。

《外科正宗》卷4：“治风湿浸淫血脉，致生疥疮，瘙痒不绝，及大人小儿风热瘾疹，遍身云片斑点，乍有乍无并效。”

适用于急性荨麻疹、湿疹、过敏性皮炎、稻田性皮炎、药物性皮炎、神经性皮炎等属于风热或风湿所致者。临床上有很多使用过各种抗过敏药品、抗组胺药、甚至激素也没有效果的顽固性皮肤病，往往可以在投用本方后取得比较满意的效果。

组成

荆芥、防风、牛蒡子、蝉蜕、苍术、苦参、石膏、知母、当归、胡麻仁、生地各6g，木通、生甘草各3g。



歌曰：消风散内有荆防，蝉蜕胡麻苦参苍。知膏蒡通归地草，风疹湿疹服之康。

配伍说明

本方所治之风疹、湿疹，是由风湿或风热之邪侵袭人体，浸淫血脉，内不得疏泄，外不得透达，郁于肌肤腠理之间所致，故见皮肤瘙痒不绝、疹出色红、或抓破后津水流溢等。治宜疏风为主，佐以清热除湿之法。痒自风而来，止痒必先疏风，故以荆芥、防风、牛蒡子、蝉蜕之辛散透达，疏风散邪，使风去则痒止，共为君药。配伍苍术祛风燥湿，苦参清热燥湿，木通渗利湿热，是为湿邪而设；石膏、知母清热泻火，是为热邪而用，以上俱为臣药。然风热内郁，易耗伤阴血；湿热浸淫，易瘀阻血脉，故以当归、生地、胡麻仁养血活血，并寓“治风先治血，血行风自灭”之意为佐。甘草清热解毒，和中调药，为佐使。诸药合用，以祛风为主，配伍祛湿、清热、养血之品，祛邪之中，兼顾扶正，使风邪得散、湿热得清、血脉调和，则痒止疹消，为治疗风疹、湿疹之良方。

治痒必要疏风。治血包含：配伍活血药、祛瘀药；郁久化热，故用凉血药；郁久耗伤阴血，故用养血药。若痒甚，则加清热燥湿之品：苦参、白鲜皮、地肤子。

根据现代药理研究结果显示，消风散汤剂成分中的防风 and 甘草都含有具备良好抗过敏作用的成分。而荆芥、苍术、当归的药理成分则具有扩张皮肤血管、改善肌肤血液循环、抗炎、抑制细菌等功效。蝉蜕含有镇静的成分。苦参止痒抗菌效果较好，不但经常应用于煎剂中，也是皮肤科外用方的常用组成部分，与当归、生地等药物一样有控制抗体生成的效果。消风散全方能有效调节人体的免疫系统功能，抗过敏、改善血液循环状况、抗菌消炎，针对外风证有良好的药理学基础。

方剂制备

全方研磨为粗末，以水600毫升煎成400毫升空腹服，1日2次。

使用注意

1. 治疗期间尽量避免风寒类刺激，不宜食用油腻荤腥、奶制品等，保持饮食清淡、心情愉快。

2. 可以配合外用洗剂，如荆芥10g，防风10g，苦参15g，白藓皮10g，地肤子10g，白帆10g煎汤洗患处，可取得较好的治疗效果。

临症加减

1. 伴有大便秘结不通者，可加生大黄少量。

2. 皮损渗出多，为湿邪较重，可加

地肤子、萆薢、车前子、白藓皮等。

3. 如果周身起疹块，颜色鲜红瘙痒剧烈，是热邪较重的表现，可加金银花、连翘、赤芍、丹皮等，同时可以加大苦参的用量。

4. 久病不愈，皮肤损害严重者，可加蛇蜕、乌蛇、白花蛇等。

实例练习

黄某，女，16岁，近3天来全身发风疹块，成片出现，此起彼伏，瘙痒异常导致影响正常休息，外出感风病情加重。自觉心中烦闷，口苦，小便黄赤，查体舌苔薄白，舌尖稍红，脉诊为弦滑。诊断为外风夹热证。处方：荆芥6g，防风6g，牛蒡子6g，蝉蜕6g，苍术6g，苦参6g，石膏6g，知母6g，当归6g，胡麻仁6g，生地6g，木通3g，生甘草3g，金银花6g，连翘6g，水煎服。

病名

癫痫、神经衰弱症（精神分裂症、眩晕症）

中医病名

少阳痰热证

症状

少阳痰热证。主要表现为胸胁满闷，神志异常，易受惊吓，不安多虑，或狂躁怒骂，多言胡话。可有发热或寒热往来，身体困重，小便不利，耳鸣眩晕，口苦，舌苔黄腻，舌质红，脉象弦数或弦滑。

本症可以因外感病证，表证未解，正气已虚，导致病邪趁机内陷少阳引起，也可因长期内伤杂病耗损脏腑之气，而造成的痰热阻内。由于邪犯少阳，故可见胸胁满闷。同时邪阻肝胆，或蒙蔽心经，又可出现各种神志症状。轻者可见心烦惊悸，焦虑或者抑郁，重则神志不清。以上这些都是诊断本证的主要依据。此外，如本证是发生于外感热证之后，则病邪来源于太阳经之表或少阳经，也有可能入里热结阳明，所以有发热或寒热往来等各种不同症状，如继发于内伤久病之后，人体阳气不足，就不一定会有发热症状了。另外，本症可能有表邪未解、正气受伤、邪阻经络



等各种变化发生，故而周身沉重、活动不灵等全身性的表现也可能出现。而少阳为邪气所阻，体内津液水分运行不畅，小便减少或小便不利。津液固壅，痰热上扰，则耳鸣眩晕，口苦而不能安眠。

本症的诊断方面，除了对主要症状的确认外，还可以参考其他症状是否与胆经有关。如美尼尔氏综合征所表现出的耳鸣眩晕，就属于少阳胆经上耳的范畴。而有些癫痫病患者发作时有胸胁部位涨满疼痛等表现，也与少阳经循行部位有关，则也可以作为本病诊断的依据。

【用方】

柴胡加龙骨牡蛎汤

——《伤寒论》

方剂说明

和解少阳，重镇安神。

组成

柴胡9g，龙骨15g，黄芩6g，生姜6g，铅丹（现代用生铁落30g代替），人参6g，桂枝6g，茯苓9g，半夏6g，大黄6g，煅牡蛎15g，大枣3枚。

歌曰：柴胡龙骨牡蛎汤，黄芩铅丹人参姜，芩夏大黄桂枝枣，清热镇惊是良方。

配伍说明

柴胡加龙骨牡蛎汤配方上是以小柴胡汤作为基础加味而成的。方中仍沿用小柴胡汤的柴胡桂枝配伍，以解内陷于少阳的病邪，本方所针对的症状有痰热之邪，故去掉性属甘温的甘草。同时桂枝配合龙骨牡蛎以及铅丹等性质属沉降的重性药物，对镇惊安神有较好效果。附以大黄泻邪热、茯苓利小便，驱除痰热。

根据现代药理研究表明，本方的煎剂成分中，有对神经系统有显著作用的成分。而配方中的龙骨牡蛎均对兴奋的神经中枢有安定抑制的作用。方中小柴胡汤为底，镇静神经，再加入龙骨牡蛎铅丹几位重镇之品，则镇静之功更强，适用于神经系统疾病。

方剂制备

本方取除大黄之外的11味药材，取1600毫升水，煮至药汁约为最初的一半后，再加入切块的大黄，沸腾几次至药汁量再减少一半，平均分为3份，每次取1份服用，1日3次。

使用注意

本方成分复杂，临床使用时须仔细辨证，根据患者情况酌情使用。另外本方不可长期服用，二至三天没有明显疗效即须转用它法。辨证须仔细，如非少



阳痰热，比如纯虚火热之症等均不使用本方。

临症加减

1. 兼见胸胁疼痛、大便色深、舌紫暗着，为瘀血内阻，可加桃仁、红花、川芎、地鳖等。

2. 面目红赤，便秘小便短赤，是邪热内盛的表现，加龙胆草、栀子，去人参、桂枝、生姜和大枣等有热补作用的药材。

3. 如果患者眩晕严重，痰多苔厚，是痰热势重的表现，可加礞石、沉香、石菖蒲。

4. 病人烦躁不安，坐立不宁而易受惊吓者，可酌情添加朱砂、夜交藤、酸枣仁。

5. 病人素体虚弱，原方基础上减少大黄、铅丹的用量；如痰热旺盛，则少用人参。

6. 无少阳证表现的，去柴胡。

典型案例

杨某，女32岁，素有癫痫病史，近日发作频繁前来就诊。自述头晕恶心，胸脘憋闷，便秘尿少。查体面色红赤，舌红苔腻，脉弦数。诊断为少阳痰热证。处方：柴胡9g，龙骨15g，黄芩6g，铅丹（现代用生铁落30g代替），茯苓9g，半夏6g，大黄6g，煅牡蛎15g，龙胆草9g，栀子9g，水煎服。

病名

面神经麻痹

中医病名

面瘫证

症状

面瘫。主要表现为口眼歪斜，或面部肌肉抽动，舌淡红，苔白。本证主要的症状是面部嘴角向一侧歪斜，口唇不利，不能紧闭，进食汤水从嘴角漏出，一侧眼睑不能闭合等。其他兼见症状包括微恶风寒，肌肉抽动或掣痛，也可能有两耳后下部疼痛。

口眼歪斜是本症的主要症状，这是由于病邪侵犯的是颜面部神经脉络的一侧，导致患侧局部功能障碍，肌肉神经失养造成的。其具体表现为面部一侧肌肉因为瘫痪无力而表现为迟缓松弛无法用力，另一侧由于功能正常肌肉具有一定张力相对紧张，牵扯患侧使口眼歪斜，患者可能出现面部表情消失，无法皱眉，眼睑不能闭合导致时时流泪，鼻唇沟即人中变浅甚至消失，嘴角向健侧歪斜，流涎。同时因本证源于外来风邪侵犯人体，营卫之气起而抗争，故有些病例可见病人有自觉发热恶寒症状，即正邪抗争



的表现。至于出现局部疼痛现象，则源于经脉气血不行，不通则痛。

口眼歪斜并不是只有面神经麻痹会出现的症状，也可以见于其他疾病，比如腮腺炎、中耳炎、乳突炎、梅毒、鼻咽癌、听神经纤维瘤等疾病，虽然极为少见，并非不会出现。此外，中风后半身不遂的患者也会出现口眼歪斜的症状，但与面瘫证的区别在于中风者除颜面部症状及一侧手足瘫痪外，面部特点是上额纹并不消失，两眼也可闭合如常，只有口角下垂、饮水外漏、鼻唇沟平坦等表现。

【用方】 牵正散

——《杨氏家藏方》

方剂说明

祛风化痰，通络止痉。

牵正散原本是治疗口眼歪斜的专方，但是近代通过临床实践发展出更为广泛的应用经验。经常用来治疗多种神经系统的疾病。比如面肌痉挛、中风偏瘫、三叉神经痛、偏头痛、末梢神经炎等，也都有不错的临床效果。

组成

白附子、僵蚕、全蝎、去毒，并生用，各等分3g。

歌曰：牵正散治口眼斜，白附僵蚕加全蝎。混合研细调酒服，风中脉络功效显。

配伍说明

本方所治之症，为风痰阻于头面经络所致。足阳明之脉夹口环唇，布于头面；足太阳之脉起于目内眦。阳明内蓄痰浊，太阳外中于风，风邪引动内蓄之痰浊，风痰阻于头面经络，经隧不利，筋肉失养，则弛缓不用；无邪之处，气血运行通畅，筋肉相对而急，缓者为急者牵引，故口眼喎斜。治宜祛风，化痰，通络。方中白附子辛温燥烈，入阳明经而走头面，以祛风化痰，尤其善散头面之风为君。全蝎、僵蚕均能祛风止痉，其中全蝎长于通络，僵蚕且能化痰，合用既助君药祛风化痰之力，又能通络止痉，共为臣药。用热酒调服，以助宣通血脉，并能引药入络，直达病所，以为佐使。药虽三味，合而用之，力专而效著。风邪得散，痰浊得化，经络通畅，则喎斜之口眼得以复正，是名“牵正”。

根据现代药理研究结果显示，牵正散的组成中，白附子还有镇静神经系统和阵痛的成分，全蝎和僵蚕有抗惊厥、镇静的作用。所以本方不仅能够针对单纯性面瘫，对一些神经系统病变也具有良好的临床效果。

方剂制备

共为细末，每次服3g，日服2~3次，温酒送服；亦可作汤剂，用量按原方比例酌定。

使用注意

1. 牵正散性质偏温燥，对于偏寒性质的风阻面络比较适合，如患者耳后红肿、口苦而渴等热性症状出现，则不宜单用本方。

2. 本方性质温燥，久服伤及人体阴液，尤其平素体质阴虚或有内热的患者，应适时配合清热以及滋养阴津的药物，以免伤身。

临症加减

1. 风阻面络的同时兼见热象，可加生地、黄芩、石膏以清热。

2. 风挟寒邪，恶寒而无汗，面部抽掣疼痛的，可加防风、羌活、秦艽以祛风寒。

3. 外风夹寒湿邪，面部歪斜拘紧，同时伴随肢体沉重、冷痛麻木者，可加麻黄、附子、桂枝等温通散寒逐湿。

4. 病变日久，难以好转，并有痰瘀阻滞于内者，可加川芎、当归、芍药以和血通络。

5. 如外风大作，痉挛疼痛者，可酌情加蜈蚣、天麻、地龙等祛风止痉。

典型案例

罗某，男，60岁。习惯晨练，某冬日晨起出门，突觉面部拘紧不舒，当时并未在意，返家后家人发现其嘴角向右歪斜，自己取镜检查后才发现，鼻唇沟与嘴角均向右侧歪斜，左眼已不能闭合。今日为发病第三天患者自觉左侧耳后疼痛，怕风寒，进餐时不能约束汤水，从嘴角漏出，左眼流泪，口角流涎。查体舌苔薄腻，脉诊细弦。诊断为面瘫证，处方：白附子6g，僵蚕6g，全蝎6g，去毒，混合研成细粉，一次取3g，温酒送服。

病名

偏头痛

中医病名

风邪上袭证

症状

风邪头痛。主要表现为偏正头痛或巅顶作痛，恶寒发热，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮者。

本方是治疗外感风邪头痛之常用方。临床应用以头痛，鼻塞，舌苔薄白，脉浮为辨证要点。



本症为风寒外邪上袭于头部，阻于经络，导致气血运行不畅而引起的。其头痛的程度和部位都可以有不同之处，有隐隐作痛者，也有痛势激烈无法忍受者；有连绵不断者，也有时痛时缓者；有痛楚偏于头部一侧者，也有痛在头顶者；也有痛处不定甚至满头作痛者。共同的特点是吹冷风后会加重。如风寒之邪同时侵犯肌表，阻遏卫阳之气，就会同时出现发热恶寒、鼻塞流清涕以及肢体酸楚等表证表现。由于风邪是一种容易夹杂其他病邪的外邪，所以临床表现往往多种多样不一而足，如：夹寒邪，表现为头痛来势剧烈，遇寒或风吹加重，可伴见恶寒无汗等寒邪束表的症状；夹热邪，表现为头部胀痛，伴见口渴，舌红苔黄，小便黄赤等热像；夹湿邪，可见头痛沉重，如顶重物，同时胸脘痞闷，泛恶，舌苔腻等表现。

头痛本来属于表证中的一个症状，所以风邪上袭证与表证有着密切的关系，不过风邪上袭证以头痛为主要症状及判断依据，其他表证症状可有可无，而表证则以恶寒发热等表证为主，头痛作为伴随症状可轻可重。

【用方】

川芎茶调散

——《太平惠民和剂局方》

方剂说明

疏风止痛。

适用于感冒头痛、偏头痛、血管神经性头痛、慢性鼻炎头痛等属于风邪所致者。

组成

川芎、荆芥各12g，白芷、羌活甘草各6g，细辛3g，防风4.5g，薄荷12g，食后以清茶调下。

歌曰：川芎茶调散荆防，辛芷薄荷甘草羌。目昏鼻塞风攻上，正偏头痛悉能康。

配伍说明

本方所治之头痛，为外感风邪所致。风为阳邪，头为诸阳之会，清空之府。风邪外袭，循经上犯头目，阻遏清阳之气，故头痛、目眩；鼻为肺窍，风邪侵袭，肺气不利，故鼻塞；风邪犯表，则见恶风发热、舌苔薄白、脉浮等表证；若风邪稽留不去，头痛日久不愈，风邪入络，其痛或偏或正，时发时止，休作无时，即为头风。外风宜散，故当疏散风邪以止头痛。方中川芎辛



温香窜，为血中气药，上行头目，为治诸经头痛之要药，善于祛风活血而止头痛，长于治少阳、厥阴经头痛（头顶或两侧头痛），故为方中君药。薄荷、荆芥辛散上行，以助君药疏风止痛之功，并能清利头目，共为臣药。方中川芎、羌活、白芷可以疏风止痛，分别用于少阳、厥阴头痛（头顶或两侧痛），太阳头痛（后脑牵连项痛），阳明头痛（前额及眉心痛）；细辛散寒止痛，用于少阴头痛；防风辛散风邪，为治风之要药；薄荷、荆芥解表疏风，清利头目；炙甘草益气和中，调和诸药。李东垣谓“头痛须用川芎。如不愈，各加引经药，太阳羌活，阳明白芷”（《本草纲目》卷十四）；细辛祛风止痛，善治少阴经头痛（脑痛连齿），并能宣通鼻窍；防风辛散上部风邪。上述诸药，协助君、臣药以增强疏风止痛之功，共为方中佐药。甘草益气和中，调和诸药为使。综合本方，集众多辛散疏风药于一方，升散中寓有清降，具有疏风止痛而不温燥的特点，共奏疏风止痛之功。证为外感风邪所致，故治外风以疏散为主。

根据现代药理研究结果显示，川芎茶调散里的主要成分川芎具有明显的扩张血管、解痉、降血压等作用。方中的细辛、防风、羌活、白芷等都有一定的止痛、退热作用，因而本方不仅仅对风邪上袭的头痛有较好的效果，也对发热及其他原因引起的头痛有一定的治疗作用。

方剂制备

上药混合后研为细末，每次取6g，进食后以茶水调服，亦可水煎服。1日2次。如有恶寒发热，无汗而头痛者，可服药后稍微盖被取汗以解表。

使用注意

导致头痛的原因很多，有外感与内伤的不同，对于气虚、血虚、或肝肾阴虚、肝阳上亢、肝风内动等引起的头痛，均不宜使用。尤其火热内盛以及虚证头痛，如误用本方，势必导致助火、动风、伤阴等不良后果。因而必须辨证准确，切不可将本方作为单纯的止头痛方，不加辨证的随意使用。

临症加减

1. 如果患者寒象严重，甚至出现畏寒肢冷，可酌量加麻黄、熟附子、并重用川芎。
2. 兼见热象而口渴目赤，舌红尿黄者，应适量减少方中辛温药物的种类及用量，并加入黄芩、栀子、菊花、蔓荆子、白僵蚕、桑叶等清火热。
3. 头痛如裹，胸脘痞闷，身体困重，舌苔白腻者，可加入独活、苍术、厚朴等。
4. 头痛日久不愈，痛处固定且剧烈如针刺者，为痰瘀于内，可加入桃仁、红花、赤芍、全蝎、地龙等行血液化瘀痰。



5. 根据头痛的不同部位调节药物用量，如头顶痛或两侧痛，加重川芎用量同时加用柴胡，头颈牵连疼痛的，可加重羌活用量，前额疼痛的，则重用白芷等。

典型案例

王某，男，35岁。自诉三月前患风寒感冒后即感头痛，忽左忽右，经常发作，迄今未止。曾被诊断为火炎于上而投过清凉之剂，疼痛反增，不分昼夜，时重时轻，坐卧不宁。查体脉左右俱浮，两寸兼紧，舌苔薄黄。诊断为风寒火郁之证，患者初感风寒之际，未能及时汗解，更进以凉遏之品，致风邪伏而难除，阻于经络，郁遏清阳之气不得宣畅，遂化火上冲而成。脉浮兼紧，提示风寒之邪外束；阳郁化火表现为舌苔薄黄。应施以疏散风寒，宣解郁热之法。处方：川芎6g，吴白芷6g，生姜二片，薄荷6g，羌活3g，菊花6g，防风3g，炒黄芩3g，陈茶6g。

病名

流行性乙型脑炎、
脑性疟疾

中医病名

肝热动风证

症状

肝热动风证。主要表现为高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，发为惊厥，甚则神昏，舌绛而干，或舌焦起刺，脉弦而数。本方是治疗肝经热盛动风的常用方。临床应用以高热烦躁，手足抽搐，舌绛而干，脉弦数为辨证要点。

本症由邪热亢盛导致，所以必见高热，并可能有烦躁、口渴。热邪熏灼脉络会导致肢体强直或者抽搐，病情较轻者时发时止，严重者持续发作不解，情况非常危重，并且预后不良。在抽搐发作时，可能伴有意识不清、牙关紧闭、两目上视等症状，严重者可以出现角弓反张，即项背强直拘急，身体反仰呈弓状。高热抽搐也是本证的主要症状，根据这个症状的出现就可以诊断为肝热动风证。舌红而干以及舌苔灰黄甚至焦黑起刺以及脉弦数都是邪热亢盛、灼伤阴液，肝风内动的征象。对肝热动风证的诊断，要与外感热病后期以及一些慢性虚衰性的疾病因阴血或肝肾真阴亏损而

导致的虚风证相鉴别。虚风证的临床表现是低热或不发热，神情萎靡，手足蠕动或者轻缓抽动，舌干绛而痿软或淡红色，脉虚细，这些都是与肝风内动及实热内盛相鉴别的论据。

【用方】

羚角钩藤汤

——《通俗伤寒论》

方剂说明

凉肝熄风，增液舒筋。

适用于流脑、乙脑以及妊娠子痫、高血压所致的头痛、眩晕、抽搐等属肝经热盛，热极动风，或阳亢风动者。

组成

羚羊角4.5g，钩藤9g，霜桑叶6g，滁（白）菊花9g，生地15g，白芍9g，贝母12g，竹茹15g，茯神木9g，生甘草3g。

歌曰：俞氏羚角钩藤汤，桑菊茯神鲜地黄，贝草竹茹同芍药，肝风内动急煎尝。

配伍说明

本方证为温热病邪传入厥阴，肝经热盛，热极动风所致。肝经热盛，故高热不退；热扰心神，则烦闷躁扰，甚则神昏；热极动风，且风火相煽，灼伤津液，筋脉失养，以致手足抽搐，发为

痉厥。肝热风阳上逆所致的头晕胀痛、手足躁扰等，机理亦同。治宜清热凉肝熄风为主，佐以养阴增液舒筋为法。方中羚羊角咸寒，入肝经，善于凉肝熄风；钩藤甘寒，入肝经，清热平肝，熄风解痉。二药合用，相得益彰，清热凉肝，熄风止痉之功益著，共为君药。配伍桑叶、菊花清热平肝，以加强凉肝熄风之效，用为臣药。风火相煽，最易耗阴劫液，故用鲜地黄凉血滋阴，白芍养阴泄热，柔肝舒筋，二药与甘草相伍，酸甘化阴，养阴增液，舒筋缓急，以加强熄风解痉之力；邪热每多炼液为痰，故又以川贝母、鲜竹茹以清热化痰；热扰心神，以茯神木平肝宁心安神，以上俱为佐药。甘草兼调和诸药，为使。综观全方，以凉肝熄风为主，配伍滋阴、化痰、安神之品，标本兼治，为凉肝熄风法的代表方。“风火相煽，筋脉为病。”肝为风、心为火、肝为筋、脉为心，总说为肝心为病。温热初起，邪实为主，故见高热，脏腑辨证，重在心肝二脏。霜桑叶：辛凉，且有润泽之性。在平熄内风的同时要注意防止外风。

根据现代药理研究结果显示，羚角钩藤汤的主要成分羚羊角与钩藤均具有镇静、止痉、解热等作用。而其他成分如生地有强心、利尿、止血的作用，白芍可以发挥解痉、镇静抗菌、利尿等多方面作用。羚角钩藤汤全方是通过止痉、退热以及降低颅内压等多方面的综



合作用而达到治疗内热灼伤筋络的抽搐症状的。

方剂制备

羚羊角：一般用0.5~3g，用水冲服，粉剂。若无可用山羊角代替，按30：1的量。钩藤：后下。或者先将羚羊角与竹茹一起加水约1200毫升，煎煮约半小时左右，去掉药渣后加入其他药材一起煎成400毫升左右的药液，分两次温服，一天根据病情轻重可以服用2~4次。如病人昏迷无法吞咽，可下鼻饲管，但动作中应加倍小心，以免刺激引发抽搐。

使用注意

1. 若温病后期，热势已衰，阴液大亏，虚风内动者，不宜应用。

2. 羚角钩藤汤是治疗实风证的代表方剂，但是对于实风证的治疗不能单纯依赖本方，必须立足于驱除肝风内动的原因，根据邪热亢盛的不同性质确立不同的应对方式，其中有阳明热盛、阳明腑实、血分热盛等，应谨慎辨证，凉肝熄风的同时与宣泄气分邪热、攻下热结、清热凉血等方法配合应用，才能取得良好的治疗效果。

3. 肝热动风是一种极为危重的病症，必须及时处理以制止惊厥，否则可能因惊厥持续不止导致正气外脱而死亡，也容易引起瘫痪、痴呆、失明等严重后果。

临症加减

1. 如果患者抽搐不止，可加入全蝎、蜈蚣、地龙等强力止痉。

2. 本症属于危重急症，治疗中可配合针灸、物理降温等方式尽快解痉，因本病发作中经常伴有神志昏迷，所以运用中经常配合至宝丹、紫雪丹、安宫牛黄丸等中成药，化入药液配合使用，以加快苏醒神志以及加强凉肝熄风的作用。

典型案例

姜某，男，5岁。患乙型脑炎。高热昏迷，喉间痰鸣，手足痉挛，项背强直，两目上窜，牙关紧闭，指纹青紫，脉象滑数。诊断为热极生风，痰蒙清窍，治宜清热熄风，涤痰开窍。处方：水牛角15g刨片，先煎。双钩藤6g，明天麻3g，川贝母3g，云茯苓6g，水竹茹6g，金银花6g，净连翘3g，西瓜翠衣30g，安宫牛黄散1支兑服，蛇胆陈皮末1支兑服。

病名

神经性呕吐、高血压
头痛

中医病名

厥阴虚寒证

症状

厥阴虚寒。主要表现为食谷欲呕，畏寒喜热，或胃脘痛，吞酸嘈杂；或厥阴头痛，干呕吐涎沫；或少阴吐利，手足逆冷，烦躁欲死。本方是治疗肝胃虚寒，浊阴上逆的常用方。临床应用以食后欲吐，或巅顶头痛，干呕吐涎沫，畏寒肢凉，舌淡苔白滑，脉弦细而迟为辨证要点。

厥阴肝经阳气被伤或阳气不足而生虚寒之证。虚寒犯于胃则胃气不平而上逆，证见呕吐或干呕。寒气延厥阴肝经走行上攻于头顶，则发作为巅顶疼痛，既厥阴头痛。由于胃内已染虚寒，故胃脘冷痛，呕吐涎沫，也表现出吞酸嘈杂等症状。寒气内阻，气机不畅可能导致胸膈满闷。胃寒则易腹泻，口淡而不渴，舌淡苔白滑。而手足不温多缘于肝胃虚寒较甚。本症的症状程度往往有在午夜加剧，随天明日出而渐渐缓解的特点，可以在临床诊断时作为参考。

在太阴、少阴、厥阴等阴经寒证

中，均可能出现呕吐，在诊断辨证时，主要是按体阳虚寒、心肾虚寒、肝胃虚寒的不同兼见症状作为鉴别手段，比如厥阴寒证的呕吐就往往便随着泛呕吐涎沫或口中渗出清水、头疼等症状。临床上也有偏头痛、颅内炎症或占位性病变等疾病表现为呕吐干呕与头痛同时出现。由此可见，厥阴虚寒证虽然在外感病中也有出现，但更加比较多见于内伤杂病中，尤其以消化系统、神经系统的疾病为多。

【用方】

吴茱萸汤

——《伤寒论》

方剂说明

温中补虚，降逆止呕。

适用于慢性胃炎、妊娠呕吐、神经性呕吐、神经性头痛、耳源性眩晕等属厥阴虚寒者。

组成

吴茱萸9g，人参9g，大枣4枚，生姜18g。

歌曰：吴茱萸汤人参枣，重用生姜温胃好，阳明寒呕少阴利，厥阴头痛皆能保。



配伍说明

本方证乃肝胃虚寒，浊阴上逆所致。肝胃虚寒，胃失和降，浊阴上逆，故食后泛泛欲吐，或呕吐酸水，或干呕，或吐清涎冷沫；厥阴之脉夹胃属肝，上行与督脉会于头顶，胃中浊阴循肝经上扰于头，故巅顶头痛；浊阴阻滞，气机不利，故胸满脘痛；肝胃虚寒，阳虚失温，故畏寒肢冷；脾胃同居中焦，胃病及脾，脾不升清，则大便泄泻；舌淡苔白滑，脉沉弦而迟等均为虚寒之象。治宜温中补虚，降逆止呕。方中吴茱萸味辛苦而性热，归肝、脾、胃、肾经。既能温胃暖肝以祛寒，又善和胃降逆以止呕，一药而两擅其功，是为君药。重用生姜温胃散寒，降逆止呕，用为臣药。吴茱萸与生姜相配，温降之力甚强。人参甘温，益气健脾，为佐药。大枣甘平，合人参以益脾气，合生姜以调脾胃，并能调和诸药，是佐使之药。四药配伍，温中与降逆并施，寓补益于温降之中，共奏温中补虚，降逆止呕之功。本方证治有阳明、厥阴、少阴之别，但其见证均有呕吐，与胃中虚寒，浊阴上逆有关。

根据现代药理研究结果，吴茱萸汤中吴茱萸的成分具有缓解平滑肌痉挛的效果，对止呕、镇痛以及控制过高的血压、抑制细菌活性、增加消化液的分泌等均有效果。人参则可以兴奋神经系统

以及垂体-肾上腺皮质系统的活动，生姜除了有镇痛的功效外也能促进血液循环，大枣在温润的同时也很有营养，是对虚弱体质的一种补益。本方构成及作用都很复杂，适合于很多疾病。

方剂制备

全方四味药用水约1400毫升，煎煮至药液剩余400毫升左右后，滤去药渣，分3份温服，每日2~3次。

使用注意

1. 本方主治阳气衰微，阴寒内盛，甚至阴盛格阳或戴阳证。症见四肢厥逆，精神萎靡，恶寒踡卧，下利清谷，甚则大汗淋漓，脉微细或脉微欲绝等。

2. 本方内含辛热之品，如辨证不明使用不当可能发生过热伤阴之弊。比如肝阳上亢或胃热旺盛等原因导致的头晕头痛、恶心呕吐、脘腹疼痛等症状就均不可投用。另外本方服用后，有可能出现短暂的胃脘部不适症状或眩晕短暂加重，正常可以稍事休息而得到缓解。

临症加减

1. 阳虚较重，表现寒象显著的患者，可加炮附子、高良姜或干姜。

2. 患者手足麻木或酸痛不舒，可加桂枝。

3. 呕吐严重的，可加姜半夏、砂仁、代赭石等。

4. 厥阴头痛剧烈的，可加川芎、葛根、全蝎。

5. 患者胃中嘈杂不宁，上逆吞酸，可加乌贼骨、萆拔、煅瓦楞子等药物。

6. 胃寒型的慢性胃炎，十二指肠溃疡等疾病时，可以适当添加高良姜、丁香、白豆蔻、白胡椒等药物。

典型案例

姜某，女，40岁。一个多月来食后即呕，有时所食之物全部呕出，饮水亦呕，四肢倦怠，脉虚细，舌淡白，手足冷，口中觉冷而不渴，腹软。《伤寒论》云：“食谷欲呕者，属阳明也”，此系胃气虚寒，不能腐熟水谷，又兼浊阴上逆。处方：吴茱萸9g，人参9g，大枣4枚，生姜18g，丁香6g，水煎服。

病名

各种疼痛、肋软骨炎、
肋间神经痛

中医病名

气滞血瘀证

症状

胸中血瘀证。主要表现为胸痛，头痛日久，痛如针刺而有定处，或呃逆日久不止，或内热烦闷，或心悸失眠，急躁

易怒，入暮潮热，唇暗或两目暗黑，舌暗红或有瘀斑，脉涩或弦紧。本方广泛用于因胸中瘀血而引起的多种病证。临床应用以胸痛，头痛，痛有定处，舌暗红或有瘀斑，脉涩或弦紧为辨证要点。

本症瘀血的部位虽然有多种，但以胸胁为多见，这与气滞的发生多由肝气不能舒畅，而肝经又循行经过胸胁处有关。气机郁滞于胸胁则导致胸胁疼痛、胀满，又因为有瘀血内停，所以其疼痛有定处，日久难愈。但瘀血不在胸胁时，也可以表现为其他部位的疼痛。因肝气郁结不舒，所以病人多性情急躁而易怒，时时嗳气或叹息，如果肝气上逆而犯胃，可见呃逆、干呕。瘀血日久则生热，所以久病患者多伴随有一些热性症状，如自觉手足心或心胸发热、烦闷等。瘀血内阻再加上瘀热内生，可影响心神，出现心悸失眠的症状。本证中所出现的口干不欲饮、两目黯黑和舌质暗红、脉涩等症状也是瘀血内阻的表现。本症多由气滞引发，所以诊断时应注意询问有无恼怒或忧思等原因。当然也可能由外伤比如跌仆等原因引起，应当从临床的具体表现和病史来判断是否有瘀血存在。



【用方】 血府逐瘀汤

——《医林改错》

方剂说明

活血祛瘀，行气止痛。

适用于冠心病心绞痛、风湿性心脏病、胸部挫伤及肋软骨炎之胸痛，以及脑血栓形成、高血压病、高脂血症、血栓闭塞性脉管炎、神经官能症、脑震荡后遗症之头痛、头晕等属瘀阻气滞者。

组成

桃仁12g，红花9g，当归9g，生地9g，川芎5g，赤芍6g，牛膝9g，桔梗5g，柴胡3g，枳壳6g，甘草3g。

歌曰：血府当归生地桃，红花甘草壳赤芍，柴胡芎桔牛膝等，血化下行不作劳。

配伍说明

本方主治诸症皆为瘀血内阻胸部，气机郁滞所致。即王清任所称“胸中血府血瘀”之症。胸中为气之所宗，血之所聚，肝经循行之分野。血瘀胸中，气机阻滞，清阳郁遏不升，则胸痛、头痛日久不愈，痛如针刺，且有定处；胸中血瘀，影响及胃，胃气上逆，故呃逆干呕，甚则水入即呛；瘀久化热，则

内热瞀闷，入暮潮热；瘀热扰心，则心悸怔忡，失眠多梦；郁滞日久，肝失条达，故急躁易怒；至于唇、目、舌、脉所见，皆为瘀血征象。治宜活血化瘀，兼以行气止痛。方中桃仁破血行滞而润燥，红花活血祛瘀以止痛，共为君药。赤芍、川芎助君药活血祛瘀；牛膝活血通经，祛瘀止痛，引血下行，共为臣药。生地、当归养血益阴，清热活血；桔梗、枳壳，一升一降，宽胸行气；柴胡疏肝解郁，升达清阳，与桔梗、枳壳同用，尤善理气行滞，使气行则血行，以上均为佐药。桔梗并能载药上行，兼有使药之用；甘草调和诸药，亦为使药。全方配伍，特点有三：一为活血与行气相伍，既行血分瘀滞，又解气分郁结；二为祛瘀与养血同施，则活血而无耗血之虑，行气又无伤阴之弊；三为升降兼顾，既能升达清阳，又可降泄下行，使气血和调。合而用之，使血活瘀化气行，则诸症可愈，为治胸中血瘀证之良方。

根据现代药理研究结果显示，血府逐瘀汤方中的主要成分桃仁、红花、当归、赤芍、牛膝、川芎等均具有抗凝血、扩张血管、改善血液循环等功能。柴胡又可以镇静、镇痛。行气药与化瘀药同用，又起到一个良性互助，互相增强效果的协同作用。

方剂制备

上药加水约1400毫升，煎煮至剩余药汁250毫升左右，滤出药渣，药液直接温服，剩余药渣再加水约800毫升后煎取约250毫升，第二次温服。1日2次。

使用注意

1. 方中活血祛瘀药较多，故孕妇忌用。
2. 血府逐瘀汤虽然为去瘀止痛的良方，但耗伤气血，对气血不足者不应投用。非瘀血所致的各种疼痛病证也非本方所宜。

临症加减

1. 头面瘀阻的头痛昏晕，加麝香、葱白以温通经脉，活血通窍。
2. 膈下瘀血，形成积块，或小儿痞块，或肚腹疼痛，痛处不移者，加五灵脂活血祛瘀，行气止痛。
3. 妇女少腹淤积疼痛，经期少腹胀满，或瘀血阻滞久不受孕者，加小茴香、干姜、延胡索、蒲黄、五灵脂，活血祛瘀，温经止痛。
4. 气血闭阻经络所致的身痛，经久不愈者，用身痛逐瘀汤活血行气，祛瘀通络，通痹止痛。

典型案例

王某，男，11岁。发热15天，初步诊断：①双侧支气管淋巴结结核，左侧

已纤维化；②高热待查。曾给予链霉素、青霉素、对氨基水杨酸钠、异烟肼、氯霉素、金霉素等药物，并服中药青蒿鳖甲汤加味等养阴清热之剂。而患儿之高热持续月余之久，未见减退，最高体温达42℃，每日午后两度热势上升，至次早则稍降。虽然体温在40℃以上，而患者自觉并不发热。脉弦涩，舌色暗，面无热色，右胁下痛而不移，口不渴，大便自调，小便亦利。诊断为瘀血发热，处方：当归尾4.5g，赤芍药4.5g，干生地9g，川芎4.5g，净桃仁6g，西红花4.5g，川牛膝6g，炒枳壳4.5g，苦桔梗3g，生甘草3g，北柴胡4.5g，制没药4.5g，干地龙6g，水煎服。

病名

免疫功能低下、大病愈后

中医病名

表虚证

症状

表虚自汗。主要表现为汗出恶风，面色㿠白，舌淡苔薄白，脉浮虚。亦治虚人腠理不固，易于外感风邪。本方为治疗表虚自汗的常用方剂。临床以自汗恶风，面色㿠白，舌淡脉虚为辨证要点。



由于肌表固卫能力不足，不能控制毛孔的开闭，所以汗液自出。体力活动之后必然消耗能量，肌表更加失去固摄，汗出不可止。同时随着汗出在表的阳气也随之消耗，肌表失去温养，恶风怕冷。由于卫表之气虚衰不足，所以容易感受外邪而经常发生感冒。肺气不足不能充养全身，则面色萎黄无华并且倦怠乏力、气短懒言。表虚证的主要特征是自汗出，但并非所有自汗症状都可以归为表虚范围。比如表寒虚证也有自汗出这一典型症状，但在该证中是因为感受风寒之邪所导致，除自汗外，还兼有各种表证症状。又如阳明气热证中，由于邪热盛于阳明，而逼迫津液外溢，也有自汗出的症状，但同时必伴有各种里热证状。以上两症以及表虚证都有自汗出的症状，但是其他兼症各有不同，需要仔细鉴别。

【用方】 玉屏风散

——《医方类聚》

方剂说明

益气固表止汗。

常用于过敏性鼻炎、上呼吸道感染属表虚不固而外感风邪者，以及肾小球肾炎易于伤风感冒而诱致病情反复者。

组成

防风6g，黄芪、白术各12g。

歌曰：玉屏风散最有灵，芪术防风鼎足形。表虚汗多易感冒，药虽相畏效相成。

配伍说明

本方主治卫气虚弱，不能固表之证。卫虚腠理不密，则易为风邪所袭，故时自恶风而易于感冒；表虚失固，营阴不能内守，津液外泄，则常自汗；面色晄白，舌淡苔薄白，脉浮虚皆为气虚之象。治宜益气实卫，固表止汗。方中黄芪甘温，内可大补脾肺之气，外可固表止汗，为君药。白术健脾益气，助黄芪以加强益气固表之力，为臣药。两药合用，使气旺表实，则汗不外泄，外邪亦难内侵。佐以防风走表而散风御邪，黄芪得防风，则固表而不留邪；防风得黄芪，则祛风而不伤正。

根据现代药理研究结果显示，玉屏风散中的黄芪是一味对体液免疫系统及细胞免疫系统都有明显促进和调节作用的药物，能增强细胞的生命力和抵抗力。玉屏风散全方煎液对人体的免疫功能呈现出双向调节的能力，对免疫功能偏低者可以提高，对于免疫过敏者又可以降低。

方剂制备

研末，每日2次，每次6~9g，大枣煎汤送服；亦可作汤剂，水煎服，用量按原方比例酌减。

使用注意

1. 若属外感自汗或阴虚内热导致的失眠盗汗，均不宜使用。
2. 本方以补益为主，只可用于因表气虚而导致的自汗，如外邪尚盛，则不可轻易使用本方，以免助长邪势，导致邪恋难去。

临症加減

1. 汗出较多，甚至终日周身汗出不断者，可加浮小麦、糯稻根、五味子、牡蛎等收敛固表。
2. 气虚较重者，可加党参、茯苓、黄精等以助黄芪补气之力。
3. 表邪未解者，可加桂枝、白芍以解肌表风寒，调营卫之气。

典型案例

黄某，女，44岁。患者经常感冒，每月1~2次，动则气促易汗，神疲易倦，面色苍白，食欲欠佳，舌淡苔薄白，脉细弱。证属卫阳不固，腠理疏松，感受风寒，处方：黄芪15g，白术10g，防风、当归各8g，每周6剂，水煎服。

病名

慢性肠胃炎、慢性肝炎、
贫血、营养不良

中医病名

脾胃气虚证

症状

脾胃气虚证。主要表现为面色晄白，语音低微，气短乏力，食少便溏，舌淡苔白，脉虚弱（细缓）。本方为治疗脾胃气虚证的基础方，后世众多补脾益气方剂多从此方衍化而来。临床应用以面白食少，气短乏力，舌淡苔白，脉虚弱为辨证要点。

人体正气有充养全身、维持生命活动等重要作用，如发生亏虚，则面色苍白或萎黄，周身无力，倦怠萎靡，同时舌质淡。又因脾气不足不能正常消化饮食，所以见食欲不振并大便稀溏。肺气不足则少气而声音低微。气虚无力鼓动血脉，则可见脉细缓或稀软无力。气虚证和阳虚证都有人体功能活动衰退的表现，一般来说，阳虚证都会有气虚的一些症状，而气虚证的进一步发展也都会形成阳虚证。两者的主要区别在于：阳虚证由于阳气不足，必有虚寒内盛而出现畏寒、四肢不温、得暖则舒等寒象，而气虚证则没有明显的虚寒症状。



【用方】 四君子汤

——《太平惠民和剂局方》

方剂说明

益气健脾。

适用于慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡等属脾气虚者。

组成

人参、白术、茯苓各9g，炙甘草6g。

歌曰：四君补气基本方，食少无力大便溏，人参白术茯苓草，益气健脾功效强。

配伍说明

本方证由脾胃气虚，运化乏力所致。脾胃为后天之本，气血生化之源，脾胃气虚，受纳与健运乏力，则饮食减少；湿浊内生，故大便溏薄；脾主肌肉，脾胃气虚，四肢肌肉无所禀受，故四肢乏力；气血生化不足；血不足不荣于面，而见面色萎白；脾为肺之母，脾胃一虚，肺气先绝，故见气短、语音低微；舌淡苔白，脉虚弱皆为气虚之象。正如《医方考》所说：“夫面色萎白，则望之而知其气虚矣；言语轻微，则闻之而知其气虚矣；四肢无力，则问

之而知其气虚矣；脉来虚弱，则切之而知其气虚矣。”治宜补益脾胃之气，以复其运化受纳之功。方中人参为君，甘温益气，健脾养胃。臣以苦温之白术，健脾燥湿，加强益气助运之力；佐以甘淡茯苓，健脾渗湿，苓、术相配，则健脾祛湿之功益著。使以炙甘草，益气和，调和诸药。四药配伍，共奏益气健脾之功。此方能使脾胃之气健旺，运化复常，资生气血，故为补气的基本方。参、术、草均为甘温壅滞之品，有碍于脾胃气机，得茯苓之淡渗利窍，则补中有利，补而不滞。本症为脾胃气虚，纳谷与运化乏力所致。脾胃为后天之本，气血生化之源。脾胃虚弱，则气血生化不足，故面色晄白，语音低微，气短乏力。脾失健运，胃纳不振，湿浊内生，故饮食减少；清阳不升，浊阴不降，停滞于中脘，则引起胃气上逆发为呕吐，又因清阳不升，则浊阴不降，清浊相干，水谷不分，故大便溏薄。舌淡，苔薄白，脉虚弱，均为中焦脾胃气虚之象。本方与理中丸比较，两方均用人参、白术、炙甘草以补益中气，仅一药之别，而功能相异。四君子汤配茯苓，功用以益气健脾为主，主治脾胃气虚证；理中丸用干姜，功用以温中祛寒为主，适用于中焦虚寒证。

根据现代药理研究结果显示，四君子汤可以增加肝糖元的合成，增强胸腺素活性。提高体内免疫和细胞免疫功能。



能。又可以调整胃肠道功能，促进骨髓的造血功能，特别是可以加速红细胞的生成，所以在失血性疾病中经常配合使用本方以加强补血作用。此外，本方可通过调节神经系统、心脏和内分泌而促进血压上升，有助纠正休克。方中使用人参可增加红细胞、血红蛋白、白细胞数量，促进新陈代谢，增强神经系统和肾上腺皮质功能，并有强心、降血糖、抗过敏等多种联合作用。白术可以保护肝脏，防止肝糖元减少，并可利尿。茯苓白术配合使用，除了可以利水外，还与人参一样具有促进人体免疫系统功能的作用。甘草的类肾上腺皮质激素作用，能解毒、解痉，保护消化道粘膜。

方剂制备

取药粉6g，用水约800毫升煎服。

使用注意

本方药性平和，副作用很少，故称为“四君子汤”。但毕竟以补益为主，很少驱逐病邪的作用，所以对正气虚与病邪共存的患者，需要配合其他方剂使用，不宜单用。

临症加减

1. 异功散：四君子汤加陈皮9g，功用：益气健脾，行气化滞。

2. 六君子汤：四君子汤加陈皮3g、半夏4.5g，功用：益气健脾，燥湿化痰。

3. 香砂六君子汤：人参3g，白术6g，茯苓6g，甘草2g，陈皮2.5g，半夏3g，砂仁2.5g，木香2g，生姜6g，功用：益气化痰，行气温中。

4. 保元汤：黄芪9g，人参3g，炙甘草3g，肉桂1.5g，生姜一片，功用：益气温阳。

5. 加减四君子汤：白扁豆、藿香叶、炙甘草、黄芪各一两，人参、茯苓、白术各四两，功用：益气补中，健脾化湿。

6. 白术散：四君子汤加藿香叶15g，木香6g，葛根15g，功用：益气补中，和胃生津。

7. 另外还有补气运脾汤、健固汤、固真汤、腹伤二方。详见《医方发挥》

典型案例

王某，男，31岁。自幼体虚多病，近半年来食欲不振，偶有大便溏薄，日行二至三次，周身无力，常感头晕心悸，活动后尤其自汗严重，注意力不易集中，口淡不渴，舌苔白舌质淡，脉细软无力。诊断为气虚证，处方：人参9g，白术9g，茯苓9g，炙甘草6g，藿香叶15g，木香6g，葛根15g，水煎服。

**病名**

慢性肠炎、肠道功能紊乱、脏器下垂、流产

中医病名

中气下陷证

症状

1. 脾胃气虚证。主要表现为食少便溏，体倦肢软，少气懒言，面色晄白，脉大而虚软。2. 气虚下陷证。脱肛，子宫脱垂，久泻，久痢，崩漏等，气短乏力，舌淡脉虚者。3. 气虚发热证。身热，自汗，渴喜热饮，气短乏力，舌淡，脉虚大无力。本方为补气升阳，甘温除热的代表方。临床应用以体倦乏力，少气懒言，面色萎黄，脉虚软无力为辨证要点。

由于脾胃气虚，中气下陷，升举无力，所以胃脘或腹部觉下坠，胀满不舒，并有肛门或其他脏器下垂或者外脱的症状，因全身精气衰退，机能不能正常运行，表现为气短乏力，少气懒言。又因人体精阳之气无力上升，所以也可见头晕目眩，但一般以头昏沉重为主，与肝肾阴虚所导致的头晕而觉旋转不停者有区别。

【用方】

补中益气汤

——《内外伤辨惑论》

方剂说明

补中益气，升阳举陷。

适用于内脏下垂、久泻、久痢、脱肛、重症肌无力、乳糜尿、慢性肝炎等；妇科之子宫脱垂、妊娠及产后瘕闭、胎动不安、月经过多；眼科之眼睑下垂、麻痹性斜视等属脾胃气虚或中气下陷者。

组成

黄芪18g，炙甘草9g，人参6g，当归3g，橘皮6g，升麻6g，柴胡6g，白术9g。

歌曰：补中益气芪术陈，升柴参草当归身。

配伍说明

本方治证系因饮食劳倦，损伤脾胃，以致脾胃气虚、清阳下陷所致。脾胃为营卫气血生化之源，脾胃气虚，纳运乏力，故饮食减少、少气懒言、大便稀薄；脾主升清，脾虚则清阳不升，中气下陷，故见脱肛、子宫下垂等；清阳陷于下焦，郁遏不达则发热，因非实火，故其热不甚，病程较长。时发时止、手心热甚于手背，与外感发热之热



甚不休、手背热甚于手心者不同。气虚腠理不固，阴液外泄则自汗。治宜补益脾胃中气，升阳举陷。方中重用黄芪，味甘微温，入脾、肺经，补中益气，升阳固表，为君药。配伍人参、炙甘草、白术补气健脾为臣，与黄芪合用，以增强其补益中气之功。血为气之母，气虚时久，营血亦亏，故用当归养血和营，协人参、黄芪以补气养血；陈皮理气和胃，使诸药补而不滞，共为佐药。并以少量升麻、柴胡升阳举陷，协助君药以升提下陷之中气，《本草纲目》谓：“升麻引阳明清气上升，柴胡引少阳清气上行，此乃禀赋虚弱，元气虚馁，及劳役饥饱，生冷内伤，脾胃引经最要药也”，共为使药。炙甘草调和诸药，亦为使药。全方配伍大意有二：一是补气健脾以治气虚之本；一是升阳举陷，以求清升浊降，于是脾胃和调，水谷精微生化有源，脾胃气虚诸证即可自愈。

关于用本方治疗气虚发热的理论依据，李东垣说：“是热也，非表伤寒邪皮毛间发热也，乃肾间脾胃下流之湿气闷塞其下，致阴火上冲，作蒸蒸燥热。”又说：“既脾胃虚衰，元气不足，而心火独盛。心火者，阴火也，起于下焦，其系系于心，心不主令，相火代之；相火，下焦包络之火，元气之贼也。火与元气不两立，一胜则一负。”

（《内外伤辨惑论》卷中）可见这种发热在李东垣看来，就是“阴火”。其

实质主要是脾胃元气虚馁，升降失常，清阳下陷，脾湿下流，下焦阳气郁而生热上冲，加之化源不足，“中焦取汁”不足以化赤生血，则心血不足以养心而致心火独亢而出现的热象。治疗这种发热，“惟当以甘温之剂，补其中，升其阳，甘寒以泻其火则愈。”“盖温能除大热，大忌苦寒之药泻胃土耳，今立补中益气汤。”（《内外伤辨惑论》）综上李氏创立“温能除大热”的理论，对区别外感与内伤发热的辨证、病机、治则、治法以及使用的宜忌等均有阐发，对深入理解本方意义和指导临床运用均有裨益。

现代药理研究结果显示，补中益气汤对子宫等内脏有兴奋作用，升麻、柴胡在方中有明显的协同作用，全方可以改善全身状态，还可以减轻放射线或其他化学、物理药物对人身体的损害，增强免疫功能。实验又表明，本方对肠道有双向调节作用，当肠道蠕动过于亢进时，可以缓解平滑肌的兴奋，当肠道蠕动不足时，又可以刺激平滑肌提升张力。方中黄芪有类似性激素及刺激兴奋中枢神经系统的作用，与人参相配合，有较显著强壮和调整人体脏器功能的作用。当归能改善人体内的血液循环环境，有助于脏器功能的保护和恢复。



方剂制备

水煎服。或作丸剂，每服10~15g，1日2~3次，温开水或姜汤下。

使用注意

由于本方性质温而上升，所以属虚火上炎而导致的面赤、口苦、眩晕、口咽干燥及气机上逆所致的恶心呕吐、胃脘胀满等症，均不宜使用本方。阴虚发热及内热炽盛者忌用。

临症加减

1. 升陷汤：生黄芪18g，知母9g，柴胡4.5g，桔梗4.5g，升麻3g，功用：益气升陷。主治：大气下陷证。

2. 升阳益胃汤：黄芪30g，半夏、人参、炙甘草各15g，独活、防风、白芍、羌活各9g，橘皮6g，茯苓、柴胡、泽泻、白术各5g，黄连1.5g，生姜五片，大枣二枚，功用：益气升阳，清热除湿。主治：脾胃虚弱，湿热滞留中焦。

3. 中气虚清阳不升导致头痛者，可加白芍、细辛、川芎、蔓荆子等。

4. 如气虚下陷基础上发生形寒肢冷等阳虚症状，可酌情加肉桂、附子、干姜等。

5. 如腹泻不止或汗出不止，可酌情加乌梅、五倍子、诃子等。

6. 胃下垂，可加郁金、茯苓、枳壳、山楂、鸡内金、山药、大枣等健脾

益气、帮助运化。

7. 产后小便不通者，可加茯苓、冬葵子等。

8. 小儿秋季腹泻，兼夹食积者，可加神曲、山楂。

9. 泻下不畅，大便粘液者，可加木香、川连。

10. 热而伤阴者，可加胡黄连、白芍。

11. 肛门直肠脱垂者，可加御米壳、诃子、儿茶等。

典型案例

陈某，男，32岁。患头痛数月，苦不可忍，曾经使用散风清火之剂，仍未治愈。脉浮虚不鼓，语言懒怯，肢体恶寒。诊断劳倦伤中，清阳之气不升，浊阴之气下降，故用药汗之反虚其表，清之益伤其中，恶寒是气虚、不能上容而外固的表现，处方：黄芪18g，炙甘草9g，人参6g，当归3g，橘皮6g，升麻6g，柴胡6g，白术9g，蔓荆子9g，水煎服。

病名

贫血、神经衰弱、营养不良

中医病名

气血两虚证

症状

1. 心脾气血两虚证。主要表现为心悸怔忡，健忘失眠，盗汗虚热，体倦食少，面色萎黄，舌淡，苔薄白，脉细弱。2. 脾不统血证。主要表现为便血，皮下紫癜，妇女崩漏，月经超前，量多色淡，或淋漓不止，舌淡，脉细者。本方是治疗心脾气血两虚证的常用方。临床应用以心悸失眠，体倦食少，便血或崩漏，舌淡，脉细弱为辨证要点。

本证是气虚症状与血虚症状并见，在临床上的表现以脏腑机能衰退和脏腑组织失于濡养为主，尤以心脾两脏的病变更为多见，这是由于这两脏与气血的生成及运行关系特别密切。由于气虚，所以倦怠乏力，少气懒言。气虚不能固表，可出现自汗。头面失于血液阳气的滋养，故头晕、视物昏花、面色或苍白或萎黄，没有红润之色。舌色唇色均淡而不红。血不能养心，则心悸失眠、记忆不集中、健忘。气血不足，不能充盈脉道，推动血行，所以脉多细弱。气血

两虚证多与心脾有关，所以有时也称为心脾两虚证，这与气阴两虚证主要是心肺亏损有所不同。

【用方】

归脾汤——《正体类要》

方剂说明

益气补血，健脾养心。

适用于胃及十二指肠溃疡出血、功能性子宫出血、再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜、神经衰弱、心脏病等属心脾气血两虚及脾不统血者。

组成

白术9g，茯神9g，黄芪12g，龙眼肉12g，酸枣仁12g，人参6g，木香6g，炙甘草3g，当归9g，远志6g。

歌曰：归脾参芪术草姜，当归龙眼枣木香，茯神远志酸枣仁，益气补血心脾强。

配伍说明

本方证因思虑过度，劳伤心脾，气血亏虚所致。心藏神而主血，脾主思而统血，思虑过度，面色萎黄，脾气亏虚则体倦、食少；心血不足则见惊悸、怔忡、健忘、不寐、盗汗；面色萎黄、舌质淡，苔薄白，脉细缓均属气血不足之象。上述诸症虽属心脾两虚，却是以



脾虚为核心，气血亏虚为基础。脾为营卫气血生化之源，《灵枢·决气》曰：“中焦受气取汁，变化而赤是为血”，故方中以参、芪、术、草大队甘温之品补脾益气以生血，使气血旺而血生；当归、龙眼肉甘温补血养心；茯苓（多用茯神）、酸枣仁、远志宁心安神；木香辛香而散，理气醒脾，与大量益气健脾药配伍、调和脾胃，以资化源。全方共奏益气补血，健脾养心之功，为治疗思虑过度，劳伤心脾，气血两虚之良方。本方的配伍特点：一是心脾同治，重点在脾，使脾旺则气血生化有源，方名归脾，意在于此；二是气血并补，但重在补气，意即气为血之帅，气旺则自生，血足则心有所养；三是补气养血药中佐以木香理气醒脾，补而不滞。故张璐说：“此方滋养心脾，鼓动少火，妙以木香调畅诸气。世以木香性燥不用，服之多致痞闷，或泄泻，减食者，以其纯阴无阳，不能输化药力故耳。”（《古今名医方论》）本方原载宋·严用和《济生方》，但方中无当归、远志，至明·薛己补此二味，使养血宁神之效尤彰。本方的适应范围，随着后世医家的临床实践，不断有所扩充，原治思虑过度、劳伤心脾之健忘、怔忡。元·危亦林在《世医得效方》中增加治疗脾不统血之吐血、下血。明·薛己《内科摘要》增补了治疗惊悸、盗汗、嗜卧少食、月经不调、赤白带下等症。归脾

汤与补中益气汤同用参、芪、术、草以益气补脾。前者以补气药配伍养心安神药，意在心脾双补，复二脏生血、统血之职，主治心脾气血两虚之心悸怔忡、健忘失眠、体倦食少，以及脾不统血之便血、崩漏等。后者是补气药配伍升阳举陷药，意在补气升提，复脾胃升清降浊之能，主治脾胃气虚、气陷之少气懒言、发热及脏器下垂等。

根据现代药理研究结果显示，归脾汤可以升高血糖，抗烫伤性休克，升高血红蛋白含量，改善凝血功能，与方中的人参、当归、黄芪等药物具有的强壮、兴奋神经系统和内分泌功能的复杂药理作用有关。

方剂制备

上药制成粗末，每次取12g，加水约500毫升，生姜5片，大枣1枚，煎取300毫升药液，去药渣后分次温服，不拘时间。也可按上方比例制成蜜丸，每丸约重15g，1次1丸，空腹服用，1日3次。

使用注意

1. 本方虽然药性平和，但是伴有中气下陷、病邪未尽的患者不宜使用。
2. 如病人脾胃功能不好，食少便溏者，使用本方时应格外谨慎，以免过于滋腻有碍脾胃功能。

临症加减

1. 血虚严重者，加熟地、枸杞子等。
2. 下血过多者，可加阿胶珠、血余炭、藕节炭等。
3. 更年期患者，可加龙骨、牡蛎等。
4. 有虚热而见面赤，五心烦躁者，可加地骨皮、丹皮等。
5. 有水肿者，可加茯苓、泽泻等。

典型案例

孙某，男，39岁。平素工作繁忙，近1年来疲劳感明显，全身酸困不适，睡眠差，记忆力下降，偶发头痛，已行脑CT、心电图、胸片、血常规和血生化等多种检查未见异常。诊见患者神色疲惫，体倦乏力，舌淡胖，苔薄白，脉沉细弦。证属心脾两虚，气血不足。治予健脾养心，益气补血。处方：白术9g，茯神9g，黄芪12g，龙眼肉12g，酸枣仁12g，人参6g，木香6g，炙甘草3g，当归9g，远志6g，加木瓜15g，川芎12g，每日1剂，水煎服。

病名

贫血、大病初愈

中医病名

血虚证

症状

营血虚滞证。主要表现为心悸失眠，头晕目眩，面色无华，妇人月经不调，量少或经闭不行，脐腹作痛，舌淡，脉细弦或细涩。本方是补血调经的基础方。临床应用以面色无华，唇甲色淡，舌淡，脉细为辨证要点。

血液主要功能是滋养脏腑及形体，血虚必然导致内脏功能的减弱，尤其是对心肝两脏的影响最大。因血液不能上养头目，所以见面色萎黄，唇色苍白，头晕目眩，舌质色淡不红。心血不足，心神不能内守，所以心悸失眠，或者表现为健忘。血液不足，月经之源亏虚，则有月经量少、不规则、甚至经闭。因血虚不能化生为乳汁，所以产后乳少或无乳。血液亏损不能充盈脉管，则脉象细弱。



【用 方】

四物汤

——《仙授理伤续断秘方》

方剂说明

补血和血。

适用于妇女月经不调、胎产疾病、荨麻疹以及过敏性紫癜等属营血虚滞者。

组 成

熟地12g，当归9g，白芍9g，川芎6g。

歌曰：四物补血基本方，营血虚滞急煎尝，熟地当归白芍芎，补血调经功效强。

配伍说明

本方是补血调经的主方，是从《金匱要略》中的芎归胶艾汤减去阿胶、艾叶、甘草而成。本方治证由营血亏虚，血行不畅，冲任虚损所致。血虚与心、肝两脏关系最为密切。肝藏血，血虚则肝失所养，无以上荣，故头晕目眩；心主血，藏神，血虚则心神失养，故心悸失眠；营血亏虚，则面部、唇舌、爪甲等失于濡养，故色淡无华；冲为血海，任主胞胎，冲任虚损，肝血不足，加之血行不畅，则月经不调，可见月经

量少、色淡、或前或后，甚或经闭不行等症；血虚则血脉无以充盈，血行不畅易致血瘀，可见脐腹疼痛，甚或瘕块硬结；脉细涩或细弦为营血亏虚，血行不畅之象。治宜补养营血为主，辅以调畅血脉。方中熟地甘温味厚质润，入肝、肾经，长于滋养阴血，补肾填精，为补血要药，故为君药。当归甘辛温，归肝、心、脾经，为补血良药，兼具活血作用，且为养血调经要药，用为臣药。佐以白芍养血益阴；川芎活血行气。四药配伍，共奏补血调血之功。本方的配伍特点是以熟地、白芍阴柔补血之品（血中血药）与辛香之当归、川芎（血中气药）相配，动静相宜，补血而不滞血，行血而不伤血，温而不燥，滋而不腻，成为补血调血之良方。本方在《仙授理伤续断秘方》中治外伤瘀血作痛，宋代《太平惠民和剂局方》用于妇人诸疾。本方所使之药物可以分为两组，一是以补为主以治血虚，为地黄、芍药；一是以通为主以治血滞，为当归、川芎。而地黄可分为生、熟，芍药有赤、白，当归有身、尾。因此需依症之不同，而用不同药物，以取良效。

根据现代药理研究表明，四物汤可以改善血液循环，促进红细胞的形成，体外实验也证明，本方可以促进人体体液免疫和细胞免疫活性。这些研究结果提示，四物汤不仅可以改善贫血状态，也能调节人体的多种功能活动。

方剂制备

方中药为粗末，每9g用水约400毫升煎取200毫升药液，去渣空腹温服，1日3次。

使用注意

1. 本方组成的药物性质偏于滋腻酸涩，对于病邪尚盛或脾胃虚弱、消化不良的病人不宜投用。

2. 方中有通大便的药物，故不适用于大便稀溏者。

3. 对于阴虚发热，以及血崩气脱之症，亦非所宜。

临症加减

1. 妇女经期超前，血多有块，色紫粘稠，腹痛者，加桃仁9g，红花6g以养血活血。

2. 血虚而兼有下焦寒盛，小腹疼痛发冷，月经量少而色淡，经期推迟者，可加艾叶、阿胶。

3. 血瘀严重者，可加丹参、桂枝、乳香等。

4. 兼有气虚，不能固摄下焦以致月经先期、量多、色淡红者，可加人参、黄芪。

5. 兼有郁热者，可加黄芩、地骨皮、丹皮等，熟地改用生地。

6. 血虚动风导致的高血压，加菊花、白蒺藜等。

7. 伴发荨麻疹者，可加蝉衣、僵蚕、苦参、丹皮、栀子等。

典型案例

刘某，女，35岁。产后未经满月，因怒气后，血流如水，三日方止。随后劳动身体，则四肢无力，睡而汗出，日晡潮热，口干，五心如炙。脉弦大无力。诊断营血虚滞证。处方：熟地12g，当归9g，白芍9g，川芎6g，胡黄连3g，秦艽3g，青蒿3g，水煎服。

病名

关节炎、系统性红斑狼疮、痛风

中医病名

风湿正虚证

症状

痹证日久，肝肾两虚，气血不足证。主要表现为腰膝疼痛，肢节屈伸不利，或麻木不仁，畏寒喜温，心悸气短，舌淡苔白，脉细弱。本方为治疗久痹而致肝肾两虚，气血不足证之常用方。临床应用以腰膝冷痛，肢节屈伸不利，心悸气短，脉细弱为辨证要点。

本证一般发生于痹症反复发作或者迁延日久而未能治愈者，从原本的单纯



邪实之证转化为正虚邪实之证。由于气血消耗日久，不足以滋养人体，故可见肢体倦怠乏力，面色萎黄无华，肢体麻木，心悸气短等症状。又因肝肾主人体筋骨，肝肾亏虚则筋骨无源而失养，则腰脊不挺，屈伸不利。

【用 方】

独活寄生汤

——《备急千金要方》

方剂说明

祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。

用于慢性关节炎、类风湿性关节炎、风湿性坐骨神经痛、腰肌劳损、骨质增生症、小儿麻痹等属风寒湿痹日久，正气不足者。

组 成

独活9g，桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、桂心、防风、川芎人参、甘草、当归、芍药、地黄各6g。

歌曰：独活寄生芩防辛，芎归地芍桂苓均，杜仲牛膝人参草，冷风顽痹屈能伸。

配伍说明

本方为治疗久痹而肝肾两虚，气血不足之常用方。本症乃因感受风寒湿邪而患痹证，日久不愈，累及肝肾，耗

伤气血所致。风寒湿邪客于肢体关节，气血运行不畅，故见腰膝疼痛，久则关节屈伸不利，或麻木不仁，正如《素问·痹论》所言：“痹在于骨则重，在于脉则不仁。”肾主骨，肝主筋，邪客筋骨，日久必致损伤肝肾，耗伤气血。又腰为肾之府，膝为筋之府，肝肾不足，则见腰膝痿软；气血耗伤，故心悸气短。《素问·逆调论》云：“营气虚则不仁，卫气虚则不用，营卫俱虚则不仁且不用。”其证属正虚邪实，治宜扶正与祛邪兼顾，既应祛散风寒湿邪，又当补益肝肾气血。方中重用独活为君，辛苦微温，善治伏风，除久痹，且性善下行，以祛下焦与筋骨间的风寒湿邪。臣以细辛、防风、秦艽、桂心，细辛入少阴肾经，长于搜剔阴经之风寒湿邪，又除经络留湿；秦艽祛风湿，舒筋络而利关节；桂心温经散寒，通利血脉；防风祛一身之风而胜湿，君臣相伍，共祛风寒湿邪。本证因痹证日久而见肝肾两虚，气血不足，遂佐入桑寄生、杜仲、牛膝以补益肝肾而强壮筋骨，且桑寄生兼可祛风湿，牛膝尚能活血以通利肢节筋脉；当归、川芎、地黄、白芍养血和血，人参、茯苓、甘草健脾益气，以上诸药合用，具有补肝肾、益气血之功。且白芍与甘草相合，尚能柔肝缓急，以助舒筋。当归、川芎、牛膝、桂心活血，寓“治风先治血，血行风自灭”之意。甘草调和诸药，兼使药之用。纵观

全方，以祛风寒湿邪为主，辅以补肝肾、益气血之品，邪正兼顾，祛邪不伤正，扶正不留邪。

根据现代药理研究结果显示，独活寄生汤中的主要成分独活、秦艽、川芎、细辛、防风、杜仲等均具有抗炎、镇痛，强壮筋骨的作用。人参、茯苓、当归、地黄、白芍等则可以调节人体免疫系统功能、抗过敏反应、强壮身体、增加有效红细胞数量质量等作用。肉桂配合川芎、当归等药物使用、可以扩张血管、改善血液循环。这些药物互相配合，对于人体关节的各种慢性炎症及其导致的疼痛、肿胀等具有良好的临床效果。

方剂制备

上十五味药共研磨为粗末，用水约2000毫升，煮取约600毫升药液，滤去药渣，分3次温服。服药期间注意保暖，切勿受凉。

使用注意

本方中有补益气血、肝肾的药物，如果不是有明显正虚表现者，则不宜投用本方，不能作为治疗所有痹症的通用方剂。尤其痹证之属湿热实证者忌用。

临症加减

1. 气血不足较严重，全身软弱无力，形寒畏冷，自汗者，可加炙黄芪、枸杞子、白术等。

2. 肝肾亏虚较严重，腰膝酸软无力者，可加川断、狗脊、淫羊藿等。

3. 寒象较重，关节冷痛、四肢不温者，可加附子、干姜、巴戟天等。

4. 湿邪严重，关节活动不利如被裹，肌肤麻木者，可加苍术、防己、海桐皮等。

5. 疼痛严重者，可加制川乌、白花蛇、地龙等。

6. 夹痰瘀实邪者，可加乳香、桃仁、红花、白芥子等。

典型案例

黄某，女，35岁。患关节疼痛十余年，以双膝关节最为严重。面色萎黄无华，形寒肢冷，倦怠乏力，腰膝酸软，头晕耳鸣，食少口淡。查体舌苔白，舌质淡红，脉细弱。诊断为风湿正虚证。处方：独活9g，桑寄生6g，杜仲6g，牛膝6g，细辛6g，秦艽6g，茯苓6g，桂心6g，防风6g，川芎6g，人参6g，甘草6g，当归6g，芍药6g，地黄6g，川断6g，狗脊6g，白术6g，水煎服。

**病名**神经衰弱症、忧郁症、
更年期综合征**中医病名**

虚烦不眠证

症状

虚烦不眠证。主要表现为失眠心悸，虚烦不安，头目眩晕，咽干口燥，舌红，脉弦细。本方是治心肝血虚而致虚烦失眠之常用方。临床应用以虚烦失眠，咽干口燥，舌红，脉弦细为辨证要点。

【用方】**酸枣仁汤**

——《金匮要略》

方剂说明

养血安神，清热除烦。

适用于神经衰弱、心脏神经官能症、更年期综合征等属于心肝血虚，虚热内扰者。

组成

酸枣仁15~30g，茯苓6g，知母6~9g，川芎6g，甘草3g。

歌曰：酸枣二升先煮汤，获知二两用之良，芎二甘一相调剂，服后安然入梦乡。

配伍说明

本方证皆由肝血不足，虚热内扰而致。肝藏血，血舍魂；心藏神，血养心。肝血不足，则魂不守舍；心失所养，加之阴虚生内热，虚热内扰，故虚烦失眠、心悸不安。血虚无以荣润于上，每多伴见头目眩晕、咽干口燥。舌红，脉弦细乃血虚肝旺之征。治宜养血以安神，清热以除烦。方中重用酸枣仁为君，以其甘酸质润，入心、肝之经，养血补肝，宁心安神。茯苓宁心安神；知母苦寒质润，滋阴润燥，清热除烦，共为臣药。与君药相伍，以助安神除烦之功。佐以川芎之辛散，调肝血而疏肝气，与大量之酸枣仁相伍，辛散与酸收并用，补血与行血结合，具有养血调肝之妙。甘草和中缓急，调和诸药为使。诸药相伍，标本兼治，养中兼清，补中有行，共奏养血安神、清热除烦之效。

本方与天王补心丹均以滋阴补血，养心安神药物为主，配伍清虚热之品组方，以治阴血不足，虚热内扰之虚烦失眠。前者重用酸枣仁养血安神，配伍调气行血之川芎，有养血调肝之妙，主治肝血不足之虚烦失眠伴头目眩晕、脉弦细等；后者重用生地黄，并与二冬、玄参等滋阴清热为伍，



更与大队养血安神之品相配，主治心肾阴亏血少，虚火内扰之虚烦失眠伴手足心热、舌红少苔、脉细数者。

方剂制备

水煎，分3次温服。

临症加减

1. 如神志症状严重，可重用酸枣仁。
2. 如虚热较甚，可去川芎，加生地、白芍、川连。
3. 如心悸多梦，可加茯神、青龙齿、磁石等。

典型案例

陈某，男，36岁。失眠心悸一年以上，虚烦不安，头目眩晕，平素易怒，咽干口燥，舌红，脉弦细。诊断为肝血不足，虚热内扰证，处方：酸枣仁15~30g，茯苓6g，知母6~9g，川芎6g，甘草3g，水煎服。



附录

古方药量考证

古方用药分量，尤其是唐代以前的方，从数字看，和现在相差很大，这是因为古代度量衡制度在各个历史时期不同所致。古称以黍、铢、两、斤计量，而无分名。到了晋代，则以十黍为一铢、六铢为一分、四分为一两、十六两为一斤（即以铢、分、两、斤计量）。

及至宋代，遂立两、钱、分、厘、毫之目，即十毫为一厘、十厘为一分、十分为一钱，十钱为一两，以十累计，积十六两为一斤。元、明以至清代，沿用宋制，很少变易，故宋、明、清之方，凡言分者，是分厘之分，不同于晋代二钱半为一分之分。清代之称量称为库平，后来通用市称。

古方容量，有斛、斗、升、合、勺之名，但其大小，历代亦多变易，考证亦有差异，例如李时珍认为“古之一两，今用一钱，古之一升，即今之二两半”。同时，明人张景岳认为“古之一两，为今之六钱，古之一升，为今之三合三勺”。

至于古方有云“等分”者，非重量之分，是指各药斤两多少皆相等，大都用于丸、散剂，在汤、酒剂中较少应用。古代有刀圭、方寸匕、钱匕、一字等名称，大多用于散药。所谓方寸匕者，作匕正方一寸，抄散取不落为度；钱匕者，是以汉五铢钱抄取药末，亦以不落为度；半钱匕者，则





为抄取一半；一字者，即以开元通宝钱币（币上有“开元通宝”四字）抄取药末，填去一字之量；至于刀圭者，乃十分方寸匕之一。其中一方寸匕药散约合五分，一钱匕药散约合三分，一字药散约合一分（草本药散要轻些）。另外，有以类比法作药用量的，如：一鸡子黄=一弹丸=40桐子=80粒大豆=480粒大麻子=1440粒小麻子。

古今医家对古代方剂用量，虽曾作了很多考证，但至今仍未作出结论。但汉代和晋代的衡量肯定比现在为小，所以汉晋时代医方的剂量数字都较大。对古方仍录其原来的用量，主要是作为理解古方的配伍意义、结构特点、变化原因，以及临证用药配伍比例的参考。在临床应用时，应当按近代中药学和参考近代各家医案所用剂量，并随地区、年龄、体质、气候及病情需要而定。

根据我国国务院的指示，从1979年1月1日起，全国中医处方用药的计量单位一律采用以“g”为单位的国家标准。兹附十六进制与国家标准计量单位换算率如下：

1斤（16两）=0.5kg=500g



深奥难懂中医药教材的全面解读

中医入门系列



中医入门系列图书是献给中医爱好者的基础著作，医生、病人皆宜。在中医理论“整体观念”“辨证论治”的指导下，中医从古到今蓬勃发展，造福国人，但其医理博大精深却也生涩难懂，让很多想学习中医的人望而却步。有鉴于上述情况，我们特意组织编写了此系列图书。聘请有多年教学及临床经验的专家，把深奥的中医理论浅显化、大众化，使其通俗易懂，并将中医学的生理、病理、药理、诊法、辨证、组方、治法、内科、外科等融合在其中。书中介绍的方药和治法都来自传统教材及临床一线，切合实际又安全有效，可用于指导治疗。



团购优惠热线 0431-85619083